

**PSICANÁLISE PARA SIGMUND FREUD
E MELANIE KLEIN**

BRASÍLIA-DF.

Elaboração

Fabíola Maria de Carvalho Izaias

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	5
ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISA	6
INTRODUÇÃO.....	8
UNIDADE I	
OS CAMINHOS FREUDIANOS E O INÍCIO DA PSICANÁLISE	11
CAPÍTULO 1	
A GESTAÇÃO DA PSICANÁLISE.....	11
CAPÍTULO 2	
E HAVIA A SEXUALIDADE	19
CAPÍTULO 3	
A PSICANÁLISE CHEGA AO MUNDO	23
UNIDADE II	
A PSICANÁLISE DE FREUD E SEUS CONCEITOS BÁSICOS.....	29
CAPÍTULO 1	
A METAPSICOLOGIA FREUDIANA.....	29
CAPÍTULO 2	
O QUE NOS IMPULSIONA – O INSTINTO E SEUS CAMINHOS.....	36
CAPÍTULO 3	
REALIDADE PSÍQUICA: O MUNDO PELO OLHAR DA FANTASIA	42
UNIDADE III	
OS CAMINHOS DE KLEIN E O SURGIMENTO DA ANÁLISE LÚDICA.....	52
CAPÍTULO 1	
KLEIN E SEU ENCONTRO COM A TEORIA PSICANALÍTICA	52
CAPÍTULO 2	
O SETTING KLEINIANO	64
UNIDADE IV	
CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA SE ENTENDER O PENSAMENTO KLEINIANO	77
CAPÍTULO 1	
O MUNDO INTERNO: UM COLORIDO DE FANTASIAS E DE OBJETOS	77

CAPÍTULO 2
A POSIÇÃO ESQUIZOPARANOIDE..... 85

CAPÍTULO 3
A POSIÇÃO DEPRESSIVA 93

REFERÊNCIAS 100

Apresentação

Caro aluno

A proposta editorial deste Caderno de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se entendem necessários para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. Caracteriza-se pela atualidade, dinâmica e pertinência de seu conteúdo, bem como pela interatividade e modernidade de sua estrutura formal, adequadas à metodologia da Educação a Distância – EaD.

Pretende-se, com este material, levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade dos conhecimentos a serem oferecidos, possibilitando-lhe ampliar conceitos específicos da área e atuar de forma competente e conscienciosa, como convém ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios que a evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo.

Elaborou-se a presente publicação com a intenção de torná-la subsídio valioso, de modo a facilitar sua caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na profissional. Utilize-a como instrumento para seu sucesso na carreira.

Conselho Editorial

Organização do Caderno de Estudos e Pesquisa

Para facilitar seu estudo, os conteúdos são organizados em unidades, subdivididas em capítulos, de forma didática, objetiva e coerente. Eles serão abordados por meio de textos básicos, com questões para reflexão, entre outros recursos editoriais que visam tornar sua leitura mais agradável. Ao final, serão indicadas, também, fontes de consulta para aprofundar seus estudos com leituras e pesquisas complementares.

A seguir, apresentamos uma breve descrição dos ícones utilizados na organização dos Cadernos de Estudos e Pesquisa.



Provocação

Textos que buscam instigar o aluno a refletir sobre determinado assunto antes mesmo de iniciar sua leitura ou após algum trecho pertinente para o autor conteudista.



Para refletir

Questões inseridas no decorrer do estudo a fim de que o aluno faça uma pausa e reflita sobre o conteúdo estudado ou temas que o ajudem em seu raciocínio. É importante que ele verifique seus conhecimentos, suas experiências e seus sentimentos. As reflexões são o ponto de partida para a construção de suas conclusões.



Sugestão de estudo complementar

Sugestões de leituras adicionais, filmes e sites para aprofundamento do estudo, discussões em fóruns ou encontros presenciais quando for o caso.



Atenção

Chamadas para alertar detalhes/tópicos importantes que contribuam para a síntese/conclusão do assunto abordado.

**Saiba mais**

Informações complementares para elucidar a construção das sínteses/conclusões sobre o assunto abordado.

**Sintetizando**

Trecho que busca resumir informações relevantes do conteúdo, facilitando o entendimento pelo aluno sobre trechos mais complexos.

**Para (não) finalizar**

Texto integrador, ao final do módulo, que motiva o aluno a continuar a aprendizagem ou estimula ponderações complementares sobre o módulo estudado.

Introdução

Este caderno de estudos tem como objetivo realizar uma apresentação da psicanálise freudiana e da psicanálise kleiniana. Nosso intento será o de expor alguns dos conceitos básicos para a compreensão do pensamento destes autores, além de discutir seu fazer clínico, pois ambos tiveram papel fundamental na construção da teoria e da técnica psicanalíticas.

Freud foi o fundador da psicanálise. Ele é uma referência obrigatória não apenas para quem quer se aprofundar nesta abordagem, mas para quem tem interesse no estudo psiquismo humano e na constituição do pensamento moderno.

Klein foi a criadora da análise lúdica, o que levou ao desenvolvimento da psicanálise com crianças. Ela inaugurou uma nova corrente na psicanálise – a Escola Kleiniana e angariou muitos seguidores, especialmente na Inglaterra. Mezan (2013) relata que a influência de seu pensamento foi, da década de 1940 à década de 1970, muito marcante para a psicanálise no Brasil, o que se constitui em um capítulo importante para entendermos o desenvolvimento do pensamento psicanalítico no país.

Para percorrermos as contribuições de Freud e Klein, assim dividimos este guia de estudos:

Os dois primeiros módulos tratam do pensamento freudiano. No primeiro fazemos uma retomada histórica de como surgiu a psicanálise para, ao fim, caracterizarmos o *setting* psicanalítico criado por Freud. No segundo, abordamos mais detidamente alguns dos conceitos que são fundamentais para quem deseja aprofundar-se na teoria freudiana.

Os dois últimos capítulos abordam o pensamento kleiniano. No terceiro, realizamos, assim como no primeiro, um relato histórico do surgimento da psicanálise de Klein, concluindo, da mesma forma, com a descrição do *setting kleiniano*. No quarto, encerramos nossa jornada focalizando os conceitos básicos da teoria de Klein, que representam as ideias originais que a psicanalista desenvolveu tendo como base seu fazer clínico e o pensamento freudiano.

Consideramos importante ressaltar que este guia de estudos não é suficiente como formação de um psicanalista – a prática clínica exige mais amadurecimento teórico, análise pessoal e prática de escuta supervisionada. Porém, ele se constitui sim em um começo para quem quer se aprofundar no pensamento psicanalítico – o que pode ser a entrada para uma vivência com a psicanálise mais ampla, na medida em que a

teoria psicanalítica não é apenas uma ferramenta clínica, mas pode ser também uma ferramenta de compreensão do humano.

Bom caminhar para todos!

Objetivos

- » Propiciar ao aluno a compreensão dos diversos aspectos da teoria psicanalítica na visão de Sigmund Freud.
- » Propiciar ao aluno a compreensão dos diversos aspectos da teoria psicanalítica na visão de Melanie Klein.

OS CAMINHOS FREUDIANOS E O INÍCIO DA PSICANÁLISE

UNIDADE I

Neste módulo, faremos uma retomada histórica de como Freud inventou a psicanálise, encerrando com a caracterização da prática que emerge de tal processo.



Você deve chegar ao final compreendendo:

- » Porque Freud se desloca do método hipnótico para o método psicanalítico;
- » Quais as principais contribuições de Freud para o entendimento da sexualidade humana;
- » O que caracteriza o *setting* psicanalítico;
- » Porque a psicanálise é diferente da psicoterapia;
- » O conceito de *Transferência*;

CAPÍTULO 1

A gestação da psicanálise

Em 1882, Sigmund Freud, o homem que receberia da história a alcunha de pai da psicanálise, principia sua atuação como médico assistente no Hospital Geral de Viena. Ali começa o caminho que resultará na construção de uma ciência do Inconsciente, calcada inicialmente na observação das manifestações neuróticas.

Freud passa por diversos setores do hospital, mas a área em que mais atua é o Instituto de Anatomia Cerebral, o que, por fim, direciona-o a centrar seus estudos sobre as doenças nervosas. Percebe, nesse momento, que havia em Viena poucos especialistas na área e vê no fato uma oportunidade para estabelecer sua clínica médica. Tal decisão levou-o a buscar fora de Viena espaços em que as doenças nervosas estivessem sendo

pesquisadas de forma mais sistemática. Em 1885, rumou para Paris, tornando-se aluno da Salpêtrière – aluno de Charcot.



Charcot (1825-1893) foi um eminente neurologista francês que atuou e lecionou na Salpêtrière. Levou para o estudo da histeria o método de observação e descrição metódica que era aplicado na neurologia. Fazendo uso da hipnose o que custava um olhar desconfiado e desaprovador da comunidade científica – defendeu a existência da histeria masculina e a presença de uma experiência traumática como base do desencadear das crises histéricas. Suas descobertas foram um dos pontos de partida fundamentais para o desenvolvimento psicanálise.

A passagem por Paris foi marcante para os desenvolvimentos que, posteriormente, Freud viria a empreender em suas observações clínicas. Ele pode se deparar ali com as investigações que Charcot realizava das manifestações histéricas. Provas de que essas manifestações eram autênticas e obedeciam a leis, que ocorriam tanto em homens quanto em mulheres e que podiam ser geradas por sugestão hipnótica, assim como por vivências traumáticas, eram descortinadas frente ao olhar atento do jovem médico. Essas ideias, no entanto, iam levar um tempo para gestar o caldo do qual emergiria o método psicanalítico.

Voltando a Viena, em 1886, Freud se instaura como especialista em doenças nervosas. De início, busca ressonâncias para as novidades que havia conhecido em Paris, mas as ideias de Charcot são prontamente rechaçadas pela comunidade médica austríaca. Resta a Freud prescrever a seus pacientes as soluções de então: eletroterapia e viagens a estabelecimentos hidropáticos – métodos cuja ineficiência o incomodava profundamente.

Mas ele começa a fazer uso também da sugestão hipnótica, caminho que vai se apresentando mais profícuo. E a hipnose se torna, então, o principal instrumento utilizado por Freud nos primeiros anos de sua atividade como médico, levando-o a abandonar, por fim, o atendimento das doenças nervosas orgânicas. Ao comentar essa mudança, Freud (1925/1990, p. 28) faz um interessante relato sobre a realidade do tratamento das doenças mentais à época:

[...] as perspectivas no tratamento de tais desordens (orgânicas) em nenhum caso jamais eram promissoras, enquanto que, por outro lado, na clínica particular de um médico exercendo suas atividades numa grande cidade, a quantidade de tais pacientes eram nada em comparação com as multidões de neuróticos, cujo número parecia ainda maior pelo

modo como eles corriam, com seus males não solucionados, de um médico a outro.

O uso da sugestão hipnótica começa, no entanto, a mostrar limitações. Apesar de conseguir, por meio dela, a suspensão dos sintomas dos pacientes, esses sintomas acabavam por reaparecer. Freud, antes mesmo de sua ida para Salpêtrière, havia conhecido Josef Breuer (*veja quadro que se segue*), um dos médicos de família mais conceituados da Viena de então. Breuer contara-lhe sobre um caso de histeria que havia atendido entre 1880 e 1882 (a paciente recebeu o nome fictício de Anna O.). Fortuitamente, o médico percebera que conseguia aliviar os sintomas da paciente ao levá-la a relatar, em estado de hipnose, o momento de surgimento dos mesmos.



Breuer (1842-1925). Médico e fisiologista. Assim como Freud, era judeu, por uma proximidade com o pai de Freud, ajudou o jovem médico a se estabelecer como clínico em Viena. A sua experiência no atendimento de Bertha – que depois ficou conhecida como Anna O., uma das histéricas mais famosas da história da psicanálise – foi descrita a Freud e se constituiu como um dos principais motores para que Freud ousasse novas técnicas para o tratamento das neuroses.

Na origem dos sintomas, encontravam-se cenas traumáticas. Essas cenas eram marcadas por conflitos mentais que haviam levado a paciente a não liberar emoções ligadas a tais acontecimentos. Essas emoções haviam sido tão fortemente suprimidas que a paciente não era capaz de se recordar, em seu estado consciente, dos fatos aos quais elas estavam vinculadas. As cenas, juntamente com os afetos que as acompanhavam, só se tornavam acessíveis por meio de hipnose.

Bastante impressionado com o relato de Breuer, e diante de impasses que os métodos que vinha utilizando lhe haviam colocado, Freud passa, especialmente a partir de 1889, a reproduzir em sua clínica a técnica que posteriormente seria denominada Método Catártico.

A mudança por si só já ensejava novos entendimentos para os fenômenos da histeria. Primeiramente, percebia-se a presença de uma faceta *dinâmica* no adoecimento, pois o surgimento do sintoma aparecia associado ao represamento de um afeto. Havia também um processo econômico, pois tudo levava a crer que a energia que alimentava o sintoma estava ali investida porque, no momento em que foi gerada, não foi descarregada adequadamente em forma de afeto. Esboçava-se, ainda, um aspecto *tópico*, pelo reconhecimento da existência de atos mentais que não tinham acesso à consciência – atos mentais inconscientes.

Mas o que queremos ressaltar aqui como de maior importância na nova técnica que Breuer e Freud estavam compondo é o fato de eles terem dado fala às histéricas. É a partir desse momento que o sintoma começa a ser compreendido como uma linguagem. A ser entendido como uma mensagem que denunciava a existência de um conflito psíquico encoberto. E se o conflito vinha à tona por meio da fala, o sintoma perdia sua função, e os pacientes se viam dele aliviados.

Trata-se de uma forma de compreensão muito diversa da que era sustentada pela psiquiatria do fim do século XIX (que tendia a buscar sempre a explicação dos sintomas em causas orgânicas). Esse entendimento inaugurará novos caminhos para a psicopatologia e para o tratamento das doenças nervosas. *Seu correlato foi a percepção de que a fala funcionava como vetor de cura.* Bem acertado, portanto, que a primeira paciente de Breuer tenha apelidado a nova técnica de “*talking cure*”. Dessa ousadia, nascerá a psicanálise.

Figura 1. Uma lição com o doutor Charcot na Salpêtrière. Pierre André Brouillet, 1887.



Fonte: <http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/a_histeria_em_cena.html>.

As observações realizadas por Freud e Breuer, por meio do Método Catártico resultaram em uma publicação conjunta na qual os médicos buscavam relatar as descobertas feitas acerca do tratamento e dos sintomas histéricos.

Em 1895, surgem os *Estudos sobre a Histeria*. Mas se, por um lado, a composição dessa obra trouxe o resultado de um esforço dos pesquisadores por teorizar a prática que compartilharam em suas clínicas, por outro, ela começou a desvelar as discordâncias que iam despontando na forma como os estudiosos interpretavam os fenômenos da histeria. Essas discordâncias foram fundamentais para o surgimento da psicanálise.

Freud (1914) relata a busca por entendimento do mecanismo psíquico envolvido nos sintomas histéricos como um dos primeiros pontos de divergência entre ele e Breuer. Ambos haviam constatado a existência de uma divisão mental nos histéricos. Porém, Breuer aproximava-se de uma interpretação mais fisiológica desse fenômeno. Considerava que os histéricos possuíam certa predisposição a apresentar o que ele denominou de “estados hipnoides” e que os processos que eram originados durante esses estados entravam na “consciência desperta” como corpos estranhos não assimilados, sem encontrar, dessa forma, um desfecho normal.

Já Freud concebia essa questão de uma forma diversa. Considerava que os processos alijados da consciência dos histéricos o eram por efeito da ação de forças que os repudiavam, num movimento de defesa que ele veio a denominar posteriormente de *repressão*. Esse entendimento levava-o a considerar os mecanismos psíquicos da histeria como próximos de outras manifestações que podiam ser observadas na vida cotidiana de todas as pessoas. Vão surgindo, assim, duas teorias explicativas diversas: a da “histeria hipnoide” (de Breuer) *versus* a das “neuroses de defesa” (de Freud).

Freud continua avançando em suas observações, e novas questões vão surgindo de sua prática. Algumas delas dizem respeito ao próprio método. Nem todos os pacientes podiam ser hipnotizados. Freud vai descobrindo aos poucos que era necessário certo endereçamento emocional com relação ao médico para que eles se permitissem hipnotizar, e – o que era mais delicado – bastava que a relação pessoal com o paciente sofresse algum tipo de perturbação para que os resultados obtidos com a terapêutica fossem, de súbito, eliminados. Esse fenômeno Freud o denominará, posteriormente, de *Transferência*.

Os primeiros sinais da transferência surgem quando Freud começa a perscrutar os motivos pelos quais Breuer havia interrompido o tratamento de Anna O. Ele chega a inferência de que, depois “que o trabalho de catarse parecia estar concluído, a moça subitamente desenvolvera uma condição de ‘amor transferencial’” (FREUD, 1925, p.39) por seu médico. Breuer não fez a ligação do fato com o estado psíquico da paciente e abandonou decepcionado, o caso. Freud acredita também que está aí um dos fatores intervenientes para que Breuer rechaçasse a presença de excitações de natureza sexual na origem dos sintomas neuróticos. Essa é mais uma divergência que marca o distanciamento entre Freud e o método catártico de Breuer e que compõe o surgimento da psicanálise.

Fato é que Freud começa a sentir os efeitos da transferência sobre a hipnose também em sua clínica, o que o leva a ter que buscar outra forma de acesso às lembranças de seus pacientes. Remontando as trocas que havia tido com Bernheim em 1889, quando foi a

Nancy assistir os experimentos de hipnose ali conduzidos, Freud retoma a ideia daquele médico, segundo quem as lembranças que surgiam durante a hipnose achavam-se, sim, ainda presentes no paciente. Ainda de acordo com Bernheim, bastava que pusesse a mão sobre a testa do enfermo e, mediante encorajamentos, incitasse-o a lembrar, que a recordação ressurgiria. Freud decidiu, então, adotar o mesmo método em sua clínica.



Bernheim (1840-1919) era professor de clínica médica na faculdade de Nancy quando, em 1882, interessou-se pelo trabalho de outro médico francês – Liébeault – que usava a hipnose como técnica terapêutica. Passou, então, a estudar o fenômeno. Suas observações levaram-no a defender que a hipnose podia ser aplicada a qualquer um, então apenas aos histéricos. Defendeu, ainda, que se tratava de um mecanismo de sugestão e que o que ocorria na hipnose podia ser alcançado também em estados de vigília a partir de outros métodos, dispensando-se o chamado sono induzido. Suas afirmações fizeram com que a escola de Nancy travasse uma contenda com Charcot. Tais ideias influenciaram avanços na técnica psicanalítica.

Fonte: <<http://www.redepsi.com.br/2008/02/19/bernheim-hippolyte-1840-1919/>>.

Essa nova mudança metodológica trará, assim como a anterior, outros impulsos para o nascimento da psicanálise. No momento em que Freud abandona a hipnose, um fenômeno que até então vinha sendo camuflado pela antiga técnica apresenta-se à observação freudiana: a existência de um conflito entre forças que não apenas impelia certos conteúdos para fora da consciência, como também os mantinha fora dela.

Freud percebe que todos os conteúdos “esquecidos” pelos pacientes possuíam um valor aflitivo, que desencadeavam sentimentos de vergonha, medo e constrangimento. E, apesar da colaboração do paciente, havia uma resistência psíquica involuntária que se contrapunha à retomada desses conteúdos. Era preciso que médico e paciente enviassem esforços para trazer à tona essas lembranças.

Foi ao visualizar mais diretamente esse fenômeno que Freud pôde ter noção do papel e da importância da resistência no tratamento das neuroses. Foi também nesse momento que ele pôde elaborar com maior clareza uma explicação do mecanismo envolvido na formação dos sintomas. Surge, assim, a *Teoria do Recalque* (traduzida na Edição Standard Brasileira como Teoria da Repressão). Ela, segundo Freud (1914/1990, p. 26), é o marco de nascimento da psicanálise:

A teoria da repressão é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. [...] a história da psicanálise propriamente dita só começa com a nova técnica que dispensa a hipnose. A consideração

teórica, decorrente da coincidência dessa resistência com uma amnésia, conduz inevitavelmente ao princípio da atividade mental inconsciente, peculiar à psicanálise [...]. Assim talvez se possa dizer que a teoria da psicanálise é uma tentativa de explicar dois fatos surpreendentes e inesperados que se observam sempre que se tenta remontar os sintomas de um neurótico a suas fontes no passado: a transferência e a resistência. Qualquer linha de investigação que reconheça esses dois fatos e os tome como ponto de partida de seu trabalho tem o direito de chamar-se psicanálise.

Outra possibilidade que se inaugura quando a hipnose é deixada para trás é a de acompanhar o deslizar da fala dos pacientes. Isso leva Freud a uma percepção importantíssima para o desenvolvimento da psicanálise. Chama a sua atenção a frequência com que os pacientes, ao se entregar ao contínuo do pensamento, relatavam seus sonhos. Esses sonhos iam se desmembrando e enriquecendo de elementos as histórias que os analisados estavam a compor sobre os seus sintomas. Freud se dá conta, por essa via, de que os sonhos têm um sentido. Assim como os sintomas, eles são uma mensagem que pode ser interpretada e que conduz aos conteúdos inconscientes.

Essa descoberta é de fundamental importância, porque os sonhos são um acontecimento que não diz respeito apenas à vida psíquica dos neuróticos. Eles são um fenômeno universal. Pela interpretação dos sonhos, Freud intensificará sua busca por construir um entendimento do funcionamento psíquico humano, erigindo conclusões que passam a ser passíveis de generalização.

Os sonhos, na verdade, serão a porta de entrada de todo um conjunto de fenômenos da psique que Freud começará a pesquisar, e que o ajudarão a compor seu modelo de aparelho psíquico. Assim, para além dos sintomas, os sonhos, os chistes, os atos falhos e os fenômenos estéticos vêm compor a argamassa sobre a qual Freud estruturará os modelos teóricos da psicanálise. São o que ele chama de “formações do inconsciente”.

Vemos, portanto, que o novo entendimento que se inaugura com o abandono da hipnose sedimenta algumas ideias que vinham sendo gestadas e que são cruciais para o nascimento da psicanálise propriamente dita.

1. Freud vai, enfim, teorizar o inconsciente como uma instância psíquica, ou seja, como um “lugar” psíquico, que traz a marca de um funcionamento próprio, diferente do da consciência – o *inconsciente*.
2. Freud é levado a se deparar ainda mais com o fenômeno da transferência (que, em determinado momento do processo analítico, constitui-se

como uma das principais formas de resistência à análise). O deparar-se com a transferência é, também, um deparar-se com o sexual na fala dos neuróticos.

Sobre esse segundo elemento – o deparar-se de Freud com a etiologia sexual das neuroses – tratá-lo-emos de forma mais atenta, pois ele é um dos principais pontos de constituição da psicanálise.

CAPÍTULO 2

E havia a sexualidade

Na medida em que avançava em suas observações clínicas, Freud começava a perceber uma constância temática nos relatos que emergiam da fala de seus pacientes. A excitação emocional que estava na base do desencadear dos sintomas neuróticos não era genérica. Ela acabava por se mostrar sempre de natureza sexual. Freud não esperava por essa constatação, e ela de fato veio a se tornar uma das principais desencadeadoras de rejeição às teorias psicanalíticas, constituindo-se em ponto principal do rompimento de Freud não apenas com Breuer, mas com nomes que viriam a desempenhar papel importante na difusão das ideias psicanalíticas (como Adler e Jung).



Alfred Adler (1870-1957) foi um médico austríaco que integrou o primeiro grupo de seguidores de Freud e divulgadores do pensamento psicanalítico. <<http://febrapsi.org.br/biografias/alfred-adler/>>.

Carl Gustav Jung (1875-1961) foi um psiquiatra suíço que fez parte do grupo de Zurique, um dos primeiros a apoiar o movimento psicanalítico. Freud tinha expectativas de que ele fosse o difusor da psicanálise para fora dos círculos judaicos, já que Jung era protestante. Mas Jung se tornou seu opositor e criou uma nova escola: a Psicologia Analítica.

Ambos – Adler e Jung – distanciaram-se de Freud devido às discordâncias teóricas, especialmente no que dizia respeito ao papel da libido como energia mobilizadora dos processos psíquicos.

Freud, no entanto, não abriu mão de relatar aquilo que escutava na fala dos histéricos. E, sistematicamente, passou a investigar também a vida sexual de outros pacientes neuróticos, que chegavam cada vez em maior número a sua clínica, percebendo também neles a presença de fatores sexuais na emergência dos sintomas.

Freud trazia consigo a influência da teoria do trauma (de Charcot), e, por meio da fala dos histéricos, foi levado a concluir que o trauma que se encontrava na base dos sintomas neuróticos era de origem sexual. A cena da sedução por um adulto encontrava-se presente com grande frequência na fala de seus pacientes. Nas histéricas, comumente era o pai quem ocupava o papel de sedutor. A escuta desses relatos levou Freud a formular a *Teoria da Sedução* como explicação etiológica das neuroses. Mas o percurso do criador da psicanálise estava só no início.

A concepção da etiologia sexual das neuroses já era, em si, bastante virulenta. Porém, aquilo que veio a se descortinar em seguida era bem mais. O que as observações clínicas de Freud acabaram por desvelar vem a ser desalojador para o discurso sustentado na época sobre a sexualidade humana.

Persistindo em suas pesquisas – que, além de se calcarem sobre a escuta de seus pacientes, passam também a colher material de um intenso processo de autoanálise ao qual Freud se entrega –, o pai da psicanálise afirmará, em carta a Fliess (*veja quadro abaixo*) de 21 de setembro de 1897: “Não acredito mais em minha *neurótica* [teoria das neuroses]”.



Wilhelm Fliess (1858-1928) era médico em Berlim e conheceu Freud por meio de Breuer. Compartilhava com ele o interesse pela histeria e veio a ser um dos principais interlocutores de Freud no período de gestação do pensamento psicanalítico. A correspondência entre ambos foi intensa entre os anos de 1887 e 1904. Fliess aparece no discurso de muitos estudiosos da psicanálise como tendo ocupado uma função importante no processo que Freud posteriormente denominaria de autoanálise. Para o amigo berlinense, eram descritos sonhos (seus e de seus pacientes), sentimentos desencadeados por fatos de sua vida – como a morte de seu pai – e ideias que iriam compor a estrutura básica da teoria psicanalítica. Os amigos acabaram por ter um forte rompimento, pois Fliess alegava que Freud havia se apropriado de parte de suas ideias. Apesar do desfecho ruim, o que restou da correspondência deles põe à mostra o surgimento de alguns dos principais conceitos freudianos. <www.revistavortice.com.br/2011/04/notórios-da-psicanálise-wilhelm-fliess.html>.

Assim é que, na carta citada acima, Freud explica a Fliess que já não era possível sustentar a teoria da sedução. Vários motivos o levaram a essa conclusão. Entre eles:

- a. O abandono, por pacientes que Freud acreditava estar compreendendo, do processo de análise;
- b. A surpresa diante do fato de que, pelos relatos que surgiam na fala dos histéricos, todos os pais (incluindo o dele) teriam de ser apontados como pervertidos – o que faria da perversão algo muito mais comum do que a neurose;
- c. Os elementos de sua história, que vinham se revelando a ele por meio da autoanálise;

- d. E, importantíssima conclusão, “a descoberta comprovada de que, no inconsciente, não há indicações da realidade, de modo que não se consegue distinguir entre a verdade e a ficção que é catexizada com o afeto. (Assim, permanecia aberta a possibilidade de que a fantasia sexual tivesse invariavelmente os pais como tema.)” (FREUD, 1950/1990, p. 358).



Catexia é o termo usado em psicanálise para indicar o investimento de determinada quota de energia psíquica em um representante ideacional. Falaremos mais sobre esse tema no segundo módulo.

A chegada a este resultado deixou Freud inicialmente desestabilizado. Levou-o mesmo a pensar em abandonar todo o trabalho que vinha realizando. Passado o choque inicial, no entanto, em carta de 15 de outubro de 1897, ele finalmente expõe a ideia que sustenta três concepções fundadoras do discurso psicanalítico: a existência de uma realidade psíquica, o Complexo de Édipo e a sexualidade infantil. Eis a afirmação que Freud (1950/1990, p. 365) entrega a Fliess:

Um único pensamento de valor genérico revelou-se a mim. Verifiquei também no meu caso, a paixão pela mãe e o ciúme do pai, e agora considero isso como um evento universal do início da infância [...]. Sendo assim, pode-se entender a força avassaladora de *Oedipus Rex* [...], a lenda grega capta uma compulsão que toda pessoa reconhece porque sente sua presença dentro de si mesma. Cada pessoa da plateia já foi, um dia, em germe ou na fantasia, exatamente um Édipo como esse, e cada qual recua, horrorizada, diante da realização de sonho aqui transposta para a realidade, com toda a carga de recalçamento que separa seu estado infantil do seu estado atual.

Freud, portanto, havia esbarrado na descoberta que mais causaria indignação e geraria rejeição às ideias psicanalíticas. Ele percebera que os sintomas neuróticos não remetiam a experiências sexuais passivas ocorridas nos primeiros anos da infância. Na verdade, compunha-se a partir de fantasias, o que demonstrava a existência de uma realidade psíquica tão importante para a vida mental desses sujeitos quanto à realidade material.

Assim, clarificou-se diante dele o fato de que essas fantasias encobriam, na verdade, uma atividade auto-erótica que tinha como palco os primeiros anos da infância, desvelando-se, assim, a vida sexual das crianças – que, até então, era tida como inexistente. Freud pode, enfim, declarar: a sexualidade começa com o começo da vida.

Precisamos ressaltar, no entanto, que a teoria da sedução não é de todo abandonada por Freud. Ele a retomará posteriormente, integrando-a melhor ao corpo teórico que será construído nos anos seguintes. No ponto de equilíbrio que encontra, a criança comparece com sua sexualidade – ativa, polimorfa, livre –, mas os cuidados recebidos nos primeiros anos da infância também desempenhariam um papel fundamental, estimulando o surgimento das fantasias sexuais infantis. Haveria, portanto, uma inoculação da sexualidade adulta, por meio dos cuidados e da afeição bem própria que a mãe direcionaria a criança. Volta a figura da sedução materna/paterna pensada sob outro formato, pensada como base para as fantasias sexuais infantis, que também teriam seu estímulo em fatores constitucionais. Sobre o desenvolvimento desse aspecto no pensamento freudiano, recomendamos a leitura do primeiro capítulo de *Freud: o movimento de um pensamento*, de Luiz Roberto Monzani.

Destacado mais esse elemento fundamental para o nascimento da psicanálise propriamente dita, é chegada a hora de finalizarmos o quadro que começamos a construir no início dessa unidade: o novo saber chega, enfim, ao mundo. E agora estamos prontos para conhecer sua face.

CAPÍTULO 3

A psicanálise chega ao mundo

Nessa unidade buscaremos descrever o que caracteriza, afinal, um tratamento psicanalítico.

Como viemos acompanhando nas unidades anteriores, a psicanálise se desenvolveu a partir de uma série de mudanças metodológicas que Freud foi realizando no tratamento das neuroses. A passagem do que ele denominou de “método de incitação” (1925/1990, p. 55) para a *Associação Livre* foi a última delas.

Essa passagem surge da percepção de que a técnica que vinha sendo adotada exigia um esforço demasiado do médico e do paciente. Nela, elegia-se um tema para ser desenvolvido e, pela insistência e pelo estímulo, o sujeito era incitado a falar sobre ele. O formato também era passível de críticas por estar muito próximo do uso da sugestão, o que poderia levantar dúvidas acerca do quanto às representações que ali surgiam diziam respeito ao paciente e do quanto eram frutos da condução do médico.

Curioso é que a experiência com a interpretação dos sonhos leva Freud a uma técnica que é justamente o oposto da anterior. Em vez de incitar o paciente a dizer algo sobre um assunto específico, pedia-se que ele falasse tudo o que viesse à cabeça, sem fazer objeções nem críticas, e sem fazer uma seleção prévia do conteúdo.

Associar livremente, deixar-se levar pelas representações que vão se apresentando na cadeia da fala sem impor sobre ela uma censura: essa passa a ser a *Regra Fundamental da Psicanálise*. Por meio dela, adquire-se acesso aos conteúdos inconscientes sem deixar de ter também a oportunidade de trabalhar as forças de resistência que os expulsaram da consciência. Eis o novo objetivo do tratamento criado, “revelar repressões e substituí-las por atos de julgamento que podiam resultar quer na aceitação, quer na condenação do que fora anteriormente repudiado” (FREUD, 1925/1990, p. 43).

A psicanálise expõe para o mundo o formato definitivo de seu método de tratamento. A seguir, sintetizamos sua construção da maneira como foi apresentada até a presente unidade:

Figura 2.



A Associação Livre é, portanto, como já havíamos afirmado, a técnica que marca o início da psicanálise propriamente dita. Há imprescindível ressaltar nesse momento, seu correlato – a *Atenção flutuante* –, cuja compreensão é de importância crucial para que se entenda o quanto o novo fazer se constituirá como um campo de produção de saberes e de práticas diferenciado do lugar epistemológico no qual se inserem as psicoterapias.

Atenção flutuante diz respeito à forma como o psicanalista deve ouvir seus pacientes. Nela, ele buscaria não fixar sua escuta em um assunto específico, mantendo a mesma “atenção uniformemente suspensa” diante de todo e qualquer material surgido na fala do sujeito. Essa seria uma maneira de evitar uma ação equivocada por parte do analista: a de começar a selecionar o material que lhe é apresentado. A seleção faz com que alguns pontos se fixem em sua mente e outros sejam negligenciados. Isso é um erro porque, ao realizar essa distinção de conteúdo, o analista corre o risco de ser conduzido por suas expectativas, arriscando-se a nunca descobrir nada além do que já sabe e a falsificar aquilo que poderia vir a perceber. Limita, assim, seu acesso aos complexos inconscientes do analisando, impedindo-se de compreendê-los.

Portanto, se do paciente é exigido que ele comunique tudo o que lhe ocorre, sem censuras, do psicanalista é esperada a ação correspondente de escutar tudo o que o paciente lhe direciona, sem seleções, ou estaria desperdiçando o material entregue pelo analisando. Assim, é recomendado que ele prescinda da sua capacidade de prestar atenção (ação própria da consciência) e se abandone à “memória inconsciente”. Sobre esse importante ponto, Freud (1912/1990, p. 154) afirma que o analista:

[...] deve voltar seu próprio inconsciente, como um órgão receptor, na direção do inconsciente transmissor do paciente. [...] (Pois) o inconsciente do médico é capaz, a partir dos derivados do inconsciente que lhe são comunicados, de reconstruir esse inconsciente, que determinou as associações livres do paciente.

Essa formulação freudiana é muito importante para que se perceba a profunda diferença entre a psicanálise e outras psicoterapias. A afirmação deixa muitíssimo claro o fato de que o que entra em jogo em um processo analítico é o Inconsciente. O que se trava entre analista e analisando não é da ordem de um debate teórico ou de uma argumentação de ideias ou de um aconselhamento – e nem mesmo da simples expressão de sentimentos “de forma adequada”, como acontecia no método catártico.

Trata-se de um processo que busca que o paciente tenha contato com seus conteúdos recalçados, se dê conta das maneiras próprias que sua estruturação psíquica criou para manter tais conteúdos alijados da consciência e compreenda o porquê de a eles ter sido destinado esse fim. Por isso é que, na análise, não é suficiente ter conhecimento

dos complexos inconscientes. Mais importante passa a ser se aperceber das forças que operaram para que eles se tornassem inconscientes. Ou seja, trabalhar as resistências e seus produtos.

Isso traz implicações muito específicas para o fazer psicanalítico. Freud (1912) questionará diretamente tanto o que chama de “ambição terapêutica” como o que chama de “ambição educativa”. Isso porque, segundo ele, quando se entrega ao furor *curandis*, o analista incorre no risco de concentrar seus esforços no alívio dos sintomas do paciente, quando sua atenção precisa estar voltada para o processo em si de emergência das representações inconscientes. A reapropriação dessas representações passa por uma zona de desencadeamento de incômodos e de resistências no analisando para a qual o analista ficará despreparado se sua preocupação principal for a de melhorar o estado do paciente. Por isso é que a recomendação na psicanálise seria: aborde o processo, a mudança no estado psíquico do paciente vem como decorrência.

De igual inutilidade seriam as intenções educativas do analista, que costumam surgir quando seu analisando consegue por fim liberar-se de grande parte de suas inibições. O analista, ainda que o quisesse, não teria como definir os caminhos de investimento pulsional a serem tomados pelo analisando ao final de um processo – uma tentativa dessa espécie poderia inclusive, reavivar inibições que já teriam sido superadas. Por isso é que Freud alerta claramente que “o médico deve controlar-se e guiar-se pelas capacidades do paciente em vez de por seus próprios desejos” (1912/1990, p. 157).

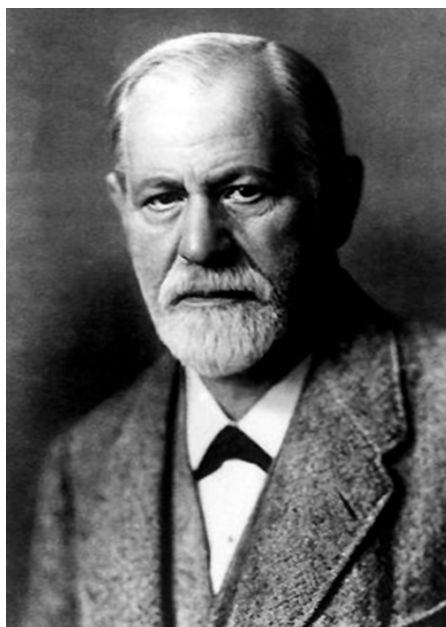
Mas, para conseguir colocar seu inconsciente a serviço da escuta do analisando, assim como para conseguir controlar suas ambições pessoais, algo se faz fundamental: que o analista se submeta, ele mesmo, a um processo de análise, pois precisa se apropriar daqueles complexos seus que têm potencial de interferir na compreensão do inconsciente do paciente. O analista precisa trabalhar suas próprias resistências, para que elas não ocultem de sua consciência o que o inconsciente do analisando lhe apresentou. Isso será de fundamental importância para que o analista esteja pronto para enfrentar a maior dificuldade do processo analítico: o manejo da transferência.

Já tocamos nela aqui. Mas agora nos debruçaremos um pouco mais detidamente. É preciso afirmar de saída que a transferência é um fenômeno universal da mente humana, apesar de o ambiente analítico ser um espaço especialmente propício para percebê-la e tratá-la. Fato é que ela surgirá independentemente da vontade do analista e do analisando, e se constituirá como o mais importante e difícil elemento a ser manejado na técnica analítica.

Podemos dizer que cada sujeito tem uma forma própria de amar. Em geral, nos vínculos amorosos reeditam-se as relações emocionais que tiveram origem nas primeiras ligações

de objeto experienciadas. Cada um compõe uma maneira específica de se conduzir na vida erótica, e repete, no curso desta, o que se poderia chamar de um clichê amoroso, constantemente reimpresso no todo das relações que empreende com seu ambiente humano. As condições para o enamoramento, as pulsões que se busca satisfazer nos relacionamentos, os objetivos que se estabelecem para si, tudo isso faz parte do modelo primeiro. A questão é que tal modelo não é composto unicamente por pulsões que conseguem sua satisfação na realidade e têm suas representações acessíveis à consciência. Parte dos impulsos libidinais foi retida no curso de seu desenvolvimento, ficando no âmbito do inconsciente e permanecendo, assim, afastada da realidade e da satisfação. Essas pulsões estão também na base da composição das fantasias. E as fantasias (com suas facetas conscientes e inconscientes) entram na equação que compõe a forma como o sujeito se posta em seus relacionamentos.

Figura 3. Sigmund Freud.



Fonte: <<http://www.psicologiahoy.com/biografia-de-sigmund-freud/>>. Acesso em: 21/2/2017.

Não é motivo de surpresa, então, que o analista possa ser investido por essas pulsões e recoberto por essas fantasias. Freud (1912/1990, p.135) apenas ressalta o ambiente analítico como mais propício ao surgimento desse fenômeno, assim como à sua resolução.

Eis, então, o que é a transferência, uma repetição desse formato de vínculo que o sujeito estabeleceu com seus primeiros objetos de investimento libidinal. Ela surge, inicialmente, como um dos principais motores do processo analítico. Há um endereçamento de sentimentos amistosos, afetuosos e de confiança que fazem com que o analista possa iniciar seu trabalho. Esses sentimentos são precípuos para o trabalho

de análise, e se colocam lado a lado de outras forças motoras, como o sofrimento do paciente e seu desejo de cura, para pôr o processo analítico em funcionamento.

No entanto, quando o conteúdo inconsciente começa a ser acessado pelo analista, ele assiste a uma transformação na transferência. Ela muda de figura e, paradoxalmente, passa a ser um dos principais pontos de resistência do analisando. Nesse momento, ela pode assumir tanto a feição de uma transferência positiva, como a feição de uma transferência negativa.

A transferência positiva, em seus prolongamentos inconscientes, remonta invariavelmente às suas fontes eróticas e pode tomar, inclusive, o formato de um arrebatado apaixonamento, que aparecerá sob os mais diversos disfarces devido ao conteúdo sexual ao qual faz remição. A transferência negativa apresenta-se na forma de sentimentos de oposição à figura do analista, e aí se manifestam na adoção das mais variadas atitudes de hostilidade.

Ambas as aparições do que Freud denominará de resistência transferencial têm o mesmo efeito: uma interrupção no processo de associação livre do analisando. Mas o que inicialmente é um transtorno ao desenvolvimento da análise passa a ser um dos mais importantes materiais do trabalho analítico, na medida em que o analista auxilia o paciente a revelar os impulsos inconscientes presentes nas ações transferenciais. Sobre essa função fundamental da análise, diz Freud (1912/1990, p.143):

O médico tenta compeli-lo a ajustar esses impulsos emocionais ao nexos do tratamento e da história de sua vida, a submetê-los à consideração intelectual e a compreendê-los à luz de seu valor psíquico. Esta luta entre o médico e o paciente, entre o intelecto e a vida instintual, entre a compreensão e a procura da ação, é travada, quase exclusivamente, nos fenômenos da transferência. É nesse campo que a vitória tem de ser conquistada – vitória cuja expressão é a cura permanente da neurose. Não se discute que controlar os fenômenos da transferência representa para o psicanalista as maiores dificuldades; mas não se deve esquecer que são precisamente eles que nos prestam o inestimável serviço de tornar imediatos e manifestos os impulsos eróticos ocultos e esquecidos do paciente. Pois, quando tudo está dito e feito, é impossível destruir alguém *in absentia* ou *in effigie*.

Por isso é que a transferência se constitui como um dos mais importantes pontos do trabalho analítico, sendo o que Freud chama de neurose transferencial um dos últimos campos a serem enfrentados na análise. A forma como se lida com ele nesse espaço é, inclusive, mais um fator que diferencia a Psicanálise de outras terapias. Como Freud

ressalta (1925/1990, p. 57), o poder da sugestão que a relação transferencial confere ao médico só deve ser utilizado para induzir o paciente a realizar um trabalho psíquico, superando suas resistências e realizando uma mudança permanente em sua economia mental. Na análise, não é permitido desempenhar o papel decisivo na determinação dos resultados terapêuticos. A sugestão pode até ser utilizada, desde que a isso não se dê o nome de psicanálise.

Por fim, queremos comentar ainda que, no contínuo deste trabalho com as resistências transferenciais, encontra-se o uso do divã, que será defendido por Freud como uma forma de impedir que a transferência se misture imperceptivelmente com as associações do paciente, pois ele pode ficar preso a interpretações de gestos do analista, conduzindo a sua fala por elas. Assim, tirando a visão do analista, o paciente ficaria diante apenas de seu discurso.

Encerrando esta unidade, pontuamos aqui algumas das principais características que compõem o *setting* psicanalítico – e que o diferenciam do campo das psicoterapias em geral. Assim, é chegada a hora de partirmos para a exploração de alguns conceitos que, até então, foram apenas mencionados. Sigamos...

A PSICANÁLISE DE FREUD E SEUS CONCEITOS BÁSICOS

UNIDADE II

CAPÍTULO 1

A metapsicologia freudiana

Em 1915, em seu artigo *O Inconsciente* Freud (1915/1990, p. 208) assim declara:

Não será descabido dar uma denominação especial a essa maneira global de considerar nosso tema, pois ela é a consumação da pesquisa psicanalítica. Proponho que, quando tivermos conseguido descrever um processo psíquico em seus aspectos *dinâmico*, *topográfico* e *econômico*, passemos a nos referir a isso como uma apresentação *metapsicológica*. Devemos afirmar, de imediato que no presente estado de nosso conhecimento há apenas alguns pontos nos quais essa tarefa terá êxito.

Freud fala aqui da estrutura teórica que adotou para explicar a forma de funcionamento do psiquismo: a metapsicologia. Mas, o que seria a metapsicologia?

Quando falamos de metapsicologia estamos nos referindo ao arcabouço teórico da psicanálise. Trata-se do termo que Freud cunhou para denominar seus esforços no sentido de explicar os mecanismos envolvidos nos atos psíquicos. A metapsicologia possui sempre três facetas, que se apresentam indissociavelmente interligadas. São elas a faceta tópica, a faceta dinâmica e a faceta econômica.

A faceta tópica se refere à localização de um elemento dentro do aparelho psíquico. Para Freud é fundamental perceber a que sistema o elemento pertence (Inconsciente, pré-consciente ou Consciente), pois cada um destes sistemas teria um funcionamento próprio e determinaria as características do conteúdo sob sua vigência.

A faceta dinâmica abarca as questões relacionadas ao jogo de forças que se trava entre os sistemas. Os conteúdos do Inconsciente exercem pressão para alcançar a consciência,

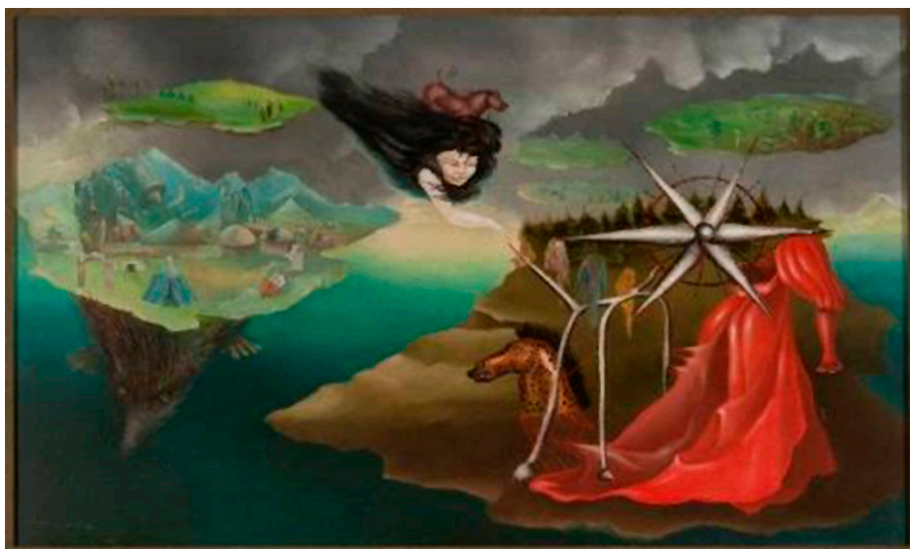
e o pré-consciente tem o papel de filtrá-los. Ocorrem, portanto, conflitos entre estes sistemas que os forçarão a arranjar formas de composição. Por isso, chamamos o resultado desses arranjos de *formações de compromisso*, porque são resultantes de “negociações” entre os sistemas. Também recebem o nome de formações do Inconsciente. São como já dissemos os sonhos, os sintomas, os atos-falhos, os chistes, a arte. Entender essa composição de forças é fundamental para compreender os mecanismos psíquicos envolvidos em tais fenômenos.

A terceira faceta é a econômica. Ela abarca as trocas energéticas entre os sistemas. A energia de que fala Freud é a libido. Seu investimento em um conteúdo psíquico (catexia) determina a pressão que ele exercerá para chegar a consciência e obter a descarga motora - e, com ela, uma sensação de prazer. Se, no entanto, tal descarga não ocorre, o aumento da energia permanece gerando tensão, o que gera desprazer. Essa concepção, Freud a denominou de *Princípio do Prazer* e demonstra a importância da compreensão da faceta energética na explicação das formações de compromisso.

Assim, a metapsicologia passa a ser norteadora dos esforços de Freud por compor uma teoria psicanalítica dos fenômenos psíquicos.

O protótipo para que Freud iniciasse suas descrições metapsicológicas dos fenômenos mentais foi o sonho. Um dos motivos para que tenha sido esse o fenômeno psíquico escolhido pelo pai da psicanálise como porta de entrada foi o fato de o sonhar ser um fenômeno universal e de os sonhos dos neuróticos em nada diferirem dos das pessoas normais. Sendo assim, as hipóteses construídas a partir da observação dos sonhos abarcariam não só casos patológicos, mas a vida anímica das pessoas em geral.

Figura 4. ARTES110, Leonora Carrington, 1942.



Fonte: <<http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/04/brasilia-recebe-maior-exposicao-feita-no-pais-sobre-mexicana-frida-kahlo.html>>. Acesso em: 21/2/2017.

Assim é que, em 1900, Freud lançará o seu polêmico *A Interpretação dos Sonhos*, no qual expõe suas descobertas acerca dos mecanismos envolvidos na construção destes fenômenos psíquicos. A primeira base a ser cuidadosamente erigida por Freud é de que o sonho é um processo dotado de sentido (e de que é possível chegar a seu entendimento a partir de um trabalho de interpretação).

Mas por que é necessário interpretar um sonho para se alcançar o seu sentido? Isto é: por que esse sentido não se apresenta de imediato no conteúdo do sonho?

Aí é que vem a segunda base sobre a qual Freud sustentará sua teoria das vivências oníricas. Os sonhos são realizações de desejos. Mas estes desejos nem sempre têm um conteúdo considerado adequado para ter acesso à consciência. Muitos deles sofrem censura, permanecendo ativos apenas como conteúdos inconscientes. Só a partir de um processo que Freud denomina *elaboração onírica* – e que tem como objetivo disfarçar os desejos inconvenientes presentes nos “pensamentos oníricos latentes” – é que esses conteúdos podem emergir, imiscuídos no “conteúdo manifesto dos sonhos”. O conteúdo manifesto é aquele que surge quando cerramos os olhos e pomos em suspenso a vida de vigília. É o sonho propriamente dito.

Sendo assim, para remontar os desejos que originaram um sonho, é necessário partir do conteúdo manifesto e ir desfazendo os disfarces, até alcançar os pensamentos latentes que o originaram. Eis o trabalho da interpretação.

Para realizá-lo, no entanto, foi necessário a Freud adquirir um entendimento de como eram elaborados os disfarces que encobriam o conteúdo latente na origem de um sonho. Ou seja, ele precisou compreender o processo de elaboração onírica, isto é, como o sonho era construído. Quatro mecanismos fundamentais operariam para arquitetura do sonho: condensação, deslocamento, figuração e elaboração secundária. Porém, aqui, trataremos apenas dos dois primeiros mecanismos, pois, como afirmou Freud, “O deslocamento do sonho e a condensação do sonho são os dois fatores dominantes a cuja atividade podemossem essência atribuir a forma assumida pelos sonhos” (FREUD, 1900/1990, p. 296).

Freud percebeu que uma das características da elaboração onírica era a de buscar reduzir os pensamentos latentes dispersos à expressão mais sucinta e unificada possível. Para isso, o trabalho onírico realizava a *condensação*, mecanismo que fazia com que o conteúdo latente do sonho fosse reduzido a uma quantidade concisa de elementos. Como?

Os elementos que entravam no sonho constituíam “pontos nodais”, para os quais convergia um grande número de pensamentos que estavam na origem do sonho. Ou seja,

cada elemento do sonho seria sobre determinado, podendo-se, a partir dele, retomar várias cadeias de associação de pensamentos que haviam contribuído na formação dos sonhos. Freud assim explicou (1900/1990, p. 276):

Não só os elementos de um sonho são repetidamente determinados pelos pensamentos do sonho como também cada pensamento do sonho é representado neste último por vários elementos. (...) os elementos do sonho são construídos a partir de toda a massa de pensamentos do sonho e cada um desses elementos mostra ter sido multiplamente determinado em relação aos pensamentos do sonho.

Mas há um segundo mecanismo descrito por Freud que atua em conjunto com a condensação para compor o conteúdo manifesto do sonho. A ele, Freud denominou *Deslocamento*. No deslocamento, entraria em jogo uma força psíquica que despojaria os elementos com alto valor psíquico de sua intensidade, transferindo essa energia para outros elementos de baixo valor psíquico. A escolha do elemento que receberia a intensidade transferida se daria de duas formas: ou ele estaria associado ao elemento anterior por algum aspecto que possuiriam em comum, ou ele seria uma expressão pictórica e concreta capaz de substituir a expressão abstrata presente no pensamento onírico.

O segundo elemento, agora investido com seu novo valor, funcionaria como um substituto do primeiro, e teria sua entrada liberada para o conteúdo do sonho. “Assim sendo, ocorrem *uma transferência e deslocamento de intensidade psíquica* no processo de formação do sonho, e é como resultado destes que se verifica a diferença entre o texto do conteúdo do sonho e o dos pensamentos do sonho” (FREUD, 1900/1990, p. 296). Mas, afinal, que força colocaria o mecanismo de deslocamento em ação?

A censura que é exercida por uma instância da mente sobre outra: a censura da defesa endopsíquica. Motivado por ela, o trabalho do sonho faz uso principalmente da condensação e do deslocamento para que o desejo que compõe o núcleo do sonho apareça de forma distorcida no conteúdo manifesto deste. Portanto, para que um elemento penetre em um sonho, ele tem de ter escapado da censura imposta pela resistência.

Neste ponto, para que possamos continuar a expor o processo de formação dos sonhos, é necessário que adentremos no modelo de aparelho psíquico proposto por Freud. Só essa incursão nos permitirá entender o fenômeno onírico a partir dos pontos de vista topológico e dinâmico.

Quando Freud propõe seu modelo de aparelho psíquico, no famoso capítulo VII de *A Interpretação dos Sonhos*, ele faz questão de ressaltar, já de início, que os conceitos que proporá não devem ser entendidos como localizações anatômicas, mas como localizações psíquicas. Ele retrata “o aparelho psíquico como um instrumento composto a cujos componentes daremos o nome de ‘instâncias’ ou (...) sistemas” (FREUD, 1900/1990, p. 492).

Essa denominação proposta por ele é de fundamental importância, pois o termo “inconsciente” passa a ser usado não apenas no sentido de adjetivar um conteúdo psíquico, mas como um sistema – com leis e funcionamento próprios. “A substituição da noção *descritiva* de inconsciente pelo conceito sistemático é um dos momentos fundamentais da construção teórica de Freud” (GARCIA-ROZA, 2009 p. 80). Seriam três os sistemas que comporiam o aparelho psíquico – Inconsciente, pré-consciente e consciente –, e este aparelho teria um sentido ou direção: toda e qualquer atividade psíquica sempre se iniciaria em um estímulo (podendo ser este interno ou externo) e buscaria uma descarga motora. Desta maneira, Freud concebe o aparelho psíquico como tendo uma extremidade sensorial e uma extremidade motora.

Compondo o quadro, portanto, na extremidade sensorial encontraríamos um sistema que receberia as percepções, enquanto que, na extremidade motora, ficaria o sistema responsável por dar (ou não) passagem destes estímulos para as atividades motoras. Geralmente, os processos psíquicos ocorreriam da extremidade perceptual para a extremidade motora.

Freud constata, no entanto, a necessidade de um terceiro sistema – aquele que teria a função de guardar os estímulos perceptivos na forma de traços mnêmicos permanentes, e que permitiria as associações entre estes traços. Tal associação aconteceria pela transmissão da excitação de um traço mnêmico para outro, possibilitada pela existência de vias facilitadoras constituídas devido a simultaneidades temporais entre estes traços, ou outras similitudes e coincidências que fossem ocorrendo e que comporiam a configuração dos elementos mnêmicos.

Descritas essas três instâncias, Freud argumenta que o sistema que abriga os traços mnêmicos seria aquele que menos teria relação com a consciência, pois as lembranças, apesar de exercerem efeitos sobre o psiquismo, seriam, na maior parte do tempo, inconscientes – podendo, ocasionalmente, tornarem-se conscientes. Já o sistema que coordenaria a extremidade motora seria aquele que dirigiria nossa vida de vigília, determinando nossas ações voluntárias e conscientes. Portanto, ele precisaria ter uma relação mais estreita com a consciência e possuir a função de exercer uma crítica sobre os conteúdos que teriam acesso a ela, comportando-se como uma tela que filtra o que

passaria da instância da memória para a consciência. Por fim, a instância perceptual seria identificada como a própria consciência, pois os conteúdos só se tornam conscientes na medida em que são percebidos e sobre eles se concentra a função da atenção.

Assim, Freud (1900/1990, p. 495) figura sua descrição do aparelho psíquico:

Descreveremos o último dos sistemas situados na extremidade motora como o ‘pré-consciente’, para indicar que os processos excitatórios nele ocorridos podem penetrar na consciência sem maiores empecilhos, desde que certas condições sejam satisfeitas: por exemplo, que eles atinjam certo grau de intensidade, que a função que só se pode descrever como atenção esteja distribuída de uma dada maneira, etc. Este é, ao mesmo tempo, o sistema que detém a chave do movimento voluntário. Descreveremos o sistema que está por trás dele como ‘o inconsciente’, *pois este não tem acesso à consciência senão por meio do pré-consciente*, ao passar pelo qual seu processo excitatório é obrigado a submeter-se a modificações.

Estruturada a visão do aparelho psíquico, importante entender que, em geral, a excitação ocasionada pelos estímulos se deslocará num sentido progressivo, da extremidade perceptual para a motora. No entanto, a proposta fundamental que o estudo dos fenômenos oníricos permite à Freud realizar é a de que, em determinados processos psíquicos, como no caso dos sonhos, a excitação pode percorrer um caminho regressivo. Ela se moveria, portanto, em sentido retrocedeste, movimentando-se da extremidade motora para a sensorial e atingindo, assim, o sistema perceptivo. Daí o porquê de os traços mnêmicos que fornecem a matéria-prima para o conteúdo manifesto de o sonho serem transpostos para a forma de imagens, adquirindo um caráter alucinatório.

Outro elemento que se funde a essa concepção de que o aparelho psíquico poderia, em alguns casos, ter um funcionamento regressivo é “a concepção de que, com toda a probabilidade, essa regressão, onde quer que ocorra, é efeito da resistência que se opõe ao avanço de um pensamento para a consciência pela via normal, e de uma atração simultânea exercida sobre o pensamento pela presença de lembranças dotadas de grande força sensorial” (FREUD, 1900/1990, p. 501). Essas duas ideias, correlacionadas, permitem a estruturação de um entendimento dos fenômenos tópicos e dinâmicos que compõem o sonho. O sonho será fruto da interposição de forças entre esses sistemas, trazendo a marca e a participação de cada um deles. Posteriormente, Freud mostrará como mecanismos semelhantes operarão para a constituição de outros fenômenos psíquicos, como os sintomas, os chistes, os atos-falhos, a criação artística.

Porém, ainda há um vértice da explicação metapsicológica do sonho que não tratamos de forma mais acurada: o econômico. Afinal, essa energia a que tantas vezes nos referimos como sendo transmitida de um traço mnêmico a outro e como podendo assumir um sentido progressivo ou regressivo dentro do aparelho psíquico refere-se a quê? Para entender melhor esse ponto, precisamos nos deter em outro dos conceitos fundamentais da teoria freudiana: o conceito de instinto ou pulsão.



Muito se discutiu sobre qual a terminologia mais adequada para traduzir o termo *Trieb*. Apesar de preferirmos a tradução por *pulsão*, optamos por utilizar nesse guia de estudos o termo *instinto*, porque usamos nas nossas citações de Freud a Edição Standard Brasileira – que adota este termo – e porque abordaremos em seguida a teoria Kleiniana – e a maior parte dos tradutores de Klein opta pelo termo instinto.

CAPÍTULO 2

O que nos impulsiona – o instinto e seus caminhos

A obra de referência para abordar o conceito de instinto em Freud é *O Instinto e suas Vicissitudes*, de 1915, por isso acompanharemos precipuamente por meio dela as elaborações de Freud sobre esse tema.

Logo no início, Freud retoma o conceito de estímulo, descrevendo-o a partir de sua atuação: um estímulo seria aplicado a um tecido vivo a partir do meio externo e progrediria até gerar uma descarga na forma de uma ação sobre este mesmo meio externo. Esta ação teria como objetivo aliviar o organismo da excitação provocada pelo estímulo. A excitação teria gerado um aumento de energia no organismo, retirando-o de sua situação ideal (que seria a da manutenção de uma quantidade constante de energia). Este aumento geraria uma tensão causadora de desprazer. Daí a necessidade de descarregar tal excitação na forma de uma ação que desse uma resposta ao estímulo provocador. Tal descarga geraria prazer e restabeleceria o equilíbrio no organismo, mantendo a quantidade de energia constante e tendente ao mínimo possível.



Dois princípios fundamentais da faceta econômica de metapsicologia freudiana são enunciados aqui. O primeiro deles é o da ideia da manutenção de uma quantidade constante de energia, e foi denominado por Freud como **Princípio da Constância**. Assim, ele a enuncia: “o sistema é um aparelho que tem por função livrar-se dos estímulos que lhe chegam, ou reduzi-los ao nível mais baixo possível; ou que, caso isso fosse viável, se manteria numa condição inteiramente não-estimulada” (FREUD, 1915/1990, p. 140), tendo, portanto, o sistema nervoso a tarefa de dominar os estímulos. O segundo é o **Princípio do Prazer**, de que já tratamos e que é consequência imediata do primeiro.

O modelo para explicar o funcionamento de um estímulo é o do arco-reflexo, e Freud traz como exemplo a luz forte que incide sobre os olhos de um indivíduo e que o faz desviar o rosto.

Estabelecido esse primeiro parâmetro, Freud levanta a pergunta sobre qual a relação entre estímulo e instinto. Sua primeira colocação será a de que um instinto é um estímulo aplicado à mente. Porém, essa definição não é suficiente, pois se faz necessário distinguir entre o que é um instinto e o que é um estímulo aplicado a mente. Freud, então, traçará a distinção entre os conceitos:

Primeiramente, um instinto não surge do meio externo, mas de dentro do próprio organismo. Isso implica que as ações para o remover envolverão uma complexidade bem maior da que é exigida para lidar com os estímulos. Outro ponto básico é o fato de que o instinto, diferentemente do estímulo, não age como um impacto momentâneo sobre o organismo. Ele atua como um impacto constante! Um impacto constante que parte de dentro do organismo. Portanto, não haveria como fugir dele a partir de uma ação única. Ele se distanciaria mais da experiência de um incômodo e se aproximaria mais da experiência de uma necessidade. E o que elimina uma necessidade é a satisfação. Portanto, lidar com um instinto exigiria ações mais elaboradas do que lidar com um estímulo, pois seria necessário atuar sobre a fonte interna de estimulação.

Eis, então, as características primeiras que Freud estabelece para o instinto:

1. tem uma fonte de estimulação interna;
2. sua força é constante;
3. a resposta para ele não funciona pela via da fuga, mas pela via da satisfação.

Essas características levam-no a conclusão de que são os instintos e não os estímulos que constituem as verdadeiras forças propulsoras dos progressos que conduzem o sistema nervoso a seu alto nível de desenvolvimento. Por isso, Freud envidará mais esforços pra melhor definir o conceito de instinto.

Segundo o pai da psicanálise, *Instinto* seria um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático. Esse caráter fronteiriço do conceito gera dificuldades para que o próprio Freud o caracterize. Ele aparecerá em sua obra como sendo o representante psíquico das excitações que se originariam dentro do organismo e que alcançariam a mente, ele surge como sendo uma força propulsora que catexizaria com certa quantidade de energia psíquica (libido) a ideia a qual estaria ligado (sendo essa ideia o 'representante psíquico' do instinto). Nesse segundo sentido, o instinto estaria sendo considerado como algo não psíquico.

Essas duas concepções permeiam em vários momentos o discurso freudiano, sendo a segunda prevalente em textos mais tardios. Acreditamos, no entanto, que, ao definir os fatores que caracterizam um instinto, Freud materializa o quanto se trata de um conceito limítrofe entre o corpo e a psique, o que justifica a diversidade de funções que vão sendo assumidas por ele nas empreitadas freudianas na busca de explicar os fenômenos psíquicos. Vamos, então, aos fatores que caracterizam o instinto: eles são quatro – pressão, finalidade, objeto e fonte.

A *pressão* corresponderia ao fator motor do instinto – à quantidade de força ou à medida da exigência de trabalho feita à mente. Freud afirma que a característica de

exercer pressão é a própria essência de um instinto. “Todo instinto é uma parcela de atividade” (FREUD, 1915/1990, p. 142)

A *finalidade* de um instinto é sempre a satisfação. Entenda-se por satisfação (de acordo com o que vimos ao discutir os princípios da constância e do prazer) a eliminação do estado de estimulação proveniente da fonte do instinto, ou seja, a resolução da pressão do instinto. Porém, como nem sempre a satisfação direta apresenta-se como via acessível, o instinto pode ir compondo várias combinações ou permutas de finalidades próximas ou intermediárias. Algumas vezes também o instinto pode apresentar-se inibido em sua finalidade. Mesmo nesse caso, Freud considera que haverá certa satisfação parcial.

O *objeto* de um instinto é a coisa por meio da qual ele é capaz de atingir sua finalidade. É o que existe de mais variável em um instinto, não estando originalmente ligada a ele, mas lhe sendo destinada por alguma característica ou situação que a torna adequada à satisfação. Eis um dos desenvolvimentos teóricos mais importantes do pensamento freudiano. Em seu *Três ensaios sobre a Teoria da Sexualidade*, Freud demarca o fato de que os instintos sexuais, diferentemente das outras formas de estimulação, têm a capacidade de variar seus objetos. Essa característica é o que faz com que a energia proveniente desses instintos esteja na base das mais diversas realizações humanas, inclusive as que são tidas como sublimes. Sobre o objeto do instinto, Freud (1915, p. 143) esclarece:

O objeto não é necessariamente algo estranho: poderá igualmente ser uma parte do próprio corpo do indivíduo. Pode ser modificado quantas vezes for necessário no decorrer das vicissitudes que o instinto sofre durante sua existência, sendo que esse deslocamento do instinto desempenha papéis altamente importantes. Pode acontecer que o mesmo objeto sirva para a satisfação de vários instintos simultaneamente [...].

Interessante observar que para Freud, inclusive, uma ligação particularmente estreita do instinto com um objeto específico pode se apresentar como desfavorável ao indivíduo. Essa situação, que Freud denomina como fixação, por vezes pode acontecer no percurso inicial do desenvolvimento de um instinto, pondo fim a sua mobilidade – fenômeno vinculado à escolha da neurose e ao desenvolvimento dos sintomas.

Por fim, Freud aborda a *fonte* do instinto. Ela se referiria ao processo somático que ocorreria num órgão ou em uma parte do corpo, dando origem ao estímulo que será representado na vida mental. O estudo da fonte do instinto não seria da alça da psicanálise, por isso não há aprofundamento neste tema.

Em *Os instintos e suas vicissitudes*, Freud proporrá a divisão dos instintos em dois grupos: os instintos do ego (ou de autopreservação) e os instintos sexuais. Esse formato dual de classificar os instintos é extremamente necessário à maneira como Freud abordará

os fenômenos psíquicos a partir de sua faceta dinâmica, pois sua proposta é a de forças que se contrapõem e, por vezes, se combinam para definir o acesso à consciência e, portanto, à satisfação. Nesse momento da teorização freudiana, os instintos sexuais surgem como assumindo, em determinadas circunstâncias, uma posição que se choca com os instintos do ego, tendo, por isso, sua via direta à satisfação inibida – o que os redirecionaria para outras vicissitudes. Posteriormente, porém, Freud reconhecerá os instintos do ego como integrando o grupo dos instintos sexuais. Sua proposta dualista progredirá até assumir o formato de uma contraposição entre instintos de vida e instintos de morte. Não acompanharemos, no entanto, este desenvolvimento, pois ele extrapola os objetivos a que nos propomos nesta exposição. Retomemos, portanto, a questão das vicissitudes dos instintos.

Freud dará seguimento à sua exposição sobre os instintos focalizando suas observações nos instintos sexuais, pois sua experiência clínica os teria revelado como estando na base das psiconeuroses – mas não só! Eles surgirão como propulsores dos mais diversos fenômenos psíquicos. Em sua síntese sobre o tema, Freud destaca o fato de que eles são numerosos e provêm de uma grande variedade de fontes orgânicas. Atuam de início independentemente uns dos outros, alcançando uma síntese mais ou menos completa apenas numa etapa posterior do desenvolvimento. A finalidade pela qual cada um deles luta é a consecução do ‘prazer do órgão’. Porém, quando a síntese for alcançada, eles estarão a serviço da função reprodutora.

Figura 5. Nicoletta Cecoli.



Fonte: <hero://www.kaifineart.com/2014/01/nicoletta-Cecilia.html?m=1>.

Os instintos sexuais surgiriam ligados aos instintos de autopreservação, ancorados nestes últimos. Gradativamente, no entanto, vão se separando deles. Mas essa ligação inicial deixa suas marcas, pois, na escolha objetual, os instintos sexuais iniciariam sua jornada seguindo os caminhos indicados pelos instintos do ego. Sobre isso, Freud (1915/1990, p. 147), inclusive, ressalta:

Parte deles permanece associada aos instintos do ego pela vida inteira, fornecendo-lhes componentes libidinais, que no funcionamento normal, escapam à observação com facilidade, só sendo revelados de maneira clara no início da doença. Distinguem-se por possuírem em ampla medida a capacidade de agir vicariamente uns pelos outros, e por serem capazes de mudar prontamente de objetos. Em consequência dessas últimas propriedades são capazes de funções que se acham muito distantes de suas ações intencionais originais – isto é, capazes de “sublimação”.

Sublimação é uma das vicissitudes dos instintos estudada por Freud. Além dela, neste momento ele fala de mais três:

1. A reversão ao seu oposto;
2. Retorno em direção ao próprio eu do indivíduo; e
3. Repressão.



Sublimação – “Processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem qualquer relação aparente com a sexualidade, mas que encontrariam o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Freud descreveu como sublimação principalmente a atividade artística e a investigação intelectual”. Klein utilizará esse conceito de forma mais expandida, entendendo-o como a capacidade de empregar uma quantidade de libido supérflua no investimento das tendências do ego. Dessa forma, a sublimação atuaria já no princípio do desenvolvimento do ego, quando a libido, por meio de um processo de simbolização, emprestaria sua energia para o desenvolvimento das primeiras atividades do indivíduo (o falar e o movimentar-se). Para saber mais consulte o verbete “Cena Originária ou Protocena” no *Vocabulário de Psicanálise*, (Laplanche e Pontalis, 1983, p.638).

Escolhemos entre estas vicissitudes a repressão como aquela de que trataremos mais detalhadamente nesse guia de estudos. Isso por entendemos que as observações tópicas,

dinâmicas e econômicas que Freud realiza acerca de tal fenômeno ocupam grande importância no discurso freudiano acerca das formações do inconsciente, compondo a tessitura da teórica da psicanálise. Antes, no entanto, vamos focalizar outro conceito que consideramos importante para entendê-la melhor: a concepção de realidade psíquica.

CAPÍTULO 3

Realidade psíquica: o mundo pelo olhar da fantasia

Entre os derivados dos impulsos instintuais do Inconsciente Freud aborda as fantasias. Elas são fundamentais no arcabouço teórico da psicanálise, por isso, as abordaremos mais detidamente.

Em 1915, Freud fala das fantasias como estruturas altamente organizadas e livres de autocontradições, tendo todas as qualidades de uma estrutura pré-consciente, apesar de pertencerem factualmente ao inconsciente. Sua origem, no entanto, decide seu destino. Assim, embora altamente organizadas, elas se mantêm reprimidas. “Aproximam-se da consciência e permanecem imperturbadas enquanto não dispõem de uma catexia intensa, mas, tão logo excedem certo grau de catexia, são lançadas para trás” (FREUD, 1915/1990, p. 219). As fantasias estão nas etapas preliminares da formação tanto dos sonhos como dos sintomas. Estão também na base de outras formações substitutivas que, em condições favoráveis, conseguem emergir a consciência.

Já em *A Interpretação dos Sonhos*, Freud falará sobre elas, descrevendo-as como fachadas psíquicas erigidas para bloquear o acesso do sujeito a lembranças da cena originária. Ele toma como modelo os devaneios (ou sonhos diurnos) para perscrutar a estrutura das fantasias, afirmando que, tal como há fantasias conscientes – os devaneios –, há, também, grande número de fantasias inconscientes (que assim permanecem por causa de seu conteúdo e por se originarem de material recalçado).

Estas fantasias, assim como os sonhos, são realizações de desejos e se constroem, em grande medida, tendo como material as impressões de experiências infantis. Elas também se beneficiam de um grau de relaxamento da censura. Examinando sua estrutura, é possível perceber que o motivo de desejo que impulsiona sua produção mistura, reorganiza e modela o material que as constitui em um novo formato. As fantasias “estão, para as lembranças infantis de que derivam exatamente na mesma relação em que estão alguns dos palácios barrocos de Roma para as antigas ruínas cujos pisos e colunas forneceram o material para as estruturas mais recentes” (FREUD, 1900/1990, p. 454).

É interessante observar que Freud vai determinar uma importância significativa para as fantasias. Não são lembranças que estão na origem da formação de sonhos e sintomas neuróticos, mas fantasias plenas de desejos. Este fato indica que uma produção psíquica, por si só, é capaz de exercer efeito sobre o real do corpo e atribui às formações

imaginárias do humano um papel fundamental na compreensão do psiquismo. É reconhecida, portanto, a profunda influência que as fantasias exercem sobre a vida anímica humana. Assim como, os derivados das fantasias passam a ser reconhecidos como fontes de conhecimento do Inconsciente humano. Daí porque, na psicanálise, este espaço da fantasia vai ser valorizado, afinal ele pode não ser realidade material (lembrança), mas é realidade psíquica – é ficção com efeito de verdade.

Importante lembrar que Freud não abandona o desejo de encontrar “no final do novelo” – ou seja, no final da história do sujeito – uma ponta de real. Ele defenderá, inicialmente, que as fantasias são estruturadas em cima de lembranças da infância. No avanço de sua escuta clínica, porém, cada vez mais percebe a dificuldade de retomar a realidade factual de tais lembranças. Para dar conta desse entrave teórico, compõe a noção de fantasias originárias. Estas fantasias retirariam sua matéria prima de uma cena primária mítica, capaz de ser reconstituída apenas em alguns fragmentos de impressões infantis. Já em suas obras finais, Freud desloca suas tentativas de resposta a esse problema do patamar ontogenético para o filogenético, teorizando que as fantasias originárias seriam baseadas em vivências ocorridas com os nossos ancestrais que teriam sido transferidas ao longo das civilizações por meio de estruturas como as fantasias, mitos, contos de fadas.

Importante ressaltar que o fato de as fantasias assumirem um estatuto diferenciado a partir do discurso psicanalítico, não quer dizer que Freud negue o caráter ilusório dessas construções. Ao contrário, ele as aponta como um espaço de refúgio para onde os homens por vezes se dirigem ao se depararem com a realidade frustradora. A questão é que o estudo das fantasias – que, no princípio, surgiu vinculado à análise de neuróticos, mostrou-as como capazes de atuar enquanto forças reais, pelo menos no nível do psiquismo, o que levou Freud a conceber a ideia de uma realidade psíquica: “Se olharmos para os desejos inconscientes, reduzidos a sua expressão mais fundamental e verdadeira, teremos de concluir, sem dúvida, que a realidade psíquica é uma forma especial de existência que não deve ser confundida com a realidade material” (FREUD, 1900/1990, p. 560).

Com a ideia de realidade psíquica, Freud teria buscado dar expressão à descoberta de que, mesmo sendo reconhecidas como ilusões, as fantasias com as quais havia se deparado em sua escuta clínica mostravam possuir com a realidade relações bem mais complexas do que a de antítese tradicionalmente destacada pela psicologia acadêmica – e, portanto, podiam se constituir como objetos dignos de exploração pela psicanálise, que busca assumir uma atitude diversa do “desprezo de nosso mundo corriqueiro – com sua riqueza de valores materiais – pelo que é simplesmente pensado ou desejado” (FREUD, 1913 [1912-1913] /1990, p. 190).

Assim, na medida em que o estudo dos neuróticos vai mostrando que o mundo das fantasias pode ser o ponto de partida para o desencadeamento de emoções reais (atuantes sobre os corpos e sobre as vidas desses indivíduos), torna-se imprescindível para o entendimento do psiquismo humano atentar para ele. Freud afirma a partir de suas escutas: “O que jaz por trás do sentimento de culpa dos neuróticos são sempre realidades *psíquicas*, nunca realidades *concretas*. O que caracteriza os neuróticos é preferirem a realidade psíquica à concreta, reagindo tão seriamente como as pessoas normais às realidades” (FREUD, 1913 [1912-1913]/1990, p.188 e 189). E ainda: a “distinção [entre evento real e evento pensado], que poderia parecer fundamental para outras pessoas, a nosso ver não afeta o âmago da questão” (FREUD, 1913 [1912-1913]/1990, p. 190).

As afirmações deixam claro o papel fundamental que Freud atribuía à realidade psíquica, tomando-a como alvo das pesquisas psicanalíticas e reconhecendo sua posição na base de uma série de eventos psíquicos. Essa é uma ideia que Freud vai retomar muitas vezes. No que diz respeito às neuroses, por exemplo, ele afirmará isso com relação às fantasias histéricas, ao colocar em *Totem e Tabu* que: “O que os histéricos repetem em suas crises e fixam por meio dos sintomas são experiências que ocorreram daquela forma apenas em sua imaginação – embora seja verdade que, em última instância, essas experiências imaginadas remontem a acontecimentos reais, ou sejam neles baseadas” (FREUD, 1913 [1912-1913]/1990, p.109).

Na mesma obra, traz o entendimento de que o sentimento de culpa que levava os obsessivos a se impingirem tantas restrições e expiações em forma de rituais teriam, em suas origens, apenas intenções, impulsos ou desejos de realizar atos criminosos. Nunca se encontravam atos reais que justificassem tal sentimento.

Laplanche e Pontalis (1988) apontam para o fato de que a realidade psíquica não deve ser tomada como a totalidade do que é subjetivo. Para Freud, todos os pensamentos intermediários e de transição que partem dos desejos inconscientes e vão sofrendo elaborações no aparelho psíquico não recebem esse estatuto de realidade psíquica, atribuído apenas aos desejos inconscientes e às fantasias que os encenam. Logo, os autores distinguem a existência de três tipos de realidade no discurso freudiano: a realidade material, a realidade psíquica e a realidade psicológica (referente aos pensamentos de transição), sendo que essa última não possuía de fato um estatuto de realidade, mas se constituía como via de acesso à realidade psíquica. E a realidade psíquica, por sua vez, teria um caráter heterogêneo, não sendo resultante de uma produção espontânea da imaginação do indivíduo, mas devendo comportar sempre alguma determinação externa, sem, no entanto, confundir-se com tal determinação.

As fantasias, portanto, adquiriram importância como objetos de pesquisa e peças fundamentais para a compreensão da vida anímica não só devido ao fato de se ter reconhecido sua atuação como realidade psíquica na determinação das mais diversas produções humanas, mas também pelo fato de preservarem em si elementos a partir dos quais seria possível recuperar parte da história não apenas dos indivíduos (como fatos que marcaram seu desenvolvimento mental), mas da própria humanidade.

A Repressão



Repressão refere-se ao conceito freudiano de *Verdrängung*. Segundo Hanns, o “termo no alemão coloquial implica ‘empurrar de lado’ (livrar-se de) um incômodo, o qual permanece próximo ao sujeito, pressionando pela volta. O foco do termo ‘reprimir’ em português é sobre o esmagamento ou supressão de uma manifestação ameaçadora. O termo germânico enfatiza o afastamento de incômodo” (Hanns, 1996, p.359). Portanto, o termo português *repressão* leva a certa perda das conotações que podem ser assumidas pelo termo *Verdrängung*. Por outro lado, o termo *recalque* caiu em desuso no português. “Na prática dos falantes do português atual, ‘recalque’ é quase como se fosse um termo cunhado exclusivamente para o uso da psicanálise” (Hanns, 1996, p. 358). Apesar de nossa preferência pelo uso da tradução *recalque*, manteremos o termo adotado na Edição Standard Brasileira, que escolhemos para ser a base deste guia de estudos, com o intuito de facilitar o entendimento dos alunos.

Para entender melhor a repressão, retomemos alguns movimentos conceituais empreendidos por Freud em *O Inconsciente*, de 1915. Nesta obra, Freud relata que um ato psíquico passa por duas fases com relação ao seu estado, entre elas se interpõe uma espécie de teste, que funciona como censura. Na primeira fase, o ato psíquico pertence ao sistema inconsciente. Caso seja rejeitado pela censura, não recebe a permissão para progredir para a segunda fase, e fala-se que ele foi reprimido, tendo que permanecer inconsciente. Porém, se passar no teste, entrará na segunda fase e ingressará em outro sistema, o sistema pré-consciente. Mas o fato de estar nessa segunda fase não implica que tenha se tornado um ato consciente. Ainda não é consciente, permanece latente, mas agora já é capaz de, sob certas condições, tornar-se consciente sem quaisquer resistências especiais.

Assim, na visão da psicanálise, para compreender um ato psíquico é preciso saber explicar a qual sistema ele pertence e quais as composições de forças que atuaram para que ele ali esteja. A próxima pergunta que Freud tentará responder é o que poderia ser

abarcado pela categorização de ato psíquico inconsciente. Sobre as ideias, muito já teria sido dito. Mas, e os instintos? E as emoções e sentimentos?

Com relação aos instintos, Freud afirmará claramente que um “instinto nunca pode tornar-se objeto da consciência – só a ideia que o representa pode. Além disso, mesmo no Inconsciente, um instinto não pode ser representado de outra forma a não ser por uma ideia” (FREUD, 1915, p. 203). Um instinto só se dá a conhecer quando se prende a uma ideia ou a um estado afetivo. A não ser assim, nada dele será conhecido. Portanto, os elementos que podem ser adjetivados como inconscientes e que sofrem o processo de repressão serão ou o representante ideacional do instinto ou o afeto que está inicialmente ligado a este representante.

Já comentamos sobre os representantes ideacionais. Com relação aos afetos, Freud descreve outro quadro, pois que eles teriam ligação com o fator quantitativo dos impulsos instintuais. Segundo ele, três seriam os caminhos que os afetos poderiam percorrer na travessia dos sistemas:

1. O afeto permaneceria, no todo ou em parte, como é;
2. O afeto seria transformado em uma quota de afeto qualitativamente diferente (principalmente em ansiedade);
3. O afeto seria suprimido e impedido de se desenvolver.

O primeiro caminho (permanecer como é) ocorreria nas situações em que o afeto é aprovado pela censura. O último (ser suprimido) seria a verdadeira finalidade da repressão. Essa finalidade, no entanto, nem sempre é alcançada, dando origem ao segundo caminho (transformação em ansiedade).

Freud ressalta ainda que o resultado da repressão sobre os afetos não é o mesmo daquele que ocorre no campo das ideias, pois essas continuam a existir como estruturas reais no sistema Inconsciente, enquanto que os afetos suprimidos restam como inícios potenciais de descarga impedidos de se desenvolver.

Para Freud, tais discussões conceituais têm a importância fundamental de desvelar que a repressão pode conseguir inibir a expressão afetiva de um instinto, impedindo-o de se transformar numa manifestação de afeto. Isso deixaria à mostra a importância da repressão, esclarecendo que ela opera não somente retendo ideias provenientes do Inconsciente, mas também cerceando o desenvolvimento do afeto e o desencadeamento da atividade muscular.

A repressão opera uma ruptura entre o afeto e a ideia a qual ele pertence. E, por vezes, para dar seguimento ao seu desenvolvimento, este afeto irá se ligar a outra ideia substituta, que possa se tornar consciente. A natureza desta ideia substituta consciente determinará o caráter qualitativo do afeto. Também é possível que o afeto proceda diretamente do sistema Inconsciente – situação em que ele sempre acaba por assumir a natureza de ansiedade (pela qual são trocados todos os afetos reprimidos).

Freud (1915, p. 213 - 214), então, pode definir melhor:

O núcleo do *Ics.* consiste em representes instintuais que procuram descarregar sua catexia; isto é, consiste em impulsos carregados de desejo. (...) As intensidades catexiais [no *Ics.*] são muito mais móveis. Pelo processo de *deslocamento* uma ideia pode ceder à outra toda a sua quota de catexia; pelo processo de *condensação* pode apropriar-se de toda a catexia de várias outras ideias. Propus que esses dois processos fossem considerados como marcos distintivos do assim denominado *processo psíquico primário*. (...) Resumindo: *a isenção de contradição mútua, o processo primário* (mobilidade das catexias), *a imtemporalidade e a substituição da realidade externa pela psíquica* – tais são as características que podemos esperar encontrar nos processos pertencentes ao sistema *Ics.*

Já no sistema pré-consciente, impera o processo secundário. Portanto, a passagem da catexia de uma ideia para outra ocorre de forma diferente, bem mais restrita, dando um tom diverso aos processos de deslocamento e condensação. Cabe, também, ao sistema pré-consciente efetuar a comunicação entre os conteúdos ideacionais, para que eles possam influenciar uns aos outros, recebendo uma ordenação temporal, sendo testados com relação à possibilidade e às consequências de sua expressão na realidade (teste de realidade) e submetendo-se à censura, que definirá seu desenvolvimento.

Chegado esse momento, podemos fazer afirmações mais precisas sobre o conceito de repressão. Freud explica que a repressão ocorre quando a satisfação da finalidade de um instinto gera prazer em um lugar e desprazer em outro. Portanto, para ocorrer uma repressão, seria necessário que a força do desprazer superasse a do prazer. Afirma ainda que “a essência da repressão consiste simplesmente em afastar determinada coisa do consciente, mantendo-a a distância” (FREUD, 1915/1990, p. 170). Ainda que Freud venha a acrescentar elementos a essa definição, pode-se dizer que a ideia da repressão como uma retirada da catexia consciente permanece como centro do entendimento deste mecanismo.

Outro ponto que Freud vai levantar é que existiria um primeiro momento em que seria negada a entrada no Consciente do representante psíquico do instinto. Assim, gerar-se-ia, no Inconsciente, uma fixação que manteria a ideia inalterada, permanecendo o instinto ligado a ela. Esse momento primeiro Freud o denomina de *repressão primeva*. E só após é que aconteceria a *repressão propriamente dita*.

A repressão propriamente dita atingiria os derivados mentais do representante reprimido – ou seja, a cadeia de pensamentos que, em algum momento, foi associada a tal representante e que, por isso, sofreu o mesmo destino. Assim, na repressão atua uma conjugação de forças que partem não apenas sentido Consciente – Inconsciente, mas o que foi primevamente reprimido também exerce atração sobre seus derivados mentais.

Partindo disso, Freud ressalta o fato de que o representante instintual e seus derivados continuam a existir no Inconsciente, organizam-se ainda mais e continuam estabelecendo vinculações. São as fantasias, que proliferam desinibidamente quando a repressão as retira da influência consciente. Na medida em que tais derivados do representante reprimido tornam-se mais distantes dele, por meio de diversas distorções, eles podem acabar por obter acesso ao Consciente. Esse fato é o que permite a Freud (1915/1990, p. 173) explicar como funciona a técnica da análise:

Ao executarmos a técnica da psicanálise, continuamos exigindo que o paciente produza, de tal forma, derivados do reprimido, que, em consequência de sua distância no tempo, ou de sua distorção, eles possam passar pela censura do consciente. Na realidade, as associações que exigimos que o paciente fizesse sem sofrer a influência de qualquer ideia intencional consciente ou de qualquer crítica, e a partir das quais reconstituímos uma tradução consciente do representante reprimido – essas associações nada mais são do que derivados remotos e distorcidos desse tipo. No correr desse processo, observamos que o paciente pode continuar a desfiar sua meada de associações, até ser levado ao encontro de um pensamento, cuja relação com o reprimido fique tão óbvia, que o force a repetir sua tentativa de repressão. Também os sintomas neuróticos devem satisfazer a essa mesma condição, já que são derivados do reprimido, o qual, por intermédio deles, finalmente teve acesso à consciência, acesso este que anteriormente lhe era negado.

Freud adentra desta forma em um ponto que é fundamental na teoria psicanalítica: o surgimento de derivados do conteúdo que foi alvo da repressão. São as formações do inconsciente, resultantes do retorno do reprimido. Freud estudará cada uma dessas

formações, buscando tecer uma rede conceitual forte o suficiente para sustentar sua metapsicologia.

Assim é que, em *A Interpretação dos Sonhos*, Freud desvela os mecanismos oníricos. Em *A Psicopatologia da Vida Cotidiana*, ele trata dos atos-falhos. Em *Os chistes e sua relação com o Inconsciente*, aborda os ditos cômicos. Em *Personagens Psicopáticos no Palco e Escritores Criativos e Devaneios*, fala dos fenômenos estéticos. Em *O Mal-estar na Civilização*, encontramos elaborações sobre a cultura e a religião. E em seus estudos clínicos, coloca o foco sobre a formação dos sintomas. Na verdade, esse serão temas que estarão recorrentemente em toda a sua obra.

Sonhos, chistes, arte, atos-falhos, sintomas: derivados do reprimido. Cada fruto de um tipo específico de mecanismo de distorção. Conseguindo obter distância suficiente do conteúdo inconsciente para conseguir – e a partir de uma intensificação de sua catexia – eles obtêm entrada para a Consciência. Desta maneira, Freud denuncia que as produções mais elevadas dos seres humanos provêm dos mesmos instintos primitivos que originam produções que a humanidade rechaçou (e das quais se envergonhou).

Importante destacar que Freud diferencia os mecanismos implicados na repressão daqueles que operariam para a formação de substitutos. Portanto, o retorno do reprimido não seria um processo inverso ao processo da repressão. Poderiam influir para seu desencadeamento tanto:

- » um aumento no esforço de pressão instintual como;
- » um estímulo gerado por uma experiência recente que, por sua estrita semelhança com o material reprimido, despertaria este último (GARCIA-ROZA, 2009, p. 166).

Como dissemos cada tipo de formação substitutiva teria um processo de construção que lhe seria peculiar. Não é objetivo do presente estudo expor cada um desses tipos. Mas consideramos interessante, a título de exemplificação, abordar ao menos um deles: o sintoma. A escolha se deve ao fato de ser o sintoma entre as *formações de compromisso* aquele que tem uma das vinculações mais diretas com o fazer clínico. Além disso, o próprio Freud o elege, em seus artigos metapsicológicos, para elucidar os mecanismos de retorno do reprimido.

Mas o sintoma não é redutível a apenas uma maneira de manifestação. Assume feições diferentes a depender do quadro clínico. Faremos, então, outra seleção. Abordaremos a explicação freudiana do sintoma na neurose de ansiedade – até porque ele toma esta explicação como ponto de partida para o entendimento de outros tipos de sintomas.

Freud, em *O Inconsciente* (1915), descreve o processo de formação do sintoma na neurose de ansiedade como se constituindo de três etapas:

Na primeira fase, o representante psíquico inconsciente de um instinto faz pressão para adentrar no Pré-consciente. Tal pressão faz com que o Pré-consciente dirija uma catexia para este representante. No entanto, trata-se de um impulso que, se persistir em seu desenvolvimento, pode ser ameaçador para o ego, pelo seu potencial de gerar sentimentos de culpa ou dor para além de uma possível satisfação. Assim, a possibilidade de sua emergência causar, também, desprazer faz com que o Pré-consciente retire dele sua catexia. Este ato psíquico faz com que ocorra uma cisão entre o representante ideacional e o afeto que a ele se vinculava. A ideia permanece no Inconsciente, ao passo que o afeto, dela desligado, segue percurso, sendo descarregado sob a forma de ansiedade. É por isso que o indivíduo experimenta apenas o medo, sem saber, no entanto, o que teme.

Lembramos nesse ponto que a repressão de uma ideia não faz com que ela desapareça. Ela continua exercendo seus efeitos a partir do inconsciente. Assim, se ocorrer um dos motivos que citamos acima como ocasionadores do retorno do reprimido, o aparelho psíquico se põe em ação para evitar novo avançar da ansiedade. Na segunda fase do processo, o pré-consciente catexizará uma ideia substitutiva que, de um lado, se relacione por associação à ideia reprimida e, de outro, escape à repressão, pois que já está suficientemente distância daquela ideia.

Desta forma, tal ‘substituto por deslocamento’ passa a ser ferramenta de uma anticatexia do Pré-consciente que impede a aparição do representante reprimido. O preço pago, no entanto, é o fato de que essa nova ideia substitutiva passa a ser desencadeadora de ansiedade – pois tal afeto, que antes emergira sem estar ligado a qualquer ideia, é a ela vinculado.

Um ponto a mais é que o enfraquecimento desta anticatexia pré-consciente seria um terceiro motivo para o retorno do reprimido (GARCIA-ROZA, 2009, p. 166). Levando em conta tal fato, Freud frisar que, para manter a repressão, o aparelho psíquico tem um gasto energético constante. Este é um dos motivos pelos quais trazer o conteúdo reprimido para a consciência implicaria em uma economia importante de energia.

Na terceira e última fase do processo, o aparelho psíquico empreenderia mais um ato, desta vez para impedir o desenvolvimento da ansiedade desencadeada pela ideia substituta. Para isso, o pré-consciente catexizaria gradativamente todo o ambiente que de alguma forma se associasse ao representante substitutivo. Objetivo? Fazer com que qualquer caminho que pudesse levar à ativação deste representante funcionasse como sinal de alerta de sua presença, para que uma fuga fosse empreendida antes de sua aparição.

Mas não só. O que se observa aqui é uma repetição da segunda fase, na medida em que o pré-consciente tenta se defender da ansiedade desencadeada pela ideia substitutiva com a catexia do ambiente que a envolve. Assim é que, por fim, vão aumentando cada vez mais a quantidade de estímulos capazes de desencadear a ansiedade. Freud (1915/1990, p. 211) descreve o seguimento deste processo da seguinte forma:

A cada aumento da excitação instintual, a muralha protetora em torno da ideia substitutiva deve ser deslocada um pouco mais para fora. A totalidade dessa construção, que é erigida de forma análoga nas demais neuroses, denominamos fobia. A fuga de uma catexia consciente da ideia substitutiva se manifesta nas evitações, nas renúncias e nas proibições, por meio das quais reconhecemos a histeria de ansiedade. (...) Nesse processo, a repressão é bem sucedida num ponto particular: a liberação da ansiedade pode até certo ponto ser represada, mas somente à custa de um pesado sacrifício da liberdade pessoal.

Para encerrar nossa exposição do desenvolvimento do sintoma em uma neurose de ansiedade, peguemos o caso clínico que Freud cita em *Repressão* (1915). Trata-se do relato da análise de um paciente de Freud que foi utilizado para compor seu estudo clínico *O Homem dos Lobos*.

Freud constata que, inicialmente, quando menino, o paciente manifestara um impulso instintual amoroso com relação ao pai que, ao mesmo tempo, era acompanhado pelo medo deste. O representante ideacional do impulso foi retirado do pré-consciente, e o afeto de ansiedade se ligou, por associação, a uma ideia substituta. A criança passou, assim, a temer lobos, ao invés de temer o pai. Percebe-se, portanto, que o processo de repressão na origem da fobia animal do paciente não alcança êxito, pois falha em impedir o desencadeamento da ansiedade. Por isso, o trabalho da repressão continua, partindo para uma nova fase. “O que se segue é uma tentativa de fuga – com a formação da fobia propriamente dita, de um grande número de evitações destinadas a impedir a liberação da ansiedade” (FREUD, 1915/1990, p. 179).

Encerramos, com este exemplo, a parte de nosso guia de estudos referente à psicanálise em Freud. Aqui, expusemos alguns conceitos que ajudarão muito aqueles que pretenderem aprofundar suas leituras do texto freudiano. Partamos agora para explorar as ideias de Melanie Klein – outro nome importante para o desenvolvimento das ideias psicanalíticas.

OS CAMINHOS DE KLEIN E O SURGIMENTO DA ANÁLISE LÚDICA

UNIDADE III

Neste módulo, faremos uma retomada histórica de como Klein compôs a psicanálise de crianças, encerrando com a caracterização da prática que emerge de tal processo.



Você deve chegar ao final compreendendo:

- » Porque Klein se desloca da educação psicanalítica para a psicanálise de crianças;
- » O que Klein teoriza sobre o brincar infantil e como ela sustentará uma prática clínica baseada neste brincar;
- » O conceito de *Transferência* para Klein: suas originalidades e discordâncias com relação ao conceito freudiano.

CAPÍTULO 1

Klein e seu encontro com a teoria psicanalítica

Melanie Klein nasceu em 1882, na cidade de Viena. Havia dois pontos em comum entre ela e Freud: ambos eram de origem judia e conviveram com os discursos sobre saúde e doença na passagem do século XIX para o século XX, pois o pai de Melanie era médico. É preciso destacar que, apesar de sua família ser proveniente de um meio judeu ortodoxo, havia, naquele ambiente, o germe de um questionamento crítico que se deslocava do discurso religioso para o científico como via alternativa de pensar o mundo. Prova disso é que o pai de Melanie, que estava destinado a tornar-se rabino, rompe com esse caminho para abraçar a medicina.

Outro fato que chama a atenção na biografia de Melanie Klein é a figura da sua mãe como uma mulher com atitudes vanguardistas, pois, ao contrário do que se esperava da mulher de um médico na Viena de então – que se ocupasse com o espaço doméstico e com os filhos –, a mãe de Melanie abre um pequeno comércio e passa a trabalhar para ajudar o marido com as despesas da casa.

Todo esse ambiente, que propicia um pensamento questionador e que estimula a ocupação feminina do espaço público, será fundamental para que Melanie Klein empreenda o percurso de trabalho que a fará um dos principais nomes da Psicanálise.

Há, ainda, dois acontecimentos marcantes na vida da pequena austríaca que também influenciarão os desenvolvimentos futuros de seus trabalhos. Em 1886, quando Melanie estava com quatro anos, sua irmã Sidonie (de oito) adoece gravemente. A enfermidade faz com que Sidonie fique acamada e, posteriormente, restrita ao espaço doméstico. Esse fato favorece que a educação e os cuidados com Melanie fiquem sob o encargo da irmã mais velha. Forma-se, entre elas, um forte vínculo afetivo, por onde perpassam as vivências de aprendizado de Melanie. É nesse momento que ela adquire a linguagem escrita, a leitura e noções básicas de cálculo. Em 1887, Sidonie falece – fato que deixa profundo traço na história de Melanie.

Mas, além de Sidonie, haverá outra figura importante para a formação do pensamento de Melanie nesses primeiros anos: seu irmão mais velho, Emmanuel. Tratava-se de um jovem talentoso, pianista e escritor esporádico, que tinha grande afeição pelas artes. Ele introduz Melanie ao meio intelectual de Viena e assume a preparação da jovem para o concurso de entrada no Ginásio (única escola que forma moças para ingressar na Universidade). Graças às lições de Emmanuel, Melanie é bem-sucedida no concurso. O irmão não esconde seu entusiasmo pela inteligência da jovem e continua a estimulá-la em suas empreitadas intelectuais.

Emmanuel, porém, sofria, desde tenra idade, de sérios problemas cardíacos. E veio a falecer em 1902, aos 25 anos. Essa é mais uma experiência de luto que marca a biografia da Psicanalista.

Nesse momento da vida, Melanie tinha como pretensão ingressar na faculdade de Medicina. A intenção, no entanto, não se concretiza. Casa-se em 1903, com o engenheiro químico Arthur Klein (de quem era noiva havia três anos) e abandona o nome de solteira – Melanie Reizes –, adotando o nome com o qual se consagraria na psicanálise: Melanie Klein.

Com o casamento, Melanie Klein passa a acompanhar o marido por diversas localidades da Europa. Em 1904, nasce sua primeira filha – Mellita. Depois, seguem-se Hans, em 1907, e Erich, o caçula, em 1914.

Alguns anos antes da Primeira Guerra Mundial, a família se estabelece em Budapeste. É nessa cidade que Melanie Klein fará sua entrada no mundo psicanalítico. É aí que, pela primeira vez, ela lerá a produção escrita de Freud. É aí também que iniciará sua análise pessoal, por volta de 1916, e assistirá ao Congresso de Psicanálise de Budapeste, em 1918. Terá, então, a oportunidade de ver Freud ministrar sua conferência “Linhas de Progresso da Terapia Psicanalítica”, e se encantará com a sensibilidade profunda que seu analista, Sándor Ferenczi, demonstra para com as questões do inconsciente.

Pois bem, não podemos deixar de destacar que a entrada de Ferenczi no círculo de discípulos de Freud ocorreu com a leitura, em 1908, no Congresso de Salzburg, de um artigo intitulado “Psicanálise e Pedagogia”, que levantava a questão de quais ensinamentos práticos a Psicanálise poderia oferecer, a partir de suas observações, à Pedagogia.



Sándor Ferenczi nasce em 1873, na Hungria. Forma-se em Medicina no ano de 1894, em Viena. E, em 1897, começa a trabalhar no Hospital Saint Roch, em Budapeste, tornando-se psiquiatra. No enfrentamento do sofrimento psíquico, busca tratamentos alternativos, que dessem melhores respostas aos desafios que enfrentava em sua clínica. É assim que, em 1908, conhece Freud e a Psicanálise. Desde então, passa a ser um discípulo dedicado da causa psicanalítica, tendo importante papel no desenvolvimento do movimento. Torna-se amigo íntimo de Freud, funda, em 1909, a Associação Psicanalítica Internacional (incumbida de defender a invenção freudiana) e promove várias reuniões científicas para discutir temas cruciais à Psicanálise. Sua participação no movimento psicanalítico também ocorre por realizar a análise de alguns dos mais importantes psicanalistas da história da Psicanálise – entre eles Ernest Jones, Geza Roheim e Melanie Klein. Suas propostas teóricas e técnicas vieram a influenciar bastante o pensamento kleiniano.

Esse fato adquire sua importância na medida em que a entrada de Melanie Klein na Psicanálise dá-se não pela via da escuta clínica, mas pela da Pedagogia. A primeira comunicação de Melanie Klein, feita à Sociedade Húngara de Psicanálise, em 1919, expõe suas ambições pedagógicas. Nela, defende, entusiasticamente, uma educação psicanalítica, que libere a criança da repressão, permitindo que desenvolva suas teorias sexuais infantis e impedindo, assim, uma inibição intelectual.

A comunicação – que, em 1921, se tornará artigo – conta a experiência de Melanie Klein com a educação psicanalítica de Fritz, uma criança de 4 anos e nove meses que ela acompanhara por três meses. Fritz era, na verdade, seu filho mais novo, Erich, a quem Klein considerara mais lento em suas curiosidades e aquisições intelectuais do que seus dois outros filhos. Como Petot (2008, p. XXIII) bem expõe, a busca de Melanie Klein nesse momento é marcadamente profilática e pedagógica:

[...] A miséria da qual quer aliviar seu filho não é um sofrimento sexual e atual, mas a falta intelectual e simplesmente potencial: procura, antes de nada, protegê-lo de todo risco de inibição intelectual, dando-lhe uma educação baseada nas ideias psicanalíticas da época; crê, de natureza, poder assegurar-lhe a plena utilização de suas faculdades intelectuais, no quadro de uma normalidade entendida como reunião de todos os talentos e de todas as aptidões funcionando sem entraves. Com este objetivo, procurou liberar a criança ao máximo e, liberá-la da repressão da curiosidade sexual, considerada como fonte de todas as renúncias da inteligência; também não mediu esforços para combater a ansiedade, sinal manifesto da entrada em cena da repressão, assim como para facilitar todas as expressões, diretas ou indiretas, da espontaneidade da criança: é nesta perspectiva, de início profilática e pedagógica mais do que psicanalítica, que o brincar se torna centro de seu interesse.

É preciso observar, portanto, que a própria concepção de normalidade para Melanie Klein constitui-se, nesse momento, na ideia de um pleno funcionamento de todas as aptidões intelectuais do sujeito. Ela defende que, se a energia gasta para reprimir a curiosidade sexual infantil for liberada, essa energia será utilizada para a sublimação. Acredita também que um dos principais impeditivos criados pela sociedade e propagados pelas estruturas educacionais a essa liberação do pensamento humano é a ideia de Deus – um ser supremo que a tudo regula e a partir de onde todas as respostas são dadas.

Na base do fazer kleiniano de então há, portanto, uma concepção ideológica, à qual Freud também havia, em determinado momento, cedido. Uma concepção que se aproxima do racionalismo iluminista e exige a razão, a ciência e o questionamento da autoridade religiosa como caminhos para a salvação de um modo de funcionamento neurótico (no qual os prazeres do viver, entre os quais o de se entregar ao ato do conhecimento, encontrar-se-iam inibidos). E, essa é a aposta primeira de Klein, a educação psicanalítica seria a forma de promover a liberação desses caminhos.

Mas, será justamente a experiência com a educação psicanalítica de Erich e a frustração dessas primeiras ambições pedagógicas que levará Melanie Klein à psicanálise de crianças. Acompanhemos esse deslocamento do pensamento kleiniano.

Da educação psicanalítica à psicanálise de crianças

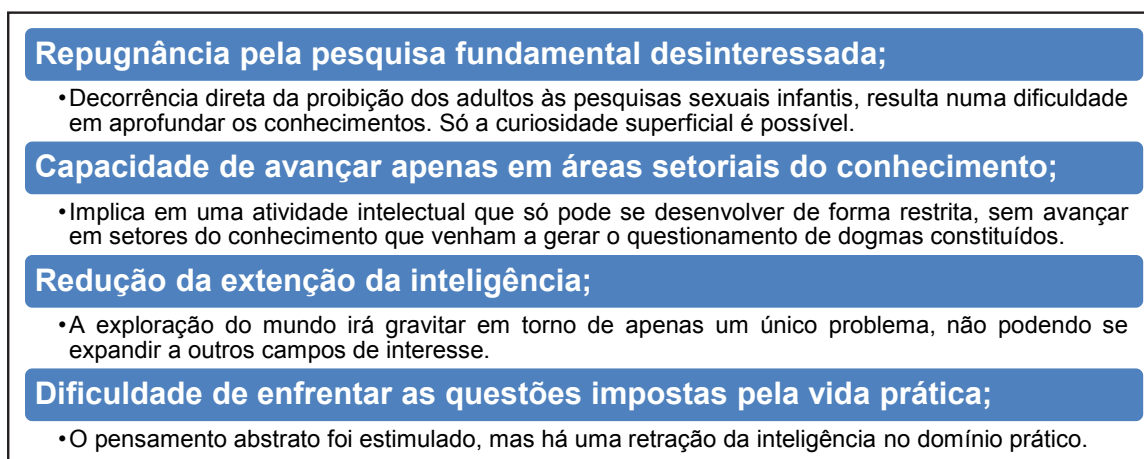
Como dito anteriormente, quando Klein inicia a educação psicanalítica de Erich, este estava com quatro anos e nove meses. O processo começa alguns dias antes da Páscoa de 1919. Erich nunca apresentara, de fato, nenhum problema em seus processos de aprendizagem, que seguiam um curso normal. Melanie Klein o descreve como uma criança aparentemente viva e inteligente. No entanto, a mãe possui o que poderíamos chamar de inquietação atenta ao desenvolvimento intelectual de seu filho, considerando Erich menos curioso que os irmãos e também menos desenvolto em suas aquisições no domínio prático do conhecimento.

Para entender essa impressão que Melanie Klein sustenta de seu filho, é preciso compreender o papel que ela atribuía às aquisições intelectuais humanas no conjunto do que seria a saúde psíquica. Segundo Petot (2008), para Klein a doença mais disseminada na humanidade média seria a inibição intelectual. Isso porque a atividade intelectual verdadeiramente normal era identificada por Klein como a capacidade de percorrer uma ampla extensão de campos de interesse e de alcançar neles uma penetração profunda, tanto no domínio científico como no domínio especulativo e no domínio prático.

Nessa época, Klein considerava a falta de espontaneidade intelectual como o sintoma mais preocupante de todos, porque retiraria do sujeito uma parte importante de sua capacidade de usufruir dos prazeres naturais da vida. Para ela, este sintoma seria consequência da repressão da curiosidade sexual inerente ao complexo de Édipo. Junto a essa repressão aliar-se-ia a composição de ilusões religiosas, que ofereceriam à criança a ideia de um Deus protetor, retomando a figura da mãe onipotente do lactante e reforçando também o próprio sentimento de onipotência de pensamentos que as crianças experimentam em certa fase de seu desenvolvimento.

Toda essa configuração comprometia a capacidade de realizar o teste de realidade, devido à necessidade de incorporar conceitos dogmáticos que não podiam ser alvo de comprovação. Isso afetava, portanto, o pensamento científico e prático, levando ao desenvolvimento tipos específicos de inibição intelectual. Eis alguns dos citados por Klein (PETOT, 2008, p. 14):

Figura 6.



E é no bojo dessas concepções que Klein avaliará a relação de Erich com o conhecimento, acreditando que uma atitude preventiva, composta pela satisfação da curiosidade sexual da criança e pelo evitar da repressão, o liberariam para vivenciar toda a sua potencialidade intelectual.

As ações do educador que tivesse como base as contribuições psicanalíticas seriam, portanto, a liberação de tabus referentes à curiosidade sexual, a educação sexual e a abolição do uso de concepções religiosas na formação da criança.

Com base nesses parâmetros, Klein inicia a educação psicanalítica de Erich. A primeira fase do processo durará menos de três meses. Nela, Erich havia começado a formular questões referentes à sua origem e à origem dos bebês. Melanie responderá as questões do filho usando a regra que havia estabelecido no início dessas incursões pedagógicas: fornece respostas às curiosidades sexuais da criança apenas na medida de seus questionamentos.

Erich demonstra uma atitude de confusão frente às respostas da mãe, mostrando-se distraído durante as conversas sobre o tema. Depois, volta repetidas vezes às mesmas perguntas. Em determinado momento, direcionará suas dúvidas à babá, que responde com o mito da cegonha. Quando ele relata a estória à Melanie Klein, ela a desmente e retoma a versão que já havia sido entregue à criança. Isso desencadeia uma série de questionamentos sobre outras figuras imaginárias – coelho da Páscoa, Papai Noel, anjos – que têm sua realidade desconstruída diante de Erich.

A criança apresenta inicialmente forte reação ao desmentido dessas histórias de que ela tanto gostava. Mas depois começa a colocar ela mesma o questionamento da sustentabilidade da existência desses seres fantásticos. É nesse caminho que Erich levanta pela primeira vez a dúvida sobre a existência de Deus. Klein responde que Deus não existe. Mas o pai de Erich possuía uma visão panteísta da divindade, e Erich

o surpreende com a mesma pergunta antes que Melanie ter tido a oportunidade de conversar com o marido sobre o assunto.

A criança recebe, então, do pai uma resposta diferente para a questão. Arthur Klein explica para o menino que ninguém nunca havia visto Deus, mas que algumas pessoas, entre as quais ele, acreditavam na existência de um ser supremo, enquanto que outras, como Melanie Klein, não acreditavam.

Para Melanie, essa resposta foi fundamental, pois ela entende que Erich, a partir desse ponto, pode observar pela primeira vez uma discordância entre os pais no que dizia respeito à construção de entendimento sobre um aspecto do mundo. Isso teria permitido que o menino colocasse em cheque a autoridade dos pais como critério de verdade, tendo que elaborar um referencial próprio de verificação, tirado de suas experiências pessoais, e tendo de realizar sua primeira escolha intelectual. Os relatos que Melanie Klein faz das semanas seguintes à sua primeira intervenção pedagógica com Erich trazem a figura de uma criança bem mais ativa intelectualmente, cujas perguntas se multiplicavam e se diversificavam. O intelecto parece liberado em extensão e profundidade, o que se manifesta por meio de uma curiosidade crescente, de uma redução das repressões e de um aumento da sublimação. Os objetivos buscados na educação psicanalítica do menino haviam sido alcançados, e Klein relata entusiasticamente o feito em sua primeira comunicação à Sociedade Psicanalítica de Budapeste.

Suas ideias são recebidas com atenção pelos psicanalistas de Budapeste, e ela é aceita como membro da Sociedade. Porém, durante a sua exposição, receberá comentários de Anton von que determinarão os rumos futuros de suas intervenções com Erich. O psicanalista aponta que as intervenções de Klein não tiveram um caráter psicanalítico, pois se dirigiram às perguntas conscientes da criança, sem que nada dos processos inconscientes fosse abordado. Ele também sugere que Klein crie um espaço de tempo específico para as intervenções com a criança – que seja diferenciado dos outros momentos de interação entre Klein e Erich.



Anton von Freund foi um importante industrial da Hungria, dono de uma cervejaria em Budapeste. Doutor em filosofia nasceu em 1880, e morreu em 1920. Submeteu-se a análise com Freud (que também analisou uma de suas irmãs) e tornaram-se amigos. Von Freund acabou por assumir o papel de um mecenas do movimento psicanalítico. Figura eminente, ele foi inicialmente o principal organizador do V Congresso Internacional de Psicanálise, em 1918, e foi o fundador do primeiro Centro de Pesquisa em Psicologia Infantil (para o qual recrutou Melanie Klein, então analisanda de Ferenczi). Também financiou a editora Internationaler Psychoanalytischer Verlag, em Viena, bem como

pretendia financiar um ambulatório analítico em Budapeste. Este último nunca foi realmente criado, pois Von Freund morreu prematuramente de câncer. Para ele, Freud compôs um obituário, homenageando a sua dedicação ao movimento psicanalítico.

Fonte: <<http://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/freund-toszeghy-anton-von-1880-1920>>.

Inicialmente, Melanie Klein discordará das colocações de Anton von Freund. Mas os desdobramentos do desenvolvimento de Erich a farão refletir sobre as questões levantadas sobre sua primeira experiência com a educação psicanalítica.

Após cerca de dois meses do final da primeira intervenção de Klein com Erich, a criança passa a manifestar uma inibição generalizada: não surgem novas perguntas em sua fala, apenas recoloca dúvidas antigas, de forma compulsiva e estereotipada. Apresenta também uma inibição no brincar e uma atitude de recolhimento, mostrando-se desinteressada e pouco ativa na presença de outras crianças. Klein percebe assim que a tendência à repressão estava triunfando, e que era mais profunda e anterior ao que supunha. Erich possuía questões acerca do ato sexual e do papel do pai na concepção que haviam permanecido inconscientes e não tinham sido, portanto, colocadas pela criança.

O que se coloca para Klein nesse momento é que será necessário ir além das preocupações manifestas pela criança, adentrando nas fantasias inconscientes que perpassam as teorias sexuais infantis. A intervenção, portanto, assume uma feição muito mais psicanalítica, e, como já não era possível se limitar apenas às dúvidas expressas pela criança, Klein terá de buscar a presença dessas fantasias em outra forma de expressão infantil: o brincar.

O brincar infantil começa, portanto, a ser tratado como uma mensagem que pode ser interpretada, desvelando as fantasia em sua base.

Na observação das brincadeiras de Erich, Melanie Klein começa a perceber a presença de conteúdos edipianos. O menino traz em sua fala fantasias sobre as crianças serem geradas no estômago, deixando entrever a teoria sexual infantil própria à fase anal, na qual os bebês são assemelhados às fezes. Klein interpreta o sentido dessas colocações para Erich, retomando explicações sobre o ato sexual. Isso permite que a criança expresse todo um novo conjunto de fantasias, que tratam do desejo de afastar o pai e se apropriar da mãe – o que fornece a Melanie Klein o ensejo para marcar a interdição ao incesto.

Esse novo período da educação psicanalítica de Erich traz a marca de mudanças importantes no fazer kleiniano. As preocupações pedagógicas passam o segundo plano, pois o desenvolvimento intelectual não é mais o objetivo principal de Klein. Ela se focará agora na liberação do brincar e do fantasiar enquanto meios de acesso aos conteúdos inconscientes que estão na base das inibições.

Como resposta a essa mudança de perspectiva, Klein assistirá Erich renovando seus campos de curiosidade, aprendendo a ler com grande desenvoltura e voltando a se relacionar com outras crianças.

O período de sucesso das últimas intervenções é, no entanto, interrompido por um adoecimento de Klein, que a deixa acamada por dois meses e a faz suspender o processo de Erich. Essa intercorrência será de fundamental importância para o desenrolar dos caminhos kleinianos, pois o adoecimento de Melanie leva Erich a desenvolver uma série de sintomas que farão com que sua mãe se desloque definitivamente para o campo da clínica.

Figura 7. Melanie Klein e sua neta.



Fonte: <<http://www.thehistorypostblog.co.uk/international-womens-day-melanie-klein/>>.

Klein faz a passagem de uma “educação psicanalítica” para uma “psicanálise de crianças” propriamente dita na busca de tratar sintomas apresentados por Erich. Na época, o brincar do menino novamente se empobrece, enquanto que a aprendizagem da leitura começa a ser revestida de um caráter compulsivo. Ele se mostra triste e ansioso, especialmente na hora de dormir. Surge também uma leve fobia a crianças que são estranhas.

Assim é que, em 1920, durante seis semanas, Melanie Klein separará um horário específico para a análise de Erich, como havia sugerido Anton von Freund. No início,

utiliza o método freudiano, centrando-se na interpretação dos sonhos do menino a partir das associações desencadeadas por elementos do conteúdo manifesto. Mas logo esbarrará na dificuldade que Freud já relatara: a criança não conseguia realizar uma associação livre partindo de perguntas. Acaba, pois, por abandonar o método clássico e começa a trabalhar com a interpretação de sonhos fazendo uso do simbolismo e da comparação de um sonho com outro.

Nesse momento surgirão nas fantasias de Erich, componentes homossexuais do Complexo de Édipo negativo. No sonhar, aparecem o desejo e o receio do coito com o pai – e o consequente temor de ser por ele destruído. Surge também, pela primeira vez, o mecanismo de clivagem da imago materna, com o aparecimento da figura da feiticeira, que representa a mãe má (imago ‘mulher com pênis’, que mais tarde será desenvolvida pela psicanalista).

Klein observa e interpreta para Erich todas as fantasias que vão emergindo nos sonhos do menino. Ao final das seis semanas de trabalho, a criança passa a adormecer sem dificuldades, o brincar reencontra sua riqueza, assim como é restabelecido o contato com outras crianças. As manifestações de ansiedade de Erich haviam arrefecido consideravelmente.

Mas as experiências anteriores fazem com que Klein já não receba com tanto entusiasmo os resultados dessa intervenção. Está mais ciente da persistência dos complexos inconscientes e anuncia a possibilidade de que novas intervenções psicanalíticas sejam necessárias no decorrer do desenvolvimento de Erich.

Em 1921, Melanie Klein muda-se para Berlim. É nesse momento que se separa de Arthur Klein. Nessa época, já havia recebido o convite de Karl Abraam para se instalar em Berlim e iniciar o atendimento psicanalítico de crianças.

A chegada de Melanie Klein em Berlim coincide, no entanto, com a entrada de Erich na escola – ocasião em que o menino desenvolve uma verdadeira neurose infantil, que se apresenta na forma de uma fobia da escola, estende-se ao caminho percorrido para chegar àquela instituição e que acaba por atingir o próprio ato de sair de casa para passeios inespecíficos.

Em suas intervenções, Klein focalizará inicialmente o significado inconsciente da repugnância pelo caminho da escola. Depois partirá para o significado da própria escola e das atividades escolares. O que se percebe aí é que a psicanalista, fazendo uso da interpretação do brincar, vai desvelando as teorias sexuais infantis erigidas por Erich e permitindo que a criança expresse suas fantasias. Questões sobre a geografia do corpo

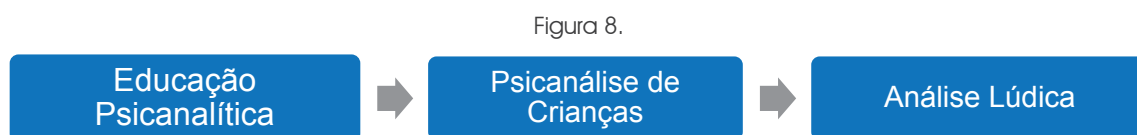
materno e sobre o desejo de conhecê-la surgem na base dos receios que Erich apresenta de explorar novos espaços. Como relata Petot (2008, p. 29):

[...] A repressão do complexo de Édipo estendera-se a seus derivados simbólicos e transformara o prazer primário em ansiedade. A interpretação da ansiedade de castração, trazendo os desejos edipianos para a consciência, permite um novo florescimento das brincadeiras e exploração do espaço.

De fato, a análise de Erich encerra-se em 1921. O menino tinha, então, cerca de oito anos de idade e, ao que parece, a intervenção de Klein, que consistiu basicamente em comunicar à criança interpretações das fantasias que se manifestavam no ato do brincar, levaram Erich à cura de sua fobia escolar e à superação de sua neurose infantil.

O que é importante perceber no breve relato que fizemos do caso Erich/Fritz é que, ao renunciar ao seu desejo inconsciente de fazer do filho um prodígio intelectual, ela finalmente consegue dar suporte à expressão dos complexos psíquicos do menino, auxiliando-o a superar as inibições que começavam a se formar por causa da ansiedade gerada por tais complexos. Klein, por essa via, realiza um movimento fundamental em sua prática, que determinará não apenas todo o seu percurso futuro na psicanálise, mas o próprio movimento psicanalítico, dando origem a uma nova escola: a escola kleiniana.

Eis para onde a escuta clínica de Klein a levará:



Fonte: própria autora.

Assim, um dos ganhos importantes que Melanie Klein terá com a análise de Erich é de ordem metodológica (Petot, 2008): ela percebe a insuficiência de uma abordagem unicamente pedagógica para lidar com os conteúdos inconscientes que estão na base do desencadear da ansiedade (que, por sua vez, sustenta as inibições). Além disso, ela também percebe a relação direta do brincar com as fantasias inconscientes, passando a utilizar as brincadeiras infantis de forma semelhante a como são tratados os sonhos e os sintomas num processo de análise, ou seja, enquanto formações do inconsciente.

E, uma conclusão que será fundamental – e que, inclusive, marca as contribuições de Klein à psicanálise infantil: “A boa adaptação social e escolar da criança não podem ser os objetivos do psicanalista de crianças, constituindo, quando muito, benefícios

secundários da psicanálise. (...) Os objetivos da psicanálise de crianças só podem ser definidos em termos psicanalíticos.” (PETOT, 2008, p. 32).

É assim que Klein se faz pronta para iniciar suas contribuições à teoria psicanalítica. A partir de 1922, passa a atender várias crianças (e, esporadicamente, adultos). Assim, sedimenta um estilo próprio, trazendo contribuições teóricas e práticas ao fazer iniciado por Freud. Partamos, então, para a configuração do setting desta importante psicanalista.

CAPÍTULO 2

O setting kleiniano

Importante começar ressaltando que Melanie Klein, apesar de ter criado uma nova técnica para a análise infantil – técnica que, inclusive, divergia de afirmações freudianas sobre a escuta de criança –, acreditou e investiu ao longo da construção de sua vivência clínica, na invenção psicanalítica. Ela declarou mais de uma vez sua fidelidade aos pontos que Freud havia destacado como sendo basais na estrutura da Psicanálise. Em *Princípios Psicológicos da Análise de Crianças Pequenas*, Klein (1926/1996, p. 163) estabelece claramente a pertinência do fazer ao campo psicanalítico:

Trata-se apenas de uma *técnica* diferente, e não de novos *princípios* de tratamento. Os critérios do método psicanalítico proposto por Freud, ou seja, que devemos utilizar como ponto de partida os fatos da transferência e da resistência, levar em consideração os impulsos infantis, a repressão e seus efeitos, a amnésia e a compulsão à repetição, e que, além disso, devemos descobrir a cena primária, como ele exige em “História de uma Neurose Infantil” – todos estes critérios são mantidos em sua integridade na técnica do brincar. O método do brincar mantém todos os princípios da psicanálise e leva aos mesmos resultados da técnica tradicional. A diferença é que ele emprega recursos técnicos adaptados à mente da criança.

E quais seriam, então, as diferenças técnicas que Melanie Klein propõe? A possibilidade, em si, de levar adiante uma análise infantil é a primeira delas.

Aqui é necessário dizer que Freud havia desaconselhado a psicanálise de crianças - isso por considerar que elas não teriam ainda adquirido condições de realizar a associação livre (pedra angular do fazer psicanalítico). Klein, que concorda com Freud no que diz respeito à inadequação do *setting* clássico da psicanálise ao atendimento com crianças, irá apresentar como alternativa a técnica do brincar (ou análise lúdica).

Como vimos, esse desenvolvimento técnico começa a surgir na sua experiência com a análise de Erich. No entanto, será com Rita, uma paciente de dois anos e nove meses que Klein atende em 1923, que a análise lúdica passará a ser realizada de forma sistemática. Rita tinha forte fixação na mãe e apresentou grande resistência em ficar sozinha com Melanie Klein, o que fez com que a analista fosse obrigada a atendê-la na casa dos pais.

Rita verbalizava muito pouco e brincava durante quase todo o tempo da sessão. Pode-se dizer que a pequena paciente praticamente impôs o brincar como forma de expressão a ser utilizada nas sessões. O fato acabou por enriquecer as experiências de Melanie Klein com a escuta de crianças pequenas e, a partir da vivência com Rita, a psicanalista adotará a técnica do brincar na análise de crianças. Defenderá, portanto, que, seja qual for a idade do paciente, o importante é que ele, no curso de sua análise, tire partido de todos os recursos de linguagem a sua disposição. E o brincar se apresenta como um dos mais profícuos entre eles. Entendamos o porquê.

Melanie Klein passa a compreender o brincar como uma formação do inconsciente. Sendo assim, ele seria como os sonhos, uma via de acesso para os complexos alijados nessa instância, que já se encontrariam presentes mesmo no psiquismo de crianças bem pequenas.

Nesse sentido, é preciso entender que, se por um lado, Klein defende que a maneira de expressão das crianças é diferente da maneira de expressão dos adultos (e isso precisaria ser levado em consideração na condução das análises), por outro, a linguagem usada pelo inconsciente é a mesma em ambas as formações psíquicas. Ou seja, assim como os adultos representam suas fantasias, desejos e experiências nos sonhos, as crianças utilizam a mesma forma de representação para construir suas brincadeiras. A estrutura de composição dos sonhos, Klein percebeu, é a mesma de composição dos jogos.

Portanto, assim como era possível compreender todos os expedientes de representação e os mecanismos empregados no trabalho dos sonhos, também era possível entender as brincadeiras em sua relação com o resto do comportamento da criança em análise. Do mesmo jeito que os elementos do sonho, quando analisados, levavam à descoberta do conteúdo latente que se encontrava na base de sua formação, os elementos do jogo infantil permitiam vislumbrar os significados latentes que se encontravam na origem de sua constituição. A análise lúdica funcionava, dessa forma, como a análise de adultos: ao tratar sistematicamente das situações apresentadas nos jogos, era possível reconstituir suas conexões com a cena primária que dera origem – fosse ela real ou imaginada – o que permitia à criança elaborá-la (KLEIN, 1932/1981).



Cena Primária – “Cena de relação sexual entre os pais, observada ou suposta segundo determinados índices e fantasiada pela criança, e que esta geralmente interpreta como um ato de violência por parte do pai”. Para saber mais, consulte o verbete “Cena Originária ou Protocena” no *Vocabulário de Psicanálise*, (Laplanche e Pontalis, 1983, p. 91).

Assim é que, entendendo o brincar como uma mensagem, Klein vai compondo seu *setting* terapêutico: “pequenos homens e mulheres de madeira, carroças, carruagens, automóveis, trenzinhos, animais, cubos e casas, além de papel, tesoura e lápis”. (KLEIN, 1932/1981, p. 41) A necessidade do acesso fácil à água também é ressaltada. Porém, mais que isso, vai surgindo uma teoria que sustenta essa prática analítica. Os brinquedos são facilitadores da expressão da criança, pois, ainda que esteja inibida em seu brincar, ela lançará ao menos um olhar para eles, permitindo ao analista um primeiro vislumbre dos complexos inconscientes. Mas esse não é o único papel dos brinquedos. É o que Klein defende quando busca o motivo pelo qual as crianças brincam. Que a criança extraí prazer da atividade do brincar é algo evidente. Mas por quê? Melanie Klein (1926) relembra que a libido, inicialmente, é dirigida para o próprio ego. No entanto, a criança, ao longo de seu processo de desenvolvimento, redirecionará essa libido para objetos externos (pessoas/coisas), estabelecendo suas primeiras relações com o mundo e voltando-se para a realidade. É deste contexto que parte o entendimento da psicanalista acerca da função do brincar.

Petot (2008) recompõe as ideias de Klein sobre o tema, lembrando que ela retoma a concepção freudiana de que as pulsões sexuais surgem tendo como base os instintos de sobrevivência. E, nessas experiências primeiras, a criança irá vivenciar o prazer do órgão (ou seja, uma satisfação local de ordem sexual que está na base do autoerotismo). Com ele, surgem também os primeiros investimentos libidinais (de caráter, portanto, narcísico). Por meio do processo de identificação – precursor do simbolismo – os objetos que receberam de início o investimento libidinal vão conduzindo a outros. Assim é que os pés, as mãos, a língua, os olhos, enfim, todo o corpo vai sendo colocado como alvo da catexia libidinal.

E, continuando a trilhar este caminho, a libido passa a investir também as atividades desempenhadas por essas diversas partes do corpo. É por essa via que tais atividades serão revestidas de significações ligadas a atividade do coito. “As representações simbólicas que as acompanham são, portanto, as primeiras fantasias masturbatórias que se ligam diretamente a cena primitiva”. (2008, p. 67). Sigamos essa trilha mais detidamente:

Após a identificação, que, como dissemos, propicia o investimento libidinal de diversas partes do corpo, ocorrem as primeiras manifestações da repressão, tornando inconscientes as representações sexuais que haviam sido construídas no processo identificatório. O simbolismo surge aí, para propiciar que essas representações reprimidas sejam usadas como base para a formação de significações sexuais – e, dessa vez, o material serão as atividades do ego.

Para Melanie Klein, as atividades que primeiramente receberiam os investimentos da libido seriam a fala e o movimento. Assim, elas passariam a ser instrumento da satisfação libidinal, palco dos primeiros processos de sublimação (*sublimações primárias*). Logo, a fala e o movimento tornam-se vias de descarga da libido, por meio de um investimento sexual baseado no simbolismo.

Acontece que as sublimações primárias passam a ser o pilar do desenvolvimento de todas as outras sublimações. Esse desenvolvimento faz-se segundo uma ordem determinada. Ao ocorrer a fixação libidinal nas sublimações primárias, estão criadas as condições preliminares às demais sublimações. É aí que surge, então, a primeira *sublimação secundária*: o brincar.

O brincar é a manifestação imediata das duas sublimações primárias que a criança realizou para os atos de falar e se movimentar – e estará no fundamento de todas as sublimações posteriores. Por ser ele uma combinação dessas primeiras sublimações, ocupará um lugar estratégico no desenvolvimento do indivíduo, por abrir o caminho para o investimento libidinal de outras atividades e objetos. E, como esse investimento ocorre inicialmente no campo do “faz-de-conta”, o brincar também tem a função de preparar o sujeito para o enfrentamento da realidade. Exerce, portanto, alguns papéis importantes: expande o investimento libidinal para novas atividades do ego e auxilia na adaptação do indivíduo à realidade.

O brincar pertenceria, então, à primeira camada de sublimações secundárias, sobre a qual se erigiriam outras camadas compostas por novas atividades do ego (como, por exemplo, as atividades relacionadas à vida escolar). Entender o brincar como ocupando essa posição com relação às demais sublimações secundárias ajudará a compreender, também, o efeito das inibições que incidem sobre ele. Sim, porque muitas vezes Klein recebia em sua clínica crianças com a atividade de brincar extremamente empobrecida, e esse fato resultava em uma série de consequências para a vida do indivíduo.

O ponto é que as sublimações primárias não conseguem realizar a satisfação completa das pulsões libidinais. Freud já afirmava que sempre há um resto de pulsão, uma sobra que não consegue se resolver na destinação da sublimação. Esse fracasso parcial é o que coloca a libido em movimento. Ela se vê compelida a buscar novos meios de satisfação, que, em última instância, nunca a esgotarão, pois a libido é, irremediavelmente, insaciável. Justamente essa característica é que a faz motor da atividade, pois seu investimento se repetirá continuamente no decorrer de todo desenvolvimento, compondo novos símbolos e permitindo novas sublimações e formações reativas.

Figura 9. Crianças brincando. Portinari, 1940.



Fonte: <<http://www.elfikurten.com.br/2011/02/candido-portinari-mestres-da-pintura.html>>. Acesso em: 21/2/2017.

É por meio deste processo que as sublimações primárias forneceram sua energia para as sublimações secundárias. Todas as sublimações remeterão, em última análise, à fala e ao movimento. E o brincar será a primeira delas, constituindo-se como fundamento de todas as demais sublimações. Da mesma forma, todas as inibições recairão sobre a inibição do brincar, pois a inibição de uma sublimação está fundada em uma sublimação anteriormente reprimida.

É esse o motivo pelo qual Klein vai dar ênfase, no início das análises que empreende, à liberação do brincar. A questão é que as brincadeiras trazem em si simbolizações das fantasias sexuais – que remetem às teorias sexuais infantis e que têm como matéria prima a cena primitiva. Quando essas fantasias são reprimidas e, nesse processo, gera-se um sentimento de culpa na criança demasiadamente pesada para ser suportada por um ego ainda fraco, a repressão atinge também seus representantes simbólicos.

Dessa forma, o brincar e, conseqüentemente, as outras sublimações secundárias que nele se assentam (como pesquisar, conhecer, ler, escrever passear e tantas mais) serão afetadas, pois o sentimento de culpa – com a correlata ansiedade desencadeada por este sentimento – vai se espalhando para as atividades que se ligam às cadeias simbólicas que, por sua vez, partem das primeiras fantasias sexuais. Eis o processo que conduziria várias atividades da vida do indivíduo a sofrerem inibições.

Mais um motivo pelo qual o brincar pode ser prazeroso para os pequeninos. Porque, quando a criança é liberada das inibições do brincar, ela deixa de despender parte de sua energia psíquica com a repressão de complexos inconscientes, liberando essa energia inclusive para realizar novas sublimações. A elaboração da ansiedade vinculada às fantasias também gera descarga de tensão e conseqüente alívio para o indivíduo.

Creio que podemos agora sistematizar algumas das respostas dadas por Melanie Klein a pergunta por que as crianças brincam. Essas respostas nos permitem antever a importância da contribuição técnica kleiniana quando a análise lúdica se estabelece no *setting* da psicanálise com crianças.

Figura 10.

1) O brincar serve de fundamento para todas as demais sublimações que o indivíduo realizará na vida. No jogo, a criança experimenta, explora, investe e reveste o mundo. Ele é o protótipo das mais fantásticas realizações que o ser humano será capaz de empreender. Por isso, o tratamento psicanalítico deve conduzir a uma liberação do brincar.

2) Ao brincar, a criança exterioriza seus conflitos internos e treina o enfrentamento e a vitória de realidades dolorosas e medos interiores por meio da projeção, na realidade, de seus complexos psíquicos. "Sua função é tentar controlar, dominar, elaborar as demandas excessivas ao ego e suas sobrecargas". (Montagna, p.64)

3) Nas brincadeiras, a criança pode representar simbolicamente as fantasias masturbatórias construídas a partir da cena primária, obtendo, assim, a descarga da libido que partiu destas fantasias e investiu o brincar. Há, portanto, liberação de prazer no ato de brincar

4) No momento em que suas fantasias são rechaçadas, a criança passa a apresentar angústia quando entra em contato com representantes dos impulsos reprimidos. O brincar servirá aqui como via de acesso e elaboração destas fantasias. "O intenso prazer que as crianças encontram em seus jogos ocorre (...) também porque o brinquedo permite o domínio da angústia" (Mello, p.41), ajudando-as a lidar com o sentimento de culpa e liberando a energia antes gasta com a repressão .

Vislumbrando esse quadro, podemos, por fim, concluir a dimensão que o brincar assume no desenvolvimento da técnica e da prática kleinianas. Petot (2008, p. 69) bem o expõe, quando destaca que:

O método psicanalítico é simultaneamente um processo de investigação e uma terapêutica. Enquanto processo de investigação, tem função de interpretar as brincadeiras da criança, destacando as fantasias masturbatórias subjacentes a cada atividade lúdica e remetendo-as à cena primitiva da qual constituem a elaboração. Enquanto terapêutica, só pode atingir seu objetivo de redução dos sintomas e de restituição

das sublimações por meio da interpretação da vida de fantasia atuada no brincar, cuja inibição constitui o primeiro momento de formação do sintoma neurótico ou da inibição de uma aptidão. As duas dimensões – heurística e terapêutica – da técnica psicanalítica aplicada à criança levam a conferir ao brincar um valor privilegiado no tratamento enquanto signo diagnóstico, material a ser interpretado e âmbito de evolução do processo analítico.

Aqui aparece mais claramente, portanto, a segunda contribuição técnica que Melanie Klein faz à psicanálise: sua forma original de interpretar.

No que diz respeito à interpretação, Melanie Klein também inovou em seu *setting*. A escola vienense de psicanálise infantil (a quem estava ligado o nome de Anna Freud, e que defendia o *tratamento educativo e curativo*) pregava a necessidade de avaliar em que oportunidade dever-se-ia entregar ao analisando uma interpretação. Essa escola defendia que, primeiramente, o analista teria que interpretar as defesas que o paciente manifestava, antes de chegar à interpretação das fantasias inconscientes e de suas pulsões correspondentes. A interpretação, portanto, tinha de começar pelas camadas mais superficiais do psiquismo, penetrando paulatinamente os demais estratos (regra da superficialidade).

Necessário afirmar também que a linha da escola vienense evitava a interpretação da transferência, até porque questionava a própria natureza da transferência nas crianças, alegando que os pequenos pacientes ainda estariam na presença real de seus primeiros objetos de amor, o que implicaria que não teriam ainda finalizado a construção dos protótipos amorosos que serviriam como base para as relações transferenciais. Seria, dessa forma, teoricamente inconsistente falar de uma transferência propriamente dita na análise de crianças.

Diversamente dessas ideias, a prática kleiniana prega o uso das interpretações profundas, e essas interpretações ocorrem na transferência. Entendamos melhor:

As primeiras interpretações feitas em análise têm, para Klein, importância fundamental no seguimento do processo. Ela afirma que, nas crianças, a transferência ocorreria muito mais rapidamente do que nos adultos. Ela seria imediata. Assim é que, já nas primeiras sessões seria possível ao analista perceber a natureza da transferência. A transferência positiva, assim como pensava Freud, seria um motor para o tratamento. Já a transferência negativa, sobre essa seria necessária atuar com urgência já no início do tratamento.

A transferência negativa em geral se impõe com força no início da análise. Mas ela também aparece quando os pequenos pacientes começam a acessar seu material complexo. Klein acreditava que a facilidade com que a criança fazia uma transferência espontânea se devia ao fato de a angústia infantil ser muito mais aguda do que a adulta. Esse fato seria determinante na aproximação ou no afastamento dos objetos. Os objetos que aliviassem a tensão da angústia gerariam uma transferência positiva na criança, enquanto que os que excitassem a angústia levariam a uma transferência negativa.

Assim, nas crianças pequenas, a transferência costuma se manifestar como medo indisfarçado, enquanto que, nas maiores, surgirá como desconfiança e reserva. Isso acontece porque o deslocamento é uma das maneiras de se lidar com a angústia. A criança, portanto, estende seus temores dos objetos mais próximos (imagos internalizadas da “mãe má” e do “pai mau”) para objetos mais distantes, como forma de tentar lidar com seus medos. “Esta é a razão porque a criança realmente neurótica, em quem predomina a sensação de estar sob a ameaça de perigo constante e que vive na expectativa de um pai ou mãe ‘maus’, reagirá com angústia ante a presença de qualquer estranho” (1932/1981, p. 51).

O analista, em geral, enfrenta esta situação no início da análise. E precisa estar preparado para que, logo que a transferência negativa surja, ele possa agir, entregando a seu pequeno paciente a interpretação que lhe é correspondente. Tal interpretação precisa incidir sobre o material inconsciente que desponte como o mais urgente, para que a situação analítica se estabeleça. A urgência será avaliada pela repetição frequente de determinado tema nas representações do pensamento lúdico e pela forte tonalidade sentimental que as acompanhará – deixando antever a intensidade dos afetos ligados ao conteúdo.

Caso o analista não aja no momento adequado, negligenciando um material de natureza urgente, a criança interromperá a brincadeira, manifestando grande resistência, e tendo despertada a angústia. Essa situação, se não for manejada pelo analista, pode levar a criança a vivenciar crises de angústia nas sessões de análise. Por isso é que quando, “desde o início, predomina uma transferência negativa ou quando as angústias e resistências surgem desde o princípio, já vimos a absoluta necessidade de se interpretar o mais rápido possível.” (KLEIN, 1932/1981, p.52)

Assim, Klein afirmará que o analista não deve temer fazer uma interpretação em profundidade, mesmo no início da análise. Na verdade, ela sustenta que a interpretação pode e deve ser realizada logo que o paciente tiver deixado entrever (por meio de

seus jogos, desenhos, fantasias) os seus complexos, já que “a função da interpretação em profundidade é simplesmente a de abrir a porta do inconsciente e diminuir a angústia suscitada, preparando, assim, o caminho para o trabalho analítico”. (KLEIN, 1932/1981, p.50).

Portanto, para a psicanalista a interpretação não só pode como deve ser realizada em profundidade. A profundidade de uma interpretação será tão fundamental quanto sua oportunidade. Ao levar em conta a urgência dos conteúdos psíquicos que vão emergindo nas sessões, o analista é obrigado a se aprofundar até a camada psíquica que está se manifestando nas produções do paciente, *locus* não apenas do material que teima em se desvelar, mas também das ansiedades e da culpa que o acompanham.

Mas se o psicanalista se eximir de realizar uma interpretação em profundidade e permanecer, como na análise de adultos, nos estratos superficiais do psiquismo (mais próximo do ego e da realidade), ele falhará em seu objetivo de estabelecer a situação analítica e de reduzir a ansiedade da criança. Sobe isso, Klein (1932/1981, p. 52) alerta claramente:

Uma interpretação que não desce às profundidades que estão sendo ativadas pelo material e pela angústia concernentes; que não ataca o local onde reside a mais forte resistência latente; e que não se empenha, antes de mais nada, em reduzir a angústia no ponto onde é mais violenta e evidente, uma tal interpretação não terá qualquer efeito sobre a criança.

Klein ressalta também a importância de cuidar do linguajar usado nas interpretações. Ele deve ser escolhido em função da maneira como as crianças pensam e falam. Elas ainda se encontram, em grande parte, sob o domínio do inconsciente, e sua linguagem traz a marca desse fato, sendo, predominantemente, pictórica. Palavras evocam quadros e fantasias, e vão fornecendo acesso ao mundo psíquico infantil.

Pode-se concluir a partir do exposto que Klein assumirá, no que diz respeito ao papel da interpretação, um caminho bem diferenciado do que até então era seguido nas tentativas de análise de crianças. A interpretação é feita na transferência e é porta de entrada para a análise, possuindo, inclusive, o efeito de diminuir a inibição no brincar e de modificar o caráter dos jogos (tornando a representação do material inconsciente mais clara).

Klein (1932/1981, p.58) assim resume os elementos que a interpretação assume em seu *setting*:

Para sermos mais exatos, a interpretação deve ser feita no momento oportuno e deve atingir a zona do psiquismo que se encontra ativada pela angústia; uma interpretação deve basear-se numa apreciação justa e rápida do sentido desse material, que nos esclarece tanto no que se refere à estrutura no caso, quanto ao estado afetivo atual do paciente; mas, sobretudo, é necessária uma percepção imediata da angústia latente e do sentimento de culpa nela contido.

Outra contribuição técnica de Melanie Klein, como assinalarmos anteriormente, foi a forma como ela passou a manejar a transferência na clínica psicanalítica.

Em 1926, Anna Freud defende a ideia de que só seria possível observar na análise de crianças manifestações transferenciais positivas. E, mesmo essas, ocorreriam dentro de limites estreitos, pois que os pequenos pacientes ainda não estariam aptos a desenvolver uma verdadeira neurose de transferência.

Essa declaração de Anna Freud era, na verdade, uma crítica dirigida aos relatos de caso de Melanie Klein, nos quais despontavam diversas descrições de fenômenos transferenciais – já presentes desde o início do processo analítico e, em geral, de caráter negativo.

Klein não apenas atestava a presença da transferência negativa na análise com crianças. Ela ia bem além: situava o manejo deste fenômeno por meio da interpretação como a pedra de toque para a entrada em análise. Ao receber as críticas de Anna Freud, ela revidará com uma concepção importantíssima para demarcar a diferença entre o *setting kleiniano* e a psicanálise infantil praticada pela escola de Viena. Klein declarará que Anna Freud não consegue perceber a presença da transferência em sua prática clínica por causa da posição que assume frente a seus pequenos pacientes. Anna se colocaria em um papel pedagógico, o que impediria a criança de manifestar suas fantasias, pois que o *enfant* faria previamente a leitura do que seria ou não aprovado pela analista, passando a se conduzir a partir desse parâmetro ao invés de simplesmente expressar seus impulsos mais urgentes.

Para Klein, portanto, a posição do analista tem que ser de neutralidade. Só assim torna-se possível para ele perceber a presença de uma verdadeira capacidade de transferência nas crianças – e, por meio dela, alcançar as fantasias do *enfant*. Isso porque a relação do paciente com o analista não seria uma relação com um objeto real.

Para Anna Freud, a relação da criança com os pais é uma relação com objetos reais, assim como será a relação da criança com o analista (que é, tão somente, uma reprodução dessa relação com os pais).

Mas para Klein, mesmo a relação com os pais já não é uma relação com objetos “reais”. Os pais com quem a criança se relaciona são imagos internas compostas a partir de vivências reais e fantasias. São representações imaginárias e deformadas dos pais reais.

A experiência clínica de Klein a levará a concluir que, desde o início da vida, o bebê possui um ego capaz de, mesmo não estando ainda integrado, sentir ansiedade e se defender dela por meio de sucessivas introjeções e projeções, estruturando, assim, um mundo interno e dando início às relações objetais. O bebê opera uma clivagem em suas representações imaginárias, da qual resultam “bons” e “maus” objetos. Esses objetos são projetados não só para dentro dos pais, mas para todas as relações “reais” amorosas ou hostis da vida cotidiana (identificação projetiva).

Portanto, a relação com os pais já é uma relação transferencial – sendo a transferência entendida aqui como resultante da externalização, sob a pressão exercida pela ansiedade, de relações objetais internalizadas. (BARROS, E.M.R; BARROS, E.L.R, 2009).

Assim, Klein defenderá que a transferência observada na psicanálise infantil não é um deslocamento da relação com os pais reais para a relação com o analista, mas um direcionamento para o analista da mesma dinâmica relacional que a criança estabelece com seus objetos internos. A questão essencial envolvida na transferência não será, portanto, a da relação entre passado e presente, mas aquela que se trava entre o mundo interno e o mundo externo. Sobre isso, Klein (1943/1989, p. 50) afirma:

Por meio desta utilização ampliada da situação transferencial, o analista se dá conta de que está desempenhando uma variedade de papéis na mente do paciente, e que ele não está só representando pessoas reais do presente e do passado do paciente, mas também os objetos que o paciente internalizou desde seus primeiros dias de vida, construindo assim o seu superego. Desta forma, somos capazes de compreender e analisar desde o seu início o desenvolvimento de seu ego e seu superego, de sua sexualidade e de seu complexo de Édipo.

Importante ter clareza, ainda, de que a criança não reage somente às experiências reais que vivencia com os pais. Ela responde às representações que construiu da realidade a partir de suas introjeções e projeções. Portanto, o que comparece na transferência não são lembranças reais de fatos ocorridos no passado, mas depositórios internalizados de vivências já deformadas pelo processo de introjeção.

A criança, em seu desenvolvimento, vai realizando o que Klein denomina de interjogo entre pais reais e pais introjetados. E é esse interjogo que permite, gradativamente, a redução da distância entre essas figuras, aproximando os objetos internos dos objetos reais.

No caso da análise, especificamente, o que deve imperar é a supressão deste interjogo. Para propiciá-la, o analista deve primar pela neutralidade, respondendo às falas e aos atos dos pequenos pacientes tão somente por meio de interpretações – sem censurar ou demonstrar acordo com qualquer um deles. Assim, quando as crianças transferirem para o analista seus objetos introjetados, a ausência de resposta “real” por parte do analista permitirá a emergência, em estado puro, da potencialidade de transferir que as crianças de fato possuem. É assim que, como constata Klein (1943/1989, p.51):

Esta interação constante entre processos conscientes e inconscientes, entre produtos da fantasia e percepção da realidade, encontra plena expressão completa na situação transferencial. Então vemos, em certos estágios da análise, como o foco se desloca das experiências reais para situações de fantasia e para situações internas – com isso quero dizer o mundo de objetos sentido pelo paciente como estabelecido no seu interior – e novamente de volta para situações externas, que mais tarde podem aparecer como um aspecto realista ou fantasioso. Este movimento para dentro e para fora está relacionado com o intercâmbio de figuras reais, fantasiadas, externas e internas, que o analista representa.

Por fim, pode-se constatar que as concepções kleinianas também vão colocar a transferência na posição de alavanca do processo analítico, pois, para Klein, a interpretação permite a rápida instituição de uma nova forma de interjogo entre os objetos introjetados e o analista (sendo este último visto como um parceiro, que interpreta as atividades lúdicas e expõe as ansiedades, propiciando a elaboração destas). “O processo analítico tem, pois, como tarefa, reduzir os afetos patogênicos na e pela transferência, e a criança desenvolve uma neurose de transferência plena e integral, no sentido em que Melanie Klein entende este termo, o que não coincide exatamente com aquele que lhe é dado classicamente” (PETOT, 2008, p. 106).

Ao final desta exposição sobre algumas das principais contribuições técnicas de Melanie Klein – análise lúdica, interpretação e transferência – pode-se perceber a marca assumida pelo *setting kleiniano*. Klein não apenas se afasta da escola vienense de psicanálise, mas das próprias concepções que nortearam inicialmente sua prática. Enquanto a linha de Hug-Hellmuth (psicanalista vienense considerada uma das pioneiras da psicanálise com crianças e de cujo grupo idéias Anna Freud fez parte) defendia que a psicanálise com crianças deveria perseguir atitudes simultaneamente educativas e curativas, Klein

sustentará que “a situação analítica só pode ser estabelecida e assegurada quando se mantém uma atitude puramente analítica com o paciente”. (KLEIN, 1932/1981, p. 44). Qualquer processo de esclarecimento deve, portanto, agora se colocar em função dos objetivos analíticos. O material fornecido deverá inicialmente ser apenas interpretado, sem qualquer explicação. Como elucida Klein (1926/1996, p. 162):

Assim, o esclarecimento vai acontecendo aos poucos, com a remoção das resistências inconscientes que agiam contra ele. [...] Essa compreensão é aceita sob injunção do superego, cujas exigências são modificadas pela análise, de modo que ele passa a ser tolerado e obedecido por um ego bem menos oprimido e, portanto, mais forte do que antes. Assim, a criança não se confronta *de repente* com a necessidade de admitir uma nova visão de sua relação com os pais, nem é obrigada a absorver de forma mais geral, um conhecimento que é um fardo para ela. Minha experiência mostra que os efeitos desse conhecimento gradualmente elaborado é aliviar a criança e estabelecer uma relação mais favorável com os pais [...].

O *setting kleiniano* apresenta, então, sua forma ao meio psicanalítico de então. Nada de educação psicanalítica. Tem-se a análise lúdica. Constituíra-se uma nova técnica, permeada por também novos conceitos teóricos. E Klein inscreve sua marca nas contribuições que a Psicanálise vem oferecer ao tratamento do sofrimento psiquismo. Acompanhem, no próximo módulo, os conceitos que a psicanalista irá forjar a partir deste ambiente clínico que acabamos de descrever.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA SE ENTENDER O PENSAMENTO KLEINIANO

UNIDADE IV

Neste módulo, exporemos alguns dos principais conceitos da teoria kleiniana. Eles fornecerão uma base para quem desejar partir para uma leitura mais ampla dos textos de Klein.



Você deve chegar ao final compreendendo:

- » O conceito de *Fantasia* para Klein;
- » O conceito de *Objeto Interno* e a realidade psíquica na visão kleiniana;
- » Os mecanismos esquizoparanoides e seu papel do desenvolvimento do psiquismo;
- » Os mecanismos depressivos e seu papel no desenvolvimento humano.

CAPÍTULO 1

O Mundo Interno: um colorido de fantasias e de objetos

Melanie Klein, ao empreender a análise de crianças, adquiriu amplo conhecimento do funcionamento emocional da psique infantil. Seu entendimento do mundo interno dos pequenos pacientes também auxiliou no enriquecimento da compreensão da personalidade adulta – com seus núcleos sedimentados, que operariam por toda a vida. Isso porque a psicanalista defendia que a estrutura arcaica das emoções infantis tinha participação fundamental no desenvolvimento da mente dos adultos, levando-se inclusive em conta as experiências datadas de um período pré-verbal.

A investigação que Klein realizou da vida emocional dos bebês permitiu o vislumbre das atividades mentais primitivas e a possibilidade de dar palavras aos elementos mais primevos e aos núcleos mais infantis da personalidade. Tais núcleos internos são expressão do funcionamento emocional dos pacientes e base de significação para as vivências deles no campo das relações objetais. Sigamos algumas ideias que surgem desta busca de entendimento empreendida por Klein.

Uma concepção muito importante na teoria kleiniana é a noção de fantasia. Klein dedicou considerável atenção ao papel da fantasia inconsciente dinâmica na vida psíquica da criança. Em sua obra, o conceito freudiano de fantasia inconsciente recebeu maior destaque, ampliando-se.

Perscrutar a origem, a estrutura e as funções da fantasia sempre foi um desafio constante para os psicanalistas. Enfrentar a questão da fantasia inconsciente é estar no cerne da composição da psique, por causa de sua relação com os instintos, os objetos, a simbolização e a estruturação das trocas entre a realidade psíquica e a realidade exterior. Em especial, o mundo fantasmático que surge na obra de Melanie Klein é, para muitos, inicialmente espantoso. Povoado de objetos internos e complexas tramas – onde a cobiça, a inveja, a vingança, o medo, a gratidão, o mais extremo amor e tantos outros sentimentos vão entrando em jogo na vida do enfant –, esse mundo interno que o sistema kleiniano descreve é fruto de uma longa experiência clínica, e não de uma dedução teórica que se constrói a partir do vazio.

Como nos afirma Tanis (2009, p. 69), o universo da fantasia inconsciente, da forma como Klein o concebe, é uma linguagem corporal muito viva e extremamente concreta. Para a criadora da psicanálise com crianças, existe uma continuidade muito clara entre o corpo e a fantasia, por isso é que Klein entenderá que a fantasia é, desde suas origens, inconsciente – iniciando sua ação antes mesmo da repressão. Nesse sentido, sua pesquisa das manifestações da fantasia abarca inclusive os processos psíquicos pré-verbais, o que mais uma vez denota a concepção de uma organização do psiquismo sofisticada e atuante desde os primeiros meses de vida.

Importante compreender também que a fantasia não é a contraposição a uma falta de sentido da realidade. Não é uma oposição negativizada da razão. Na verdade, para Klein, não é possível conceber a razão sem o colorido que lhe atribui a vida emocional. As emoções deformam as percepções e as imagens que formamos do mundo, determinando a tonalidade dos elementos que chegam a nossa mente partindo do mundo externo. A razão é, portanto, inevitavelmente permeada pela fantasia. “O significado emocional das experiências não nos é dado por uma faculdade independente idealizada como razão, capaz de operar fora de uma zona de conflitos, mas pela organização das emoções que

vão colorir nossa razão, transformando-a em crenças e percepções”. (BARROS, E.M.R; BARROS, E.L.R, 2009, p. 20).

Sendo assim, a fantasia e a realidade passam a constituir um dueto indissolúvel na composição da subjetividade. O que determinaria o caráter do psiquismo do indivíduo seria a natureza de suas fantasias inconscientes e o modo como elas se relacionariam com a realidade externa.

Mas o que afinal seria, para Klein, a fantasia? Segundo Segal (1973), a fantasia pode ser considerada como o representante psíquico, a expressão mental dos instintos. Entende-se, portanto, que o inconsciente seria habitado, sobretudo, por fantasias – entendidas no sentido que Klein a elas atribuiu: o de representantes mentais instintuais.

Figura 11. A minha ama e eu. Frida Kahlo, 1937.



Fonte: <<http://www.hierophant.com.br/arcano/posts/view/Fool/401>> . Acesso em: 21/2/2017.

Logo, na teoria kleiniana, as ideias que representam os instintos são as fantasias primitivas originais. Já no início da vida, a atuação dos instintos seria transposta para a vida mental com fantasias de satisfação. Nelas, o instinto aparece como sendo satisfeito por um objeto apropriado. As fantasias inconscientes, na medida em que datam de um período pré-verbal, são experimentadas como sensações, e depois, tomam a forma de imagens plásticas – imagens visuais, auditivas, sinestésicas, táteis, gustativas, olfativas... Os sentimentos (desejos, angústia, amor), assim como as defesas erigidas para com eles lidar, também serão traduzidos pelo pequeno indivíduo como fantasias inconscientes.

Para Tanis (2009), um dos pontos essenciais que resulta das pesquisas de Melanie Klein é a percepção do aspecto originário das fantasias inconscientes. As fantasias não teriam origem em um conhecimento estruturado a partir do mundo externo, sua fonte seria interna: os impulsos instintivos. Portanto, a originalidade da ideia kleiniana não residiria no fato de existirem representações protomentais das ações dos instintos, mas da suposição de que ações, por exemplo, de natureza destrutiva – como dilacerar e devorar – já estariam contidas instintivamente no impulso, de maneira que a fantasia precederia a experiência. Sobre isso, Isaacs (1952/1986 p.108) exemplifica:

A fantasia de que os seus impulsos apaixonados destruirão o seio materno não exige que o bebê tenha realmente visto os objetos devorados e destruídos e chegue, depois, à conclusão de que também poderia fazê-lo. Esse anseio, essa finalidade, essa relação com o objeto, é inerente ao caráter e direção do próprio impulso e seus afetos correlativos.

Apesar desse entendimento, a realidade externa em nada diminui sua importância na estruturação psíquica do sujeito. Assim é que também Isaacs (1952/1986, p. 107) ressaltará:

Portanto, as primeiras fantasias promanam de impulsos físicos e estão interligadas com sensações e afetos físicos. Expressam primordialmente, uma realidade interna e subjetiva; contudo, desde o princípio, estão vinculadas com uma experiência concreta, mais ou menos limitada e estreita, da realidade objetiva.

Essa teorização é o que permite que se presuma a existência de fantasias lá desde o nascimento, pois, já ali, os instintos estariam em ação. A primeira fome, acompanhada pela vivência instintual que busca satisfazê-la, será seguida pelo fantasiar de um objeto capaz de dar resposta ao anseio aí gerado. Dessa forma, pode-se perceber a vinculação entre os conceitos de fantasia e de objeto interno.

Tomemos como exemplo o primeiro objeto interno do bebê, o seio alimentador. Ele pode adquirir tanto qualidades boas como qualidades más, de acordo com a faceta que vai se apresentando para a criança a cada momento. O *enfant* pode representar figurativamente a fome como presença concreta de um objeto que o frustra, sendo encarada como fruto da ação concreta de algo realmente existente dentro dele e vivenciada como uma figura persecutória. Nesse sentido, o seio será interpretado como bom, quando alimenta o bebê, ou como mau, quando não o satisfaz.

Esse também é um bom exemplo para pensar o conceito de objetos parciais. O bebê, de início, não teria a capacidade de perceber a mãe como um todo unificado. Apesar

disso, já seria capaz de estabelecer suas primeiras relações objetais. Mas, como seu ego primitivo ainda careceria de coordenação, essas relações seriam estabelecidas apenas com partes do corpo da mãe – que, no entanto, seriam vislumbradas pelo bebê como constituindo um todo. Essas partes do corpo constituiriam os denominados objetos parciais (seio, fezes, pênis...).

Trata-se de objetos precipuamente emocionais, o que implica que a percepção de sua existência material importa bem menos do que sua função enquanto objeto de satisfação. Por isso mesmo, suas características intrínsecas, como entidade exterior ao bebê, não é o que dá o tom à relação. O que entra em jogo é o modo como o bebê se direciona para ele, com suas necessidades instintuais e fantasias. O objeto parcial será vivenciado como um objeto que gratifica ou que frustra.

O objeto parcial não tem, portanto, características separadas e independentes do indivíduo que o sustenta. Por esse motivo, ele possui contornos muito mais narcísicos do que propriamente objetais. Apesar de sua natureza narcísica, o bebê comporta-se com ele como se estivesse em uma relação com um objeto separado e diferenciado de si. “De modo animístico, o bebê atribui-lhe sentimentos, qualidades e intenções que precisam ser sentidos como alheios ao seu *self*”. (COELHO JÚNIOR; SIGLER, 2009, p. 78)

E, dessa maneira, o bebê irá projetar sobre esse objeto parcial – que ele, inicialmente, encara como um todo constituído – suas fantasias inconscientes. De acordo com Simon (2009), a projeção do instinto de vida resulta na imagem de um objeto de gratificação, que ama e protege. Já a projeção do instinto de morte compõe a imagem de um objeto frustrador, que rejeita e ameaça. Essas imagens criadas são, posteriormente, introjetadas e servirão de material para a composição do mundo interno do bebê. Diversas projeções e introjeções se seguirão às primeiras, de forma que a estrutura do ego, do superego, assim como a estrutura de diversos objetos internos com quem essas instâncias se relacionarão, serão, assim, formadas.

Nesse início, no entanto, o que ocorre é que esses objetos parciais iniciais montam um cenário interno de elementos fantásticos que pode ser, ora imensamente generoso, ora extremamente cruel. O bebê experimentará, assim, nos seus primeiros meses, uma angústia persecutória (ou “paranóide”). Isso impulsionará o pequeno indivíduo a fazer uso de alguns mecanismos defensivos. O principal deles – a clivagem – permite que o bebê divida o objeto originário em objeto mau e objeto bom (“seio mau” e “seio bom”, por exemplo). Depois, fazendo uso da projeção e da idealização, o bebê expelle os objetos persecutórios (evitando, assim, ser por eles destruído) e idealiza os bons objetos (para que eles o protejam das ameaças de aniquilamento).

Com o desenvolvimento, no entanto, começa a imperar no bebê uma tendência à síntese. Ele começa a ser capaz de perceber o seio como um objeto total. Dessa maneira, os objetos bons e os objetos maus principiam um processo de integração que os comporá como objetos totais. Assim, progressivamente o bebê vai integrando seus objetos, e o mundo passa a ser habitado por pessoas complexas e cheias de contradições. O enfant passa a vivenciar a ambivalência (ama e odeia o mesmo objeto), já que, a partir daí, passa a conviver com as imagos de seu pai, de sua mãe e do casal parental de forma integrada.

Coelho Júnior e Sigler (2009) elucidam que o objeto total não possui mais uma natureza narcísica, pois não se define exclusivamente pelos sentimentos do bebê, contendo características próprias. O bebê pode experimentar, então, uma maior estabilidade nos seus sentimentos pelos objetos – sem vivenciar variações muito bruscas como nas fases anteriores. Despontam, também, a preocupação e o interesse pelos objetos.

É nessa fase que, levando-se em conta a característica de onipotência das fantasias, o bebê pode desenvolver a crença de que seu ódio é capaz de destruir os objetos amados. Essa é a origem do sentimento de culpa e de arrependimento, pois a criança acredita que pode ter causado um dano aos seres reais. Isso acarreta “um estado de luto pelo mundo destruído, interna e externamente, vivido com muita dor e remorso, muito semelhante ao do adulto quando perde um objeto amado” (SIMON, 2009, p. 29).

O amor e a culpa pelo prejuízo causado mobilizariam um mecanismo de reparação por meio do qual a criança abriria mão de sua destrutividade e iniciaria um movimento de restauração do objeto amado, processo de fundamental importância para o bom relacionamento humano e a evolução da cultura. Eros imperaria sobre Thanatos.

Conclui-se, portanto, que os objetos internos – ideia central do sistema kleiniano – integram o conjunto de fantasias que são a base do nosso mundo psíquico.

Esse mundo psíquico, como já foi dito, também recebe as influências das experiências concretas. Desde o nascimento, o indivíduo tem de lidar com as exigências reais, experimentando diversas situações de gratificação e frustração. Essas experiências vão tomando sua forma dentro do movimento incessante de trocas entre fantasias inconscientes e realidade. Um campo retroalimenta o outro, e ambos vão se constituindo em lentes por meio das quais o indivíduo enxergará e se relacionará com o mundo.

Assim, assistimos a uma inter-relação constante travada entre fantasia e realidade. A fantasia inconsciente influencia e altera a percepção e a interpretação da realidade. O inverso também ocorre: a realidade exerce seu afeito sobre a fantasia inconsciente e é vivida, incorporada e atua sobre a própria fantasia.

A compreensão desta inter-relação também está no fundamento das discussões sobre a importância do ambiente no desenvolvimento da criança. Não há como negar o papel que o ambiente exerce tanto no início da infância como em seus anos posteriores, mas é preciso também atentar para a função das fantasias e das ansiedades persecutórias – que existirá para além de o ambiente ser realmente bom ou mau. Como afirma Seggal (1973), a importância do fator ambiental só pode ser avaliada em relação ao que ele significa nos termos dos próprios instintos da criança. Ou seja, não há como fazer uma avaliação “pura” sobre a influência do ambiente sem levar em conta a atuação das forças instintuais operantes na criança.

Importante lembrar ainda que, nos primeiros processos mentais, a fantasia é representante psíquica dos instintos libidinais e destrutivos. Mas, no desenvolvimento mental da criança, a fantasia cedo se converterá também em uma defesa contra a ansiedade – um meio de inibir e controlar os impulsos instintivos – assim como será, além do mais, a expressão dos desejos reparadores. Isso porque as fantasias servem a vários propósitos, como por exemplo: negação, renovação da segurança, controle, onipotente... (ISAACS, 1952/1986).

Um exemplo é a capacidade que a criança tem de fantasiar que está tendo suas necessidades saciadas. Dessa maneira, ela se defende das privações (tanto externas como internas), evitando, assim, as sensações desencadeadas pela frustração.

Esse mecanismo é fundamental para que se entenda a função que a fantasia tem de adiar a descarga da libido – auxiliando, no entanto, na diminuição das tensões geradas pelos instintos, pela ansiedade e pela culpa (na medida em que é uma via de realização de desejo substitutiva). É nesse papel que ela se configura como ferramenta para a passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade. Logo, ela prepara o indivíduo para o desenvolvimento das funções mentais mais elevadas, como, por exemplo, o pensar.

As fantasias também podem ser usadas como defesa contra outras fantasias. Segal (1973) fornece como exemplo típico desse mecanismo as fantasias maníacas, cuja principal finalidade é repelir fantasias depressivas subjacentes.

E foi partindo da teorização de todas essas funções que a fantasia desempenhava na vida psíquica do ser humano que Melanie Klein pôde sustentar que o “nada”, que alguns acreditavam constituir a mente do bebê, não era um vazio. Já se encontrava preenchido por forças instintuais, que ameaçavam a integridade do pequeno indivíduo, gerando uma ansiedade de aniquilamento que o forçava a estabelecer intenso intercâmbio entre seu mundo interno e o mundo externo. Retomemos algumas das funções da fantasia.

- » Representante psíquico das forças instintuais;
- » Defesa contra as privações, a ansiedade e a culpa;
- » Base para a formação dos objetos internos, do Ego e do Superego;
- » Ferramenta que auxilia na passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade, permitindo o desenvolvimento de funções mentais mais elevadas.

Estabelecidos esses conceitos básicos, nos é possível partir para algumas inovações teóricas que Klein propôs a partir de sua clínica.

CAPÍTULO 2

A posição esquizoparanoide

Neste capítulo e no subsequente apresentar-se-á, respectivamente, os conceitos de posição esquizoparanoide e posição depressiva. Para isso, no entanto, faz-se precípuo elucidar, de saída, o que afinal significa posição na teoria Kleiniana.

Para Segal (1973), a posição esquizoparanóide e a posição depressiva podem ser consideradas momentos do desenvolvimento do psiquismo humano. Elas representariam subdivisões do estágio oral. Na posição esquizoparanoide, em funcionamento nos primeiros meses de vida do bebê, a criança não perceberia a totalidade de seus primeiros objetos (por exemplo, a “mãe” e o “pai”). As relações do bebê seriam, na verdade, travadas com objetos parciais (por exemplo, o seio), prevalecendo os processos de divisão e as ansiedades paranoides. Em seguida a esse momento, surgiria a posição depressiva, marcada pela percepção da mãe como objeto total. Nela, emergiria a integração dos objetos, assim como os sentimentos correlatos de ambivalência, ansiedade depressiva e culpa.

Mas por que usar, então, o termo “posição” ao invés de “estádio”? Porque Melanie Klein desejava demarcar a diferença entre essas duas concepções, na medida em que as posições seguem outro tipo de funcionamento. Elas não são, por exemplo, ultrapassadas cronologicamente pela criança, assim como aconteceria com os estágios ou as fases. Elas têm uma natureza estrutural. Representam determinados tipos de configurações assumidas pelas relações de objeto, ansiedades e defesas que o indivíduo levaria consigo por toda a vida, sendo fundamentais para entender o funcionamento psíquico humano.

Portanto, a posição depressiva nunca supera, de todo, a posição esquizoparanóide. Sempre há uma via de interação entre os mecanismos de ambas, e não será raro que, ao se defender das ansiedades próprias à posição depressiva, o indivíduo regride às manifestações esquizoparanoides, estando sempre a oscilar entre as duas posições. Não se tratam, dessa maneira, de fases que serão superadas, mas de mecanismos que o sujeito usa para interagir com o seu mundo interno e com o mundo externo.

Logo, é necessário compreender que “O conceito de ‘posição’ não entra em conflito com o conceito de ego, superego e id, mas tem como teor definir a estrutura real do superego e do ego, bem como o caráter de seus relacionamentos nos termos das posições esquizoparanoides e depressiva”. (SEGAL, 1973/1975, p12)

Definida, assim, a concepção de posição, podemos passar à descrição dos fenômenos que caracterizam a posição esquizoparanoide. Para tanto, acompanharemos de perto as elaborações de Klein sobre esse tema em seu texto de 1946, “Notas sobre Alguns Mecanismos Esquizóides”.

Klein principia seu escrito anunciando que tratará da importância dos mecanismos esquizoparanoides, sobre os quais teria refletido muito a partir de suas experiências clínicas. Estes diriam respeito às mais antigas ansiedades experimentadas pelo bebê, deixando antever o funcionamento arcaico do psiquismo humano.

Klein levanta a hipótese de que, no início da vida, o bebê se depararia com ansiedades primitivas que impulsionariam o ego a desenvolver mecanismos de defesa específicos. Esse movimento teria uma profunda influência sobre o desenvolvimento em todas as suas nuances, incluindo as que abarcam o ego, o superego e as relações objetais.

Esse ponto retomaria a defesa de Klein da ideia de que, desde o princípio da vida, já existiriam as relações objetais, e de que o primeiro objeto da criança seria o seio da mãe. Ela o dividiria em seio “bom” (gratificador) e seio “mau” (frustrador). Tal divisão resultaria numa separação nítida entre amor e ódio. A clivagem do objeto, assim como a utilização dos mecanismos de introjeção e projeção (que compõem diversas interações entre si) e as situações internas e externas moldelariam as relações objetais do pequeno indivíduo. “Esses processos participariam na formação do ego e superego, preparando o terreno para o estabelecimento do complexo de Édipo na segunda metade do primeiro ano de vida”. (KLEIN, 1952/1986, p.314)

Eis os processos psíquicos que ocorreriam no início da vida do bebê: quando o impulso de morte volta seu investimento contra o primeiro objeto – o seio materno – ele assume a forma de fantasias de ataques sado-orais, progredindo, posteriormente para agressões generalizadas ao corpo da mãe também pelos meios sado-anais e sado-uretrais. Nos impulsos sádico-orais, a criança fantasia despojar o corpo materno de todos os conteúdos bons, esvaziá-lo de suas riquezas (seus bebês, o pênis paterno que ali estaria guardado, etc). Já as fantasias sado-anais e sado-uretrais almejariam colocar dentro da mãe os excrementos da criança (e a própria criança desejaria penetrar no corpo materno, como forma de controlá-lo por dentro).

Figura 12. Cena do filme *Fale com ela*. Almodóvar, 2002.



Fonte: <<https://cinecafe.wordpress.com/2013/05/29/fale-com-ela-pedro-almodovar-2002/>>. Acesso em: 21/2/20147.

O sadismo da criança provoca, no entanto, o medo da retaliação pelo objeto que foi tomado como alvo. Essa seria a fonte do surgimento das ansiedades persecutórias. O *enfant* teme ser devorado, despedaçado, envenenado. Tais medos o levarão a fazer uso de diversos mecanismos de defesa (clivagem, negação, idealização, projeção, introjeção). Se os medos persecutórios forem muito fortes e o bebê não for capaz de construir a passagem da posição esquizoparanóide para a posição seguinte – a depressiva –, dando a esta última uma resolução, o fracasso de tal processo pode acarretar um reforço regressivo dos medos persecutórios e gerar pontos de fixação que serão a base para psicoses graves. Esses fatores também serão o fundamento para a escolha da neurose.

Destrinchemos mais minuciosamente os processos envolvidos no quadro até aqui descrito:

É preciso destacar, já desde o início, que Melanie Klein defenderá a ansiedade e suas vicissitudes como sendo o motor do processo de desenvolvimento humano. Tanto é que ela focará as ansiedades como elementos fundamentais de manejo de sua clínica. Assim é que o desencadear de uma ansiedade ao longo de um processo analítico pode ser sinal de evolução e não de retrocesso no quadro apresentado pelo paciente.

O ego primitivo, para Klein, careceria de coesão, alternando entre uma tendência para a integração e uma tendência para a desintegração (fragmentação em múltiplas parcelas). A maior ou menor coesão do ego no princípio do desenvolvimento estaria na dependência da capacidade deste para tolerar as ansiedades – o que seria determinado, segundo Klein, por um fator constitucional.

Fato é que esse ego primitivo, ainda que carente e coesão, já possuiria algumas funções próprias de um ego mais avançado. Entre elas, uma fundamental: dominar a ansiedade.

A ansiedade nasceria da ação do instinto de morte dentro do organismo. Ela seria sentida como um medo de aniquilamento do eu, que se tornaria medo de perseguição. Portanto, esse medo do impulso destrutivo toma a forma de medo de um incontável e prepotente objeto. Somar-se-ão a esta primeira fonte de ansiedade também a ansiedade de separação e as ansiedades referentes às experiências de frustração das necessidades corporais. Também elas serão ligadas à imagem de um objeto, como se por ele houvessem sido causadas. Esses objetos externos, por meio da introjeção, são tornados internos, reforçando o medo do impulso destrutivo.

Dentro desse quadro, o ego primitivo desenvolve defesas fundamentais para enfrentar a ansiedade que o assola. Parte do impulso destrutivo é projetado no exterior, vinculando-se ao primeiro objeto externo: o seio da mãe. Outra parte da pulsão, que permanece dentro do organismo, une-se à libido, atuando nos impulsos sádicos, e ainda

uma terceira parte, que não alcança seu propósito nos dois caminhos anteriormente citados, permanece no organismo e continua a gerar a ansiedade de ser destruído interiormente. Essa ansiedade gera no ego uma tendência à fragmentação.

Sendo assim, o ego primitivo, em seu intento de lidar com o impulso de morte, divide não apenas o objeto e as relações com ele estabelecidas, o ego também se divide, na busca de dispersar o impulso destrutivo. Esses mecanismos são extremamente importantes para entender os processos esquizofrênicos.

Quanto ao impulso destrutivo que foi projetado no exterior, ele é sentido, primeiramente, como uma agressão oral. Quando o bebê se vê diante de situações de frustração e ansiedade, seus desejos sado-orais se intensificam, e ele fantasia incorporar o mamilo e despedaçar o seio. Logo, à divisão entre seio mau e seio bom, soma-se a fantasia de um seio frustrador fragmentado. Já o seio gratificador, sob o domínio da libido, permanece completo. Seria esse seio completo, o primeiro objeto interno bom, que atuaria como um ponto focal, compensando os processos de divisão e dispersão, fomentando a coesão e a integração e servindo de instrumento para a formação do ego (KLEIN, 1952/1986).

Ainda assim as vivências de frustrações e ansiedades experimentadas pela criança também poderiam leva-la a experimentar o seio bom como fragmentado, o que viria a abalar a construção da coesão do ego. Sobre isso, Klein (1952/1986, p.319) completa:

Acredito que o ego é incapaz de dividir o objeto – interno e externo – sem que uma correspondente divisão ocorra dentro do próprio ego. Portanto, as fantasias e sentimentos sobre o estado do objeto interno influem vitalmente na estrutura do ego. Quanto mais sadismo prevalecer no processo de incorporação do objeto e quanto mais se sentir que o objeto está em pedaços, atento mais o ego estará em perigo de ser dividido em relação com os fragmentos do objeto internalizado.

Somados aos mecanismos de divisão (ou clivagem) há, no entanto, outras importantes defesas utilizadas pelo ego primitivo. A idealização é uma delas. Na idealização, os aspectos bons do seio são postos em evidência como forma de criar uma proteção contra o medo do seio perseguidor. Essa exacerbação da imagem do bom seio também atende aos desejos instintivos, que fantasiam uma gratificação ilimitada, a ser fornecida por este seio ideal, inexaurível e abundante.

A negação também é um tipo de defesa – que pode aparecer inclusive conjugada à clivagem e à idealização. Nela, o ego nega a existência do objeto persecutório, assim como toda a situação de frustração e os sentimentos dolorosos a ela associados. Há, portanto, a negação de uma realidade psíquica, realizada por meio de fortes sentimentos de

onipotência presentes no psiquismo primitivo. No entanto, ao realizar essa operação, o ego não está negando apenas o objeto mau e as situações de frustração a ele associadas. O que está sendo aniquilado é, inclusive, a situação objetal. A consequência disso é que parte do ego também é aniquilada e negada nesse processo.

Esses mecanismos de defesa ainda assim não impedem que o bebê direcione ao seio seus impulsos libidinais e agressivos. Como falamos anteriormente, os ataques ao seio materno acabam se convertendo em agressões ao corpo materno, que passa a ser visto como um prolongamento do seio. Em suas manifestações orais, essas fantasias de ataque configuram-se como um sugar, esvaziar, morder e roubar todo o bom conteúdo do corpo da mãe. Nas manifestações anais e uretrais, essas fantasias são as de evacuação de substâncias venenosas (que são expelidas com ódio para serem introduzidas o corpo materno), assim como de partes más do ego (que são projetadas para dentro da mãe). Esses ataques têm o intuito tanto de causar danos como de controlar e tomar posse do objeto.

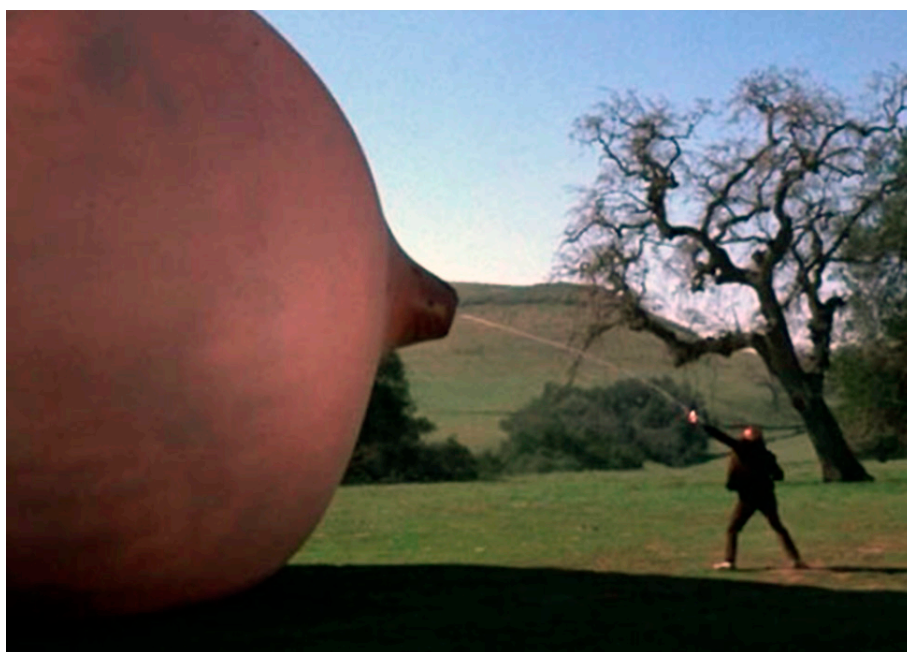
No entanto, ao projetar para a mãe as partes malquistas de seu ego, essas partes acabam por se identificar com o objeto que as recebeu. Assim, “Muito do ódio contra algumas partes do eu é agora dirigido para a mãe. Isso conduz a uma forma particular de identificação que estabelece o protótipo de uma relação objetal agressiva. Sugiro para esses processos a expressão ‘identificação projetiva’”. (KLEIN, 1952/1986, p. 322)

Em situações como essa, quando ocorre a identificação de um objeto com partes odiadas do ego, e quando os impulsos projetados teriam como objetivo causar danos ou controlar o objeto, este passa a assumir a feição de um objeto perseguidor, sendo fonte de ansiedade. Além disso, se a projeção para o mundo externo de partes do ego for excessiva, ele ficará enfraquecido, pois “o componente agressivo dos sentimentos e da personalidade está intimamente associado, na mente, com o poder, potência, força, conhecimento e muitas outras qualidades desejadas”. (KLEIN, 1952/1986, p. 322)

Em um processo semelhante, as partes boas do eu também serão expelidas para o objeto externo. Assim é que os excrementos passam a ter o sentido de ofertas, presentes entregues ao corpo da mãe, e os elementos bons e amorosos do eu são projetados para dentro de outras pessoas. Aqui também essas partes boas projetadas serão identificadas com os objetos que as receberam. Dessa maneira, a identificação que surge com base nesse tipo de projeção também influencia de forma fundamental as relações objetais. “A projeção de bons sentimentos e boas partes do eu na mãe é essencial para a capacidade infantil de desenvolver boas relações objetais e integrar seu ego” (KLEIN, 1952/1986, p. 323).

Porém, aqui também há o risco de a projeção das partes boas do ego para o mundo externo se tornar excessiva, gerando no bebê o sentimento de que as partes boas da sua personalidade se escoaram e foram perdidas. Isso geraria um empobrecimento do ego e uma super idealização do objeto, sendo a mãe convertida em ego ideal. Esse processo seria expandido para outros objetos, trazendo como consequência uma dependência excessiva com relação a esses representantes externos das partes boas do próprio ego. A própria capacidade de amor parece ficar comprometida nesse processo, devido a ser o objeto amado essa projeção demasiada do próprio eu.

Figura 13. Cena do filme Tudo que você sempre quis saber sobre sexo mas tinha medo de perguntar. Woody Allen, 1972.



Fonte: <<http://www.cinepipocacult.com.br/2014/02/tudo-o-que-voce-sempre-quis-saber-sobre.html>>. Acesso em: 21/2/2017.

Outro elemento complicador que pode surgir nessa equação é que, quando a idealização do objeto e a projeção das partes boas do ego se tornam demasiadas, isso intensificará a inveja primitiva.

A inveja seria uma das primeiras e mais fundamentais emoções experimentadas pelo ser humano. Ela se estabelece sempre em uma relação dual, na qual o sujeito inveja alguma posse ou qualidade do objeto. E é importante perceber que é experienciada essencialmente em termos de objetos parciais, mesmo que persista nas relações com objetos totais. Inicia como um desejo do sujeito de ser tão bom quanto o objeto, mas, quando isso é sentido como impossível, transforma-se em desejo de danificar a bondade do objeto, por meio da projeção de partes ruins. Assim, “em fantasia, ataca o seio, cuspiendo, urinando, defecando, soltando flatos, e pelo olhar projetivo e penetrante (o mau-olhado)”. (SEGAL, 1973/1975, p. 53).

É aí que a inveja se torna nociva ao desenvolvimento do ego, pois a própria fonte de bondade na qual o bebê poderia vir a se espelhar assume feições más, e, assim, ele não tem como introjetar as partes boas de volta ao seu ego. A clivagem entre um objeto idealizado e um objeto perseguidor característica da posição esquizoparanóide fica comprometida, pois que o objeto ideal, que serviria como base para a introjeção e constituição de um foco de coesão e fortalecimento do ego, foi danificado. Assim, o indivíduo vivencia situações de desespero, na medida em que não encontra um objeto ideal para se identificar, e, portanto, não vê esperança de amor ou de qualquer ajuda. Para tornar a situação mais difícil, os objetos destruídos passam a ser fonte de perseguição interminável e de culpa. Surge, então, “um círculo vicioso, no qual a inveja impede a introjeção boa; isso por sua vez aumenta a inveja” (SEGAL, 1973/1975).

Logo, podemos concluir que “O processo de destacar as partes do eu e projetá-las em objetos é, portanto, de importância vital para o desenvolvimento normal, assim como para as relações objetais anormais” (KLEIN, 1952/1986, p. 323).

E assim também se dá com relação à introjeção. Como há pouco descrevemos, a introjeção do bom objeto é uma pré-condição para o desenvolvimento normal, pois é a base de formação do ponto focal que propiciará a coesão do ego. A existência desse bom objeto é importante inclusive para os momentos em que a criança precisa lidar com as frustrações e as ansiedades, pois ela pode usar como recurso a evasão para seu objeto ideal. Aqui, mais uma vez, o excesso pode ser perigoso. Se o medo persecutório é muito forte e a fuga para o objeto idealizado se torna excessiva, isso dificultará as relações objetais e prejudicará o desenvolvimento do ego.

Assim, resume Melanie Klein (1952/1986, p. 325), a ação dos mecanismos de introjeção e projeção no desenvolvimento humano:

Quanto à personalidade normal, pode-se dizer que o curso do desenvolvimento do ego e das relações objetais depende do grau em que pode ser atingido um equilíbrio ótimo entre a introjeção e a projeção nos estágios iniciais do desenvolvimento. Isso, por seu turno, influi na integração do ego e na assimilação dos objetos internos. Mesmo que o equilíbrio seja perturbado e um ou outro desses processos seja excessivo, haverá sempre uma interação da introjeção e projeção.

Pode-se concluir, portanto, que, na posição esquizoparanóide, caracterizada pelas constantes permutas entre fases de integração e de desintegração do ego, o bebê experimenta ansiedades de aniquilamento, separação e frustração das necessidades que o levam a se utilizar do mecanismo de clivagem dos seus objetos primeiros e de seu próprio ego. Esse expediente, no entanto, somado a outras ações de defesa como a

introjeção, a projeção, a negação, a idealização e a identificação projetiva (que operam diversas combinações entre si) dão origem a uma ansiedade persecutória, que tanto pode gerar uma maior coesão do ego e uma integração dos objetos internos e externos (o que o conduziria à posição depressiva), como pode ser excessiva e desencadear uma série de fixações e distúrbios no processo de desenvolvimento psíquico.

Fato é que, pensar o mundo com o olhar de um bebê na posição esquizoparanóide é enxergá-lo como constituído por objetos bons, que ele tenta obter, e objetos maus, que ele tenta afastar. Organizando-se assim, espera-se que ele constitua confiança no objeto que repetidas vezes o gratifica, e com ele se identifique, sentindo-se mais capaz e mais forte para enfrentar os objetos persecutórios e frustradores – que, futuramente, perceberá que pertencem não somente ao mundo externo, mas que também integram o seu eu. Esta é a função estruturante e organizadora que conduz o bebê (e conduzirá o adulto) em seu enfrentamento das vivências emocionais difíceis e fragilizadoras.

Para compreender o que Klein descreve como posição esquizoparanóide, é necessário ser capaz de vislumbrar uma experiência na qual o conhecimento de si e do mundo ainda são muito precários, e em que ainda não é possível distinguir as emoções que são suas das que são do outro. Esse é o mundo do bebê (e de alguns adultos que se fixarão ou regredirão vez por outra a essa posição). Nas experiências de frustração, tudo é vivido como ameaçador e persecutório, e, nas experiências de gratificação, tudo é perfeito e idealizado.

Sobre a presença continuada da fase esquizoparanóide ao longo da vida, Souza (2009, p.55) coloca:

Essa linguagem técnica talvez dê a impressão de algo muito distante de nosso cotidiano, do mundo dos outros, dos loucos, e não uma experiência à qual estamos sujeitos com muita frequência. Mas o que Klein tenta descrever é algo de nosso dia a dia. Ela se refere àqueles momentos nos quais parecemos ficar cegos para o que sentimos e para quem é o outro e o que ele está sentindo. Tomados de emoções avassaladoras, somos ou dom-quixotes iludidos pela idealização ou tiranos convencidos da pertinência e da propriedade de nosso sadismo, diante da impossibilidade de aceitar que podemos ser frustrados. É possível superarmos essas vivências e aprender com elas ou passar a vida lutando contra inimigos imaginários.

Sigamos, então, o que emerge da posição esquizoparanóide: a posição depressiva.

CAPÍTULO 3

A posição depressiva

Segundo Segal (1973), a posição depressiva, para Melanie Klein representaria o momento do desenvolvimento no qual o bebê reconheceria um objeto total e estabeleceria, por essa via, novas formas de relação objetal. Acompanhemos então, como Klein descreverá a posição depressiva em dois importantes escritos: Uma Contribuição à Psicogênese dos Estados Maníacos Depressivo, de 1935, e Algumas Conclusões Teóricas sobre A Vida Emocional do Bebê, de 1952.

De acordo com a psicanalista, a partir do segundo trimestre do primeiro ano, o bebê começa a atravessar algumas transformações intelectuais e emocionais que o levam a uma modificação em sua relação com o mundo externo. Seus interesses se ampliam – e, conseqüentemente, também suas gratificações. Aumentam, ainda, suas capacidades de expressar emoções para os outros. Enfim, ocorre uma gradual integração e um gradual fortalecimento das funções do ego.

Nesse processo, a organização sexual da criança também vai se modificando, com uma intensificação das tendências uretrais, anais e genitais. Diferentes fontes de impulsos libidinais e agressivos passam a fazer maior presença na já agitada vida emocional do bebê, ampliando o campo das fantasias – que, agora, já assume feições mais elaboradas – e desencadeando novas situações de ansiedade. O correlato será um desenvolvimento também na natureza das defesas.

Na proporção em que o ego se torna mais organizado, vai ocorrendo uma aproximação entre os objetos internos e os objetos externos. Vimos que a repetição continuada de introjeções e projeções dos objetos auxiliam no desenrolar desse processo. E ele propiciará uma identificação mais completa do ego com os “bons” objetos, o que vai fazendo surgir um ego mais fortalecido, mais preparado para lidar com o medo dos “maus” objetos e com a ansiedade persecutória. É nesse contexto que o bebê vivenciará uma mudança fundamental em seu psiquismo. Relata Klein (1935/1996, p. 306):

Juntamente com esse desenvolvimento ocorre uma mudança da maior importância: a passagem de uma relação de objeto parcial para a relação com um objeto total. Ao dar esse passo, o ego atinge nova posição, que serve de base para a situação chamada de perda do objeto amado. Só quando o objeto é amado como um todo é que sua perda pode ser sentida como um todo.

Necessário ressaltar aqui que os mecanismos que fazem com que o objeto se torne total ocorrem simultaneamente àqueles que levam a uma cada vez maior integração do ego. Teremos, portanto, agora relações objetais que se travam entre um ego cada vez mais coeso e um objeto total. Essa é a marca precípua da posição depressiva. Ela tem implicações fundamentais na vida psíquica, porque, quando ao mesmo tempo em que o bebê reconhece sua mãe como objeto total, ele também percebe que é ela a fonte tanto de suas boas experiências como também das más. Da mesma forma, a integração de seu ego o leva a perceber que é ele quem direciona a mãe não apenas os sentimentos bons, mas também os destrutivos.

Importante ressaltar que esses desenvolvimentos se dão inicialmente com relação à mãe, pela transposição gradual da condição de seio para a de pessoa, objeto completo com quem o bebê se identificará. Nesse mesmo contínuo, no entanto, farão entrada o pai, o casal, e outras pessoas de relevância para o bebê.

É essa mudança, que estamos fazendo questão de bem demarcar, que operará uma transformação na faceta da ansiedade quando ocorre a entrada na posição depressiva, moldando, igualmente, novas configurações para os mecanismos de defesa. É como Klein (1952/1986, p. 230) esclarece:

Todos esses processos de integração e síntese fazem que o conflito entre amor e ódio atinja sua plena força. A consequente ansiedade depressiva e os sentimentos de culpa alteram-se não só em quantidade, mas também em qualidade. A ambivalência é agora experimentada, de modo predominante, em relação a um objeto completo. Amor e ódio estão muito mais unidos, e o seio “bom” e “mau”, a mãe “boa” e “má”, já não podem manter-se tão separados quanto no estágio anterior.

A ambivalência, portanto, será um forte vetor de ansiedade. O bebê percebe que, quando libera em suas fantasias seus impulsos sádicos e destrutivos, tem como alvo justamente o objeto que ama e que teme imensamente perder – o objeto de onde retira elementos para fortalecer o seu ego e enfrentar seus medos. Essa nova configuração também trará uma alteração nas interações entre introjeção e projeção. E de que forma?

Quando as condições de desenvolvimento são favoráveis, o bebê percebe cada vez mais robustez em seu objeto ideal e os impulsos libidinais, que ficarão aumentados, também o fortalece na queda de braço contra os impulsos agressivos e os maus objetos. Essa dinâmica favorece a que ele se identifique com o objeto ideal e se torne mais apto para se defender e para sentir que pode defender o objeto amado de seus próprios impulsos maus. Confiante em sua capacidade de lidar com os próprios sentimentos negativos, ele necessita cada vez menos fazer uso da projeção, pois sua tolerância ao instinto de morte

que atua dentro de si e, conseqüentemente, aos seus medos persecutórios aumenta. É um círculo de reforço que favorece a integração do bebê: "Quando diminui a projeção de impulsos maus, diminui também o poder atribuído ao objeto mau, ao passo que o ego se torna mais forte, já que está menos empobrecido pela projeção". (SEGAL, 1973/1975, p. 80)

Concomitantemente, na medida em que os anseios libidinais aumentam por decorrência de uma identificação mais completa com o objeto bom, a criança desenvolverá um amor e um desejo voraz por incorporar esse objeto, intensificando o mecanismo de introjeção. "Nesse estágio, mais do que nunca, o ego é impelido pelo amor e pela necessidade de introjetar o objeto". (KLEIN, 1935/1996, p. 306). Mas, além de possuí-lo, a criança também deseja protegê-lo, acreditando que, ao trazê-lo para dentro de si, o manterá a salvo de perigos. Essa intensificação da introjeção atuará como já mencionamos, na integração do ego.

Porém, a mesma dinâmica que favorece a integração do ego também está na origem das ansiedades depressivas. Isso porque o indivíduo passa a perceber o valor que o objeto possui para ele, havendo um significativo aumento da consideração que ele nutre pelo objeto. O indivíduo passa então a experimentar o medo da "perda do objeto amado", assim como se da conta também de sua dependência com relação a este objeto. A descoberta da ambivalência faz com que ele experimente intensos sentimentos de anseio, culpa e luto com relação tanto aos objetos internos como externos.

Teme, então, que seus próprios impulsos destrutivos danifiquem o objeto amado, assim como receia a ação dos objetos persecutórios internalizados sobre ele. O medo de que o objeto esteja passando por um perigo de aniquilamento ou já tenha sido aniquilado gera uma identificação ainda mais forte com o objeto danificado, e se encontra na base das tentativas que o ego fará para reparar o objeto de amor.

Além disso, o ego também fará uso das defesas maníacas. Novamente vemos surgir aqui os mesmos mecanismos que tomaram a cena na posição esquizoparanóide: a negação, a idealização, a clivagem, a identificação projetiva e a busca pelo controle dos objetos são mais uma vez usados pelo ego – só que, agora, de forma qualitativamente diferente. Eles buscam neutralizar as ansiedades depressivas e a culpa, e são muitíssimos mais organizados do que na fase anterior, em concordância com o estado de maior integração do ego.

As defesas maníacas tentarão, portanto, neutralizar as marcas da experiência depressiva. Voltam-se, por exemplo, para a dependência que o ego percebeu ter com relação ao objeto amado, contrapondo-se a esse sentimento, que será obviado, negado ou invertido. Há também tentativas de negar o amor pelo objeto, o que poderá resultar

em uma duradoura sufocação do amor, com um distanciamento dos objetos ideais e um retorno a ansiedade persecutória, pois restariam apenas os maus objetos.

A defesa maníaca que intenta o controle dos objetos deriva dos sentimentos de onipotência e é usada tanto para tentar conter a ação dos objetos internos malignos contra o objeto amado como para evitar as frustrações que podem advir inclusive desses objetos ideais. A clivagem, por sua vez, tem agora outro resultado. Ela divide o objeto completo em um objeto vivo e imune de riscos em detrimento de um objeto danificado e em perigo. Tenta, assim, preservar o objeto amado.

Segal (1973) e Nazio (1995) ressaltam, ainda, que mais duas formas de defesa próprias a posição depressiva: o triunfo e o desprezo. Ambas estariam ligadas com a percepção do valor do objeto amado, com o medo de perdê-lo e com a culpa por qualquer dano que pudesse ser a ele causado.

No triunfo, a fantasia é a de dominação do objeto, a de sua humilhação e tortura. Ora, essas tendências voltam-se contra os objetos persecutórios, ora contra os objetos idealizados. No caso desses últimos, propicia-se uma derrocada de seus aspectos louváveis, buscando com isso diminuir a dor causada por uma possível perda dos objetos amados – esse mecanismo está relacionado com a vivência da inveja).

No desprezo, o movimento é por uma desvalorização do objeto, por uma tentativa de diminuir a importância que ele possui para o indivíduo, desqualificando-o e o considerando desprezível ao ponto de não ser digno de despertar culpa.

Nazio (1995) cita também as defesas pela fuga. Trata-se de uma fuga para os bons objetos. Se ela se direcionar para os objetos internos, tem-se um distanciamento da realidade (psicoses, autismo). Se ela ocorrer no sentido dos objetos externos, tem-se os estados amorosos repetitivos nas neuroses. De uma forma ou de outra, o indivíduo evita lidar com as ansiedades desencadeadas pela perda do objeto amado.

Por fim, há ainda uma defesa maníaca importante de ser comentada. Ela precisa ser tratada com atenção porque se trata de um mecanismo que não obrigatoriamente se constituirá como defesa. Pode ser, ao contrário, uma das formas positivas de elaboração da posição depressiva. Estamos falando do processo de reparação.

Quando o bebê passa a perceber a mãe como objeto total, ele começa a experimentar também a intensa ansiedade de ter de lidar com o fato de que ela é uma pessoa diferenciada dele, e possui desejos e mobilidade próprios diversos dos seus. A mãe pode desaparecer por horas a fio e, depois, retornar, não exercendo o *enfant* nenhum controle sobre os destinos desse tão fundamental objeto. Isso causa uma miscelânea de sentimentos – raiva, tristeza, medo – que, agora, ele já reconhece como sendo seus.

Esse conjunto de sofrimentos advém da crença do bebê de que, quando a mãe some, ele pode tê-la perdido para sempre. Ela pode não mais voltar, pois pode ter sido danificada ou até mesmo morta – quem sabe em consequência dos sentimentos sádicos e agressivos que um dia o bebê lhe direcionou. Essas idéias não só desencadeiam ansiedades depressivas, como também geram no pequeno indivíduo fortes sentimentos de culpa.

No entanto, o bebê será exposto repetidas vezes a essas experiências de perda, assim como repetidas vezes experimentará a recuperação do objeto. O retorno da mãe, juntamente com o contínuo amor e cuidado recebidos do ambiente, faz com que ele vá gradativamente percebendo que os ataques sádicos e agressivos que realiza em suas fantasias não têm a onipotência para destruir os objetos amados na realidade. Dessa forma, vai ganhando mais confiança na força de seus impulsos amorosos e em sua capacidade de, após as manifestações de raiva e desagrado, restaurar seus objetos internos e mantê-los consigo nos momentos de ausência dos objetos externos. Seu ódio torna-se menos assustadores, e as ansiedades depressivas vão perdendo a força. Como bem ressalta Segal (1973/1975, p. 105)

Por meio da repetição de experiências de perda e recuperação, sentidas parcialmente como destruição pelo ódio e recriação pelo amor, o objeto bom se torna gradualmente mais bem assimilado no ego, pois, na medida em que o ego restaura e recria o objeto internamente, este se torna cada vez mais propriedade do ego, podendo ser assimilado por ele e contribuir para seu crescimento.

Mas nem sempre será esse o caminho assumido pelo processo de reparação. Tal mecanismo pode se desenrolar dentro de um contexto em que o bebê ainda esteja tomado pelo sentimento de onipotência e não encontre um ambiente que favoreça a aproximação de suas fantasias da realidade externa. Isso dificultará a adequação da realidade psíquica, interferindo no crescimento do ego e a adaptação deste à realidade. Nesse caso tem-se a reparação como uma defesa maníaca, usada para evitar qualquer contato com os sentimentos de perda e de culpa.

Uma das formas de realizar esse intento é, por exemplo, realizando uma substituição do objeto. Ao invés de buscar reparar o objeto de amor, os esforços de reparação são direcionados para objetos remotos, que tenham sofrido danos por causas igualmente remotas e impossíveis de serem relacionadas a ações ou sentimentos do indivíduo.

Há que ser também um objeto, em certa medida, desprezível. Inferior ao sujeito que se entrega ao ato de reparação – para que não haja o risco de que esse objeto substituto desperte justamente os sentimentos amorosos que se tentou evitar no objeto original. Tal artimanha faz com que a reparação maníaca nunca consiga realizar o intento de

restaurar, de fato, o objeto que escolhe. Porque isso faria dele um objeto de amor, o que levaria novamente à emergência do medo da perda deste objeto e à ansiedade que o acompanha e que tanto se tentou evitar por meio da reparação. Segal (1973/1975, p. 109) conclui:

Por causa dessas condições, a culpa subjacente que a reparação maníaca procura aliviar não é, na verdade, aliviada, e a reparação não traz satisfação durável. Os objetos que estão sendo reparados são tratados inconscientemente – e às vezes conscientemente – com ódio e desprezo, sendo invariavelmente sentidos como ingratos e, pelo menos inconscientemente, temidos como perseguidores potenciais.

O que pode se observar, portanto, é que a reparação que conduz à uma saída positiva da posição depressiva não tem como dispensar o reconhecimento de uma perda do objeto. Apenas o reconhecimento e a aceitação dessa perda é que permitem a elaboração da culpa por meio da recriação de um novo objeto interno. Isso nos leva a compreender porque a única superação verdadeira da posição depressiva se dá por meio do trabalho do luto. “É do resultado do trabalho de luto do objeto primordial que depende a saída da neurose infantil e da neurose transferencial”. (NAZIO, 1995, p. 163) Sobre isso, Nazio (1995, p.163) acrescenta ainda:

Para Melanie Klein, todo luto que ocorre posteriormente na vida reaviva a posição depressiva, isto é, tem um episódio confusional, ativado pelas angústias persecutórias e pelos sentimentos de ódio, desespero e saudade. A nostalgia, isto é, a memória do “bom” objeto, é o estímulo para o trabalho do luto. Somente o amor pelo objeto, e não o ódio garante o processo. Nesse estágio do luto, o sofrimento pode tornar-se produtivo, e não mais inibidor. A reconstrução do mundo interno caracteriza então o sucesso do trabalho do luto.

Conclui-se assim que a capacidade que a criança vai adquirindo para lidar com a ansiedade depressiva está diretamente relacionada com a forma como ela conseguiu incorporar e estabelecer o seu bom objeto, base para o núcleo do seu ego. Sendo esse processo bem sucedido, a criança superará a posição depressiva e estará pronta para enfrentar os desafios do complexo de Édipo, agora lidando com objetos completos e com os sentimentos ambivalentes que carrega em relação a eles. Contudo, se o ego não aprender a bem manejar as situações de ansiedade da posição depressiva, ele correrá o risco de regredir à posição esquizoparanóide, o que “impediria também os processos de introjeção do objeto completo e afetaria substancialmente o desenvolvimento não só durante o primeiro ano de vida, mas em toda a infância” (KLEIN, 1952/1986, p. 235) e também na vida adulta.

Encerramos aqui nossa exposição dos mais básicos e originais desenvolvimentos teóricos com os quais Melanie Klein prestou sua contribuição ao pensar psicanalítico. Sua obra influenciou de forma indelével a maneira de conceber o psiquismo infantil, assim como ampliou as possibilidades de sua técnica psicanalítica, ao criar a análise lúdica. Assim como na primeira parte deste guia de estudos, acreditamos ter feito um recorte dos conceitos kleinianos que constituirá um preâmbulo consistente para situar e incentivar àqueles que pretendam enveredar pelo pensamento de Klein – percurso que constitui uma das mais fascinantes buscas de compreensão da psique humana.

Conclusão

É hora de concluirmos nosso percurso. Desejamos fechar esta nossa caminhada ressaltando que a psicanálise é um saber vai além de uma ferramenta clínica. Seu lugar no campo *‘psí’* é marcado por essa constante busca do Inconsciente, compondo-se como um discurso que não visa a cura, no sentido médico do termo é que busca escapar dos usos que buscam objetivos adaptacionistas.

A psicanálise, no mundo em que vivemos - o mundo da pressa, da eficiência, das ideias avassaladoras de sucesso e de felicidade – continua a se apresentar como contracorrente de pensamento. Ela nos ajuda a deitar um olhar crítico sobre os fenômenos psicossociais e a compor espaços de resistência discursiva que permitem ao homem assumir seu mal-estar e elaborá-lo, dando-lhe palavras. Que esse seja apenas um início de percurso dentro desse campo desafiador.

Referências

BARROS, E. M. R. & BARROS, E. L. R. **Introdução**. In: Melanie Klein: evoluções. São Paulo: Ed. Escuta, 1989.

BARROS, E. M. R.; BARROS, E. L. R. **Um olhar para o inconsciente profundo**. In: PINTO, G. C. Coleção memória da psicanálise: Melanie Klein; volume 4. São Paulo: Duetto Editorial, 2009.

BREUR, J.; FREUD, S. (1893-1895). **Estudos sobre a histeria**. Rio de Janeiro: Imago, 1990. (Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, v.2).

COELHO JÚNIOR, N.; SIGLER, R. **A açogueira inspirada**. Em: PINTO, G. C. Coleção memória da psicanálise: Melanie Klein; volume 4. São Paulo: Duetto Editorial, 2009

FONSECA, V. R. **O autismo e a proposta psicanalítica**. In: PINTO, G. C. Coleção memória da psicanálise: Melanie Klein; volume 4. São Paulo: Duetto Editorial, 2009

FREUD, S. (1950[1892-1899]). **Extratos de documentos dirigidos a Fliess**. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990, v.1.

_____ (1900). **A interpretação dos sonhos**. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990. v. 4 e 5.

_____ (1912). **A dinâmica da transferência**. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

_____ (1912). **Recomendações aos médicos que praticam a psicanálise**. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

_____ (1913). **O início do tratamento**. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

_____ (1914). **A história do movimento psicanalítico**. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

_____ (1912). **Os Instintos e suas vicissitudes**. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

_____ (1912). **Repressão**. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

_____ (1912). **O inconsciente**. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

_____ (1925b [1924]). **Um estudo autobiográfico**. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990. v.20.

GARCIA-ROZA, A. L. **Freud e o Inconsciente**. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2009.

HANNS, L. **Dicionário comentado do alemão de Freud**. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

KLEIN, M. (1923). **A análise de crianças pequenas**. In: Amor, culpa e reparação e outros trabalhos (1921 – 1945.) Rio de Janeiro: Imago, 1996.

_____ (1926). **Princípios psicológicos da análise de crianças pequenas**. In: Amor, culpa e reparação e outros trabalhos (1921 – 1945.) Rio de Janeiro: Imago, 1996.

_____ (1932) **Psicanálise da criança**: São Paulo: Mestre Jou, 1981.

_____ (1935). **Uma contribuição à psicogênese dos estados maníacos-depressivos**. Em: Amor, culpa e reparação e outros trabalhos (1921 – 1945.) Rio de Janeiro: Imago, 1996.

_____ (1943). **Transferência**. In: Os progressos da psicanálise. Rio de Janeiro, Guanabara, 1986.

_____ (1952). **Algumas conclusões teóricas sobre a vida emocional do bebê**. In: Os progressos da psicanálise. Rio de Janeiro, Guanabara, 1986.

_____ (1952). **Notas sobre alguns mecanismos esquizoides**. In: Os progressos da psicanálise. Rio de Janeiro, Guanabara, 1986.

LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. **Vocabulário de psicanálise**. São Paulo: Martins Fontes, 1983.

MELLO, M.C.A. **A técnica e a linguagem do brincar**. In: PINTO, G. C. Coleção memória da psicanálise: Melanie Klein; volume 4. São Paulo: Duetto Editorial, 2009.

MEZAN, R. **Freud e a psicanálise**: um trabalho de civilização. In: ALMEIDA, J e BADER, W (Orgs). Pensamento alemão do século XX. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

MONTAGNA, P. **O eu e o mundo**. Em: PINTO, G. C. Coleção memória da psicanálise: Melanie Klein; volume 4. São Paulo: Duetto Editorial, 2009.

PETOT, J. **Melanie Klein I**: primeiras descobertas e primeiros sistemas, 1919-1932. São Paulo, Perspectiva 2008.

PINTO, G. C. **Coleção memória da psicanálise**: Melanie Klein; volume 4. São Paulo: Duetto Editorial, 2009.

SEGAL, H (1973). **Introdução à obra de Melanie Klein**. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

SIMON, R. **Admirável mundo ambivalente**. Em: PINTO, G. C. Coleção memória da psicanálise: Melanie Klein; volume 4. São Paulo: Duetto Editorial, 2009.

SOUZA, A. S. **Dois vértices emocionais**. Em: PINTO, G. C. Coleção memória da psicanálise: Melanie Klein; volume 4. São Paulo: Duetto Editorial, 2009.

TANNIS, B. **O reino imaginário**. In: PINTO, G. C. Coleção memória da psicanálise: Melanie Klein; volume 4. São Paulo: Duetto Editorial, 2009.